



COMPENDIO DE TRABAJOS

Comisión Epistémica:

Agustina Cedolini (Foro Argentino, Polo Salta),
Maria Celia Delgado de Carvalho (Foro San Pablo - Brasil),
Gioconda Espina (Foro de Venezuela),
María Victoria García Cingolani (Foro de Puerto Rico),
Maria de los Angeles Gómez (Foro de Puerto Rico),
Carla Novaes Carvalho (Rede Diagonal - Brasil),
Elisabeth da Rocha Miranda (Foro Río de Janeiro - Brasil),
Barbara Shuman (Foro Analítico de Colorado - EEUU),
Carolina Zaffore (Foro Argentino - Polo Buenos Aires)

El analista y el Clínico

Gabriel Lombardi y Carolina Zaffore

Lacan consideraba indispensable que el analista sea al menos dos, el que causa el trabajo analizante y el que teoriza sus efectos (*R.S.I.*, 10 diciembre 1974). Cada una de esas posiciones controla los extravíos de la otra, realiza su contra-rol. Ocasión de revisar la interacción entre ambas en cada una de las prácticas actuales del analista.

A partir de los debates sostenidos durante y luego del Simposio de San Juan de Puerto Rico, diversos temas se propusieron. Al título finalmente elegido *El analista y el clínico*, se enlazan diversos subtemas posibles, entre los cuales:

1. Acto analítico, experiencia del análisis y elaboración clínica.
2. ¿Qué es un caso clínico en psicoanálisis? Usos y funciones.
3. Del conocimiento del síntoma a la lógica del caso. La diagnosis en la entrada, durante y al término del análisis.
4. Vigencia de los historiales freudianos. Las presentaciones de enfermo de Lacan.
5. “Casos de urgencia”. La introducción del tiempo en el análisis.
6. Cuando el analista viene al caso. ¿Supervisión, control, contra-rol?
7. Pase y clínica. Articulaciones e incompatibilidades. Testimonio directo e indirecto en la transmisión del psicoanálisis.
8. “El inconsciente del analista”. Libertad interpretativa, destitución subjetiva, entusiasmo causal y responsabilidad.
9. Políticas del síntoma y de la transmisión en psicoanálisis. *Algunas referencias iniciales*

Lacan sitúa la acción del analista a partir de su concepción del pase, el analista se autoriza por sí mismo, desde una posición de destitución subjetiva que “...no detendrá al inocente, que no tiene otra ley que su deseo” *Proposición 9 octubre 1967 para el psicoanalista de la Escuela*. Nueve años después, en su *Apertura de la Sección Clínica*, propone compensar esa eficacia ciega (marcada por su *Verleugnung*, el desconocimiento estructural del acto) poniendo al “inocente” en el banquillo: la clínica psicoanalítica consiste en interrogar al analista, urgirlo a declarar sus razones sobre los efectos de su intervención, sobre su lectura de Freud y sobre lo que su práctica implica de azaroso y arriesgado *{hasardeux}*.

A su vez, en un movimiento de feedback, el *analista causa* compensa los excesos del *clínico*, inclinado desde siempre a objetivar desde afuera los signos del padecer. “Llamamos síntoma lo que el sujeto sitúa como tal”, ha dicho Colette Soler en *La querella de los diagnósticos*.

Entre los problemas cruciales para el psicoanálisis, Lacan señaló que “...si el clínico no sabe que una mitad del síntoma está a su cargo, su mitad de saber, y que sin esta segunda persona el síntoma

no termina de constituirse, estará condenado a dejar caer la clínica en la vía psiquiátrica, de la que la doctrina freudiana debería haberlo rescatado”. (*Problemas cruciales*, clase 5 mayo 1965).

Entre causa e interrogación clínica, tal vez pueda situarse mejor la posición oscilante que conviene al analista, entre *Verleugnung* del acto analítico y horror de saber. Problema crucial del psicoanálisis, situado así en la reseña de ese seminario: “Que el ser-de-saber deba reducirse a no ser más que el complemento del síntoma, es lo que causa horror al analista; si eso se elide, el estatuto del psicoanálisis como científico se estanca indefinidamente...”.

El déficit de esa articulación puede advertirse también en nuestra Escuela, y acaso más nítidamente que nunca. Incluso en las experiencias y testimonios de pase “exitoso”, con nominación de AE, suele ser escasa la articulación entre acto y clínica, y suele confundirse uno con la otra. Escuchamos regularmente historias de análisis y de su *exit* desde la narración de un analista en potencia, sin referencias a un partenaire con quien se autorizó como analista; además de que se lo hace también en público como testimonio directo, siendo que la propuesta fundamental de Lacan era la del *testimonio indirecto* a través de los pasadores.

Los otros arreglos clínicos usuales en nuestra comunidad también merecen ser revisitados desde esta doble perspectiva. *La elaboración de un caso*, ya desde Freud, no podría ser positivista (analista sujeto cognoscente - paciente objeto conocido), mucho menos tecno- empirista (información sin sujeto). Freud no publicó la transcripción de sus registros originales, sino historiales dialógicos en los que él está concernido en los efectos de su intervención, estilizando el monólogo del analizante.

¿Es la *supervisión* que se practica actualmente la que concebía Lacan, o sea el caso de un analista que se ve superado por su acto, el cual es a menudo más eficaz de lo que advierte? (Lacan, *Discurso en la EFP del 6 diciembre 1967*).

¿Podemos advertir que *transferencia* es el pivote de un alternancia, un ballet entre sujeto y objeto, sostenida entre los dos cuerpos con los que el vínculo analítico se organiza? (Proposición 9 octubre 1967). La posición del analista no es fija, ni siquiera dinámica, sino enérgica, en acto, alternante entre esas dos perspectivas.

El *discurso analítico* se realiza en el cambio de discurso y no en la estabilización del analista- causa (Seminario *Encore*, 19 diciembre 1972).

También *la práctica de la presentación de enfermo*, si involucra al analista, no es mera mostración, sino “...diálogo entre dos personas, sin el cual el síntoma no termina de constituirse como tal” (*Problemas cruciales*, 5 mayo 1965).

La propuesta es repensar la clínica freudiana tal como Lacan la presentó en 1975: *Es lo real en tanto que imposible de soportar. El inconsciente es la huella y el camino por el saber que constituye, haciéndose un deber repudiar todo lo que implica la idea de conocimiento*. Reservando este término para el caso del síntoma, conocimiento del sujeto que lo padece y lo activa sin reconocerse él. La *Spaltung* del sujeto entre conocimiento y reconocimiento es el nombre freudiano del sujeto.

Caso y síntoma son, desde esta doble perspectiva, indisociables. La historia de esos términos lo indica: el *síntoma* es el *caso* particular de división del sujeto que *acaece* en coincidencia con la singularidad que lo *causa*.

Este Simposio puede ser también ocasión de valorar la apuesta que representa para el analista de hoy en día la transformación del saber incardinado localmente en información digitalizada, con el consecuente efecto de camuflaje de los tipos clínicos freudianos de síntoma. La consulta llega hoy desde el extravío en la inmensidad de las redes “sociales”, donde las injurias del bullying se revierten en insignias de dignidad y viceversa, y donde las identificaciones se intercambian con emblemas de identidad. Cuesta ahora reconocer los tipos más elementales de síntoma real o división subjetiva, esa que se escribe en el cuerpo sin otra tinta que la que deposita el significante como letra o sustancia gozante.

¿Cómo volver hoy, casi medio siglo después, al último Lacan, el de la Sección Clínica y el Seminario *Disolución*, intentando restituir el decir de Freud en el psicoanálisis, en la praxis de la teoría, en la clínica, en la enseñanza?

Programa VI Simposio Interamericano: “El analista y el clínico”

Sala Picasso, Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660)

Buenos Aires, Argentina

Sábado 5 de Julio de 2025

8:00 hs. Acreditaciones

9:00 hs. Palabras de apertura a cargo de Carolina Zaffore

Mesa 1 - 09:15 a 10:45 hs - El analista y el clínico

Coordinadora: **Carolina Zaffore**

Relator: **Gabriel Lombardi**

Luján Iuale (FA-BA) Las afectaciones del analista. Horror y sorpresa.

Felipe Galeano (FCL-Medellín-Pereira) Del analista causa al analista clínico.

Sebastián Fernandez Moores (FA-BA) La ficción del caso.

Jorge Chapuis (FA-BA) Agotando la significación.

Gabriela Moreira (Foro California) Consideraciones de la división subjetiva del analista. Deseo, discurso y síntoma.

Mesa 2 - 11:00 a 12:30 hs - Transferencia y Acto Analítico

Coordinadora: **Barbara Shuman**

Relator: **Marcelo Mazzuca**

Oscar Quiroga (FA-BA) ¿Qué dimensión se pone en juego en el acto analítico?

Santiago Thompson (FA-BA) ¿Qué entendemos por principio de abstinencia?

Vanina Muraro (FA-BA) Interpretación y caída libre.

Gabriela Zorzutti (Foro Colorado) La voz media y el *Wunsch freudiano*.

Daniela Ferri (FA -Patagonia) Poner el acto en posición de agente.

12:30 - 14:00 Receso de almuerzo

Mesa 3 - 14:00 a 15:30 hs - ¿Qué es un caso clínico?

Coordinadora: **Nathaly Ponce**

Relator:

Alejandro

Rostagnotto

María Laura Cury Silvestre (EPFCL- FCL São Paulo) Viñetas clínicas: ¿qué es posible transmitir?

Martín Alomo (FA-BA) El deseo de analista en la presentación de enfermos.

Daniele Salfatis (EPFCL- FCL São Paulo) Enigma, enigma, enigma: del Complejo de Edipo al deseo

Silvana Castro Tolosa (FA-BA) El caso clínico: un tipo textual psicoanalítico.

Tomás Otero (FA-BA) El problema del síntoma y de la estructura en la clínica de la perversión.

Mesa 4 - 15:45 a 17:00 hs - Presentación de casos A

Coordinadora: **Elisabeth Da Rocha Miranda**

Relatora: **Julieta De Battista**

Ana Díaz Patrón (FA-Salta) La clínica que interroga al quehacer del analista.

Rosana Maldonado Torres (EPFCL- FCL Río) El pasado me condena.

Viviana Venosa (EPFCL-FCL São Paulo) ¿Cómo leer la letra?

Julia Minaudo (FA-BA) El caso, un problema “de ...dos”

Soledad Carro (FA-Patagonia) El pasador... ¿un analista?

Domingo 6 de julio de 2025

Mesa 5 - 09:00 a 10:30 hs - Presentación de casos B

Coordinadora: **Beatriz Oliveira**

Relator: **Guillermo Agüero**

Maria Helena Martinho (EPFCL- FCL Rio) Un caso clínico: transferencia, fantasía y acto.

Liora Stavchansky (Foro México) La calle: entre el juego y lo real de la violencia

Rossane Melo (EPFCL- FCL Rio) Los “diagnosticismos” y sus efectos en la clínica con niños.

Walter García (FA-BA) La interpretación como caja de resonancia

Mesa 6 - 10:45 a 12:00 hs -Supervisión y control

Coordinador: **Mario Brito**

Relatora: **Florencia Farías**

Leonardo Leibson (FA-BA) Los dos cuerpos del analista.

Luis Prieto (FA-BUE) El caso, la causa y el acto en la clínica analítica.

A. Noguera y A. Bruschi (FA-BA) Efectos en la práctica del espacio de supervisión.

Katarina Vidal Aragão (EPFCL- FCL Aracaju) La formación del analista y las consecuencias en la transmisión.

Juan Manuel Moraña (FA-BA) El pase, el control y la transmisión de casos clínicos: un trípode para interrogar los problemas cruciales del psicoanálisis.

Mesa 7- 13:30 a 15:15 hs - El pase

Coordinadora: **María Celia Delgado de Carvalho**

Relatora: **Sandra Berta**

Luciana Guarreschi (EPFCL- FCL São Paulo) Índices de pase clínico.

Matías Buttini (FA- BA) El analista y el clínico designados en un pasador.

Pedro Moacyr C. Brandão Junior (EPFCL- FCL Região Serrana) Notas sobre lo intransmisible y la reinención del psicoanálisis. Qué de los pasadores.

Dyhalma Ávila (Foro Puerto Rico). ¿“Sin tomar en cuenta procedencias ni calificaciones”?

La enrevesada pregunta por la designación del pasador.

Andrea Fernández (EPFCL- FCL Salvador) Psicoanálisis y pase: ¿qué hay de nuevo?
Fernando Martínez (FA-Patagonia) El momento de designación

Mesa 8 - 15:30-17:00 hs - Mesa plenaria de relatores
Coordinadora: **Agustina Cedolini**

Relatores: **Gabriel Lombardi, Julieta de Battista, Sandra Berta, Alejandro Rostagnotto, Florencia Farías, Marcelo Mazzuca, Guillermo Agüero**

**LA PRESENTE COMPILACIÓN NO TIENE
CARÁCTER DE PUBLICACIÓN EDITADA.
RECOGE LAS PONENCIAS DE LOS PARTICIPANTES
EN EL SIMPOSIO, EN EL ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.
TODO EL CONTENIDO, LA FORMA
Y LA TRADUCCIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.**

Comisión Epistémica

MESA 1 - EL ANALISTA Y EL CLÍNICO

Luján Iuale (FA-BA)

Las afectaciones del analista. Horror y sorpresa.

Felipe Galeano (FCL-Medellín-Pereira)

Del analista causa al analista clínico.

Sebastián Fernandez Moores (FA-BA)

La ficción del caso.

Jorge Chapuis (FA-BA)

Agotando la significación.

Gabriela Moreira (Foro California)

Consideraciones de la división subjetiva del analista. Deseo, discurso y síntoma

Las afectaciones del analista. Horror y sorpresa: consecuencias del acto analítico

Luján Iuale

Analista Practicante. Miembro del Foro Argentino-Polo Bs. As. Enseñante del C.C. Dra. En Psicología-Docente e investigadora UBA. Autora de Versiones del goce del Otro (2019) Escabel, entre otros. Supervisora Clínica.

El callejón sin salida de las teorías de la contratransferencia dejó un impasse respecto a una serie de preguntas ineludibles: ¿de qué hablamos cuando decimos “afectaciones del analista”? ¿Qué implicancias tienen dichas afectaciones en la cura? Y ¿qué hacemos con ellas para no caer en el derrotero de la mera intersubjetividad?

Hace unos años atrás -en un *cartel* compartido con Silvana Castro Tolosa, Leonardo Leibson y Julieta De Battista- nos ocupamos del cuerpo del analista. Como efecto de ese cartel propuse discernir dos modos de entender el cuerpo: por un lado – el cuerpo que recibe el embate de la transferencia, aquel que acusa recibo del residuo transferencial. Recordemos que Lacan, en el *Seminario 8*, afirma que la contratransferencia no es un concepto, sino que es un efecto genuino, un residuo de la transferencia. Por otro lado, hice referencia al cuerpo que hace soporte a la transferencia y que es signo del deseo del analista- dimensión que pone en escena al objeto *a*-objeto sin el cual la causa no podría ponerse en forma. Dos afectaciones diversas: una, correlativa al escollo mismo de la transferencia y, la otra, propia del deseo del analista. En esta oportunidad, me interesa poner el acento en la afectación de la analista correlativa al acto analítico.

En el *Seminario 15*, Lacan propone dedicar un tiempo a “la *connerie*” para aproximarnos a esta “extraña pareja” que forma el acto analítico (Lacan, 1967-68, p. 5) Dicho acto, atañe a los analistas, sobre todo a quienes no hacen de él una profesión. Por eso, nos encontraremos con una tensión entre aquello que del acto podrá transmitirse y lo que no; motivo por el cual entre el analista y el clínico hay un hiato insalvable, puesto que solo una parte de la experiencia podrá ser transmisible.

Lacan se pregunta a qué llamamos acto analítico: “¿Es acaso la interpretación? ¿Es a la transferencia hacia lo que así somos llevados? ¿Cuál es la esencia de lo que, del psicoanalista en tanto que operante es acto? ¿Cuál es su parte en juego? (...) ¿Qué es para un psicoanalista un

acto?” (1967-68, p. 20). Y agrega que “es indispensable captar la verdadera dimensión de la boludez como siendo eso con lo que tiene que vérselas el acto psicoanalítico.” (1967-68, p. 26) El tropiezo, el acto fallido, el equívoco, articulan la dimensión del *serhablante* que está en juego, el cual trae aparejado el estatuto de la verdad, verdad que surge de la equivocación, en la medida en que el significante lo permite.

Por otro lado, destacará que no hay acto analítico por fuera del manejo de la transferencia (Lacan, 1967-68, p. 32) e incluye aquello que del acto permanece elidido. Nos hablará de lo insoportable del acto, puesto que todo acto conlleva algo de ese orden, pero se apresura a aclarar que no está hablando de insoportable en términos subjetivos, sino “en alguna de sus consecuencias.” (p. 33) Concluye la clase del 29/11/67 afirmando que, la posición del analista se determina por un acto. Interpretación y transferencia -dirá- “están implicados en el acto por el que el analista da a ese hacer soporte y autorización. Está hecho para eso.” (1967-68, p. 43) Por eso, el acto analítico aparenta hacerse cargo de la verdad. Esa verdad del sujeto se articulará al objeto *a*, dado que la posición misma del analista estará hecha de ese objeto. Objeto que además cobrará la forma- el semblante- del *partenaire* del sujeto. La función de señuelo que tiene este objeto *a* es lo que funda la transferencia y, en la medida en que con oferta generamos demanda, Lacan no dudará en afirmar -años más tarde- que la única transferencia es del analista porque hace de soporte al discurso analítico. (Lacan, 1977)

Hay psicoanalista si hay acto analítico. Lacan insiste en las consecuencias de ese acto que es, por su propia dimensión, un decir (Lacan, 1967- 1968, p. 61). Implica localizar una enunciación sin sujeto, puesto que el analista no está allí más que como semblante de objeto. Paradoja del acto analítico que le da su peculiaridad. El acto analítico es lo que permite reducir el Sujeto supuesto Saber al objeto *a*. (1967-68, p. 80) Finalmente Lacan afirmará- ya en el final de su enseñanza- que “el psicoanalista tiene "horror" de su acto. Hasta el punto de que lo niega, lo deniega y lo reniega – y maldice al que se lo recuerda.” (Lacan 1980) El analista queda preocupado por las consecuencias de su acto, por la potencia que el acto conlleva y, por qué no, por el riesgo que introduce. Perturbar la defensa no es un slogan, es una operación que tiene efectos, puesto que conmueve las respuestas con las que el sujeto se ha mantenido sufriente, pero a resguardo del encuentro con lo real. Por eso, el fin de análisis implica haber podido cernir la causa del propio horror, y conlleva una mutación respecto al saber.

Lo interesante es que, a este horror correlativo del acto, muchas veces sobreviene la sorpresa. Son varias las referencias que Lacan hace a este tema. Me limitaré a traer solo algunas de ellas. Tanto en el *Seminario 11* (1964) como en el *Seminario 12* (1964-65), introduce la sorpresa de la mano de Theodor Reik, quien tiene un libro titulado *El psicólogo sorprendido* -escrito en 1938- dónde se destaca este tiempo inaugural del psicoanálisis como campo de investigación y de descubrimiento. En ese tiempo la sorpresa advenía sin demasiada dificultad. Lacan opone ese tiempo inaugural, a lo que acontece en el contexto de su época, en el cual habría poco lugar para la sorpresa. No duda en darle todo su valor a esta afectación en particular. Citando a Reik señala que la sorpresa es eso por lo que el sujeto se siente rebasado, donde siempre encuentra algo más o menos de lo que esperaba, pero aclara que lo que encuentra es invaluable (Lacan, 1964, p.33); y acentúa que la sorpresa se presenta cada vez que hemos apresado algo del inconsciente. En la clase del 6/1/65 dice:

En tiempos de Theodor Reik, ese autor pudo ver a la sorpresa (Überraschung) como la señal, la iluminación, el brillo que, en el analista designa que él aprehende el inconsciente, que algo viene a revelarse que es de ese orden de la experiencia subjetiva, de aquello que ocurre repentinamente y por otra parte, sin saber cómo ha hecho del otro lado del decorado. Eso es el Überraschung Es sobre este sendero, sobre esta traza, que él sabe todo, o al menos que está en su propio camino. (Lacan, 1964-65)

La sorpresa adviene cuando el analista advierte que ha aprehendido algo del inconsciente y que, al mismo tiempo, algo se le escapó, puesto que no sabe cómo ha hecho del otro lado del decorado. Esto nos lleva a enlazar sorpresa y acto. Por supuesto que, a la hora de dar sus razones, el analista podrá reconstruir su intervención, aunque no podrá nunca explicar del todo por qué intervino de tal o cual manera. Otra vez aquí, la hiancia entre el analista y el clínico se pondrá en juego, hiancia que no nos habilita a renunciar al esfuerzo de formalización que toda transmisión requiere para no quedar reducida a una práctica esotérica, un mero empirismo sin soporte teórico, o una especulación sin fundamento clínico.

Referencias

- Iuale, L. (2018) La operación analítica en la subjetivación del cuerpo. En Iuale, L. (Comp. Y autora) (2018) *Cuerpos afectados. Del trauma de la lengua a las respuestas subjetivas*. Buenos Aires: JCE.
- Iuale, L. (2023) El cuerpo (del) analista entre dos afectaciones. Transferencia y deseo del analista. Iuale, L. (Comp. Y autora) *Cuerpo delator. Escenarios clínicos entre afectos y goces*. Buenos Aires: Cascada de letras.
- Lacan, J. (2004) *El Seminario 8. La transferencia* [1960-61] Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. (2001) *El Seminario 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*. [1964] Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. (1964-65) *El Seminario 12. Problemas cruciales del psicoanálisis*. Inédito.
- Lacan, J. (1966-67) *El Seminario 14. La lógica del fantasma*. Inédito.
- Lacan, J. (1967-68) *El Seminario 15. El acto analítico*. Inédito.
- Reik, T. (2018) *El psicólogo sorprendido. De adivinar y comprender procesos inconscientes*. México: Epee

“¿Del analista causa al analista clínico?”

Felipe Galeano Arias

AP EPFCL. Foro Medellín, Foro Pereira. Psicólogo. Especialista en Psicopatología y Estructuras Clínicas. Magíster en Estudios del Comportamiento

En todo caso, el deseo del analista no puede dejarse fuera de nuestra pregunta, por una razón muy sencilla: el problema de la formación del analista lo postula. Y el análisis didáctico no puede servir para otra cosa como no sea llevarlo a ese punto que en mi álgebra designo como el deseo del analista^[1].

¿Hay acaso una diferencia entre lo que podemos pensar del analista y lo que puede decirse sobre el clínico?^[2] ¿Es posible separarlos? Lacan, a lo largo de su enseñanza, insistió en que se es analista *situándose en-acto*^[3]. El análisis, indudablemente no es sin analista, él está convocado, con *su decir* en la interpretación^[4], a la vez que, debe ubicarse, en el dispositivo, en un lugar particular, ¿Qué decir del analista y del clínico como efecto de un análisis? Me propongo abordar específicamente que el analista, indudablemente clínico, lo es siendo causa. La pregunta es, ¿qué es lo que significa ubicarse en el discurso analítico en el lugar de la causa? Lo que tiene implicaciones en el psicoanálisis tanto en intención como en extensión, tampoco ellos se pueden separar.

1 Lacan, J. los cuatro conceptos fundamentales para el psicoanálisis. Seminario 11. Clase del 15 de enero de 1964.

2 En el Seminario de “De un Otro al otro”, Lacan plantea que: “Bastaría sin embargo percibir que este punto de la anamnesis que se considera original y orientador, en verdad se produjo retroactivamente por la suma de las interpretaciones del psicoanalista, no solo de las que se hace en su cabeza, como suele decirse, o cuando escribe su observación, sino también de esas en las que intervino en lo que lo liga al paciente, lazo que en el registro en que se inscribe, de interrogación y de suspensión de lo que concierne al sujeto, está lejos de poder describirse pura y simplemente como una relación de potencia, aun cuando esté sometido a toda transferencia que pueda imaginarse. Ven entonces claramente por qué cuando en el psicoanálisis se trata del sujeto siempre es esencial retomar el problema de la estructura. El hecho de retomarla constituye el verdadero progreso, es lo que hace avanzar lo que se llama impropriamente la clínica. Espero que nadie se equivoque al respecto. Si la última vez experimentaron algún placer al ver aclararse la mención de un caso lo que constituye el carácter clínico de lo enunciado de esta enseñanza”. Clase del 14 de mayo de 1969. Paidós. P. 280-281.

3 Lacan, J. Seminario 15. El Acto Analítico. No establecido. clase del 28 de febrero de 1968.

4 Soler, C. El Decir del Analista. Paidós. Buenos Aires. P. 28.

5 Lacan, J. RSI. No establecido. versión crítica. 10 diciembre 1974.

Lacan en *RSI* dice que hace falta que el analista sea dos^[5]. Para nuestro encuentro se introduce que el analista sea el *causa* y clínico^[6], esa separación del y me permite reflexionar ¿acaso están separados?, ¿en qué punto se da el empalme y en cuál se separan? Me valgo de las posibilidades de lectura que tiene esta cita de Lacan,^[7] y es ese analista que es dos: el que tiene efectos y que los teoriza, pero que se puede leer por igual, que el analista para tener efectos debe teorizarlos. Así podríamos intentar plantear que el analista que tiene efectos como *causa* y el que los teoriza no pueden ser separados o ¿cómo son diferentes?, ¿Es posible ser analista sin teorizar? ¿Cuáles serían estos efectos? ¿Qué es lo que se debe teorizar de los efectos? Habrá que desarrollar los siguientes puntos: *empalme*, analista y clínico.

El punto de la teorización se vuelve problemático, pues tendríamos que plantearnos qué serían los efectos, yo apuesto a que sean los del análisis, de los del analista, de lo que encuentra en su clínica, ¿Es presentar/ teorizar lo que escucha de sus pacientes? Se abre un debate necesario. Ya Colette Soler, lo planteaba hace poco en la conferencia que dio en Madrid, *la teoría no es sin la experiencia y la experiencia no es sin la teoría*. No obstante, quiero insistir, pues uno de los puntos, llamémoslo candentes, tiene que ver con las consideraciones asociadas a la teoría y la teorización, y en este punto emerge en algunos lugares la presentación de los casos clínicos, que, si bien resultan ilustrativos, ¿no irían un poco en contravía de la singularidad de cada sujeto? ¿O es la teorización, el debate y reflexión sobre el psicoanálisis mismo lo que nos convoca en el trabajo de Escuela y de los Foros? Dejo esto en suspenso. Retomo el hecho que el analista no se autoriza sino de sí mismo^[8], sino también de otros^[9].

6 Presentación SIMPOSIO INTERAMERICANO 2025 EL ANALISTA Y EL CLÍNICO.
https://www.champlacanien.net/public/docu/3/IA2025_Argument.pdf

7 Referencia a la versión no establecida, crítica de Ricardo Rodríguez Ponte, en la que señalan que Lacan dice: “Sin embargo es indispensable que el analista sea al menos dos. El analista para tener efectos es {est} el analista que, a esos efectos, los teoriza” y dice que el “y” en el lugar de est (et) es una transcripción de Jacques-Alain Miller

8 Referencia tanto de la Proposición del 9 de octubre del 67, como de la Nota a los italianos.

9 Lacan, J. Seminario 21. Los incautos no yerran (Los nombres del padre). No establecido. clase del 9 de abril de 1974 “Empalmarlas sería darles ese desarrollo que haría que, en una escuela, la mía porque no, con alguna suerte, que en una escuela se articulara esa función de la cual la elección del analista, la elección de serlo no puede sino depender. Porque al autorizarse sólo por sí mismo él no puede con ello sino autorizarse también por otros. Me reduzco a ese mínimo porque precisamente, espero que algo sí invente del grupo sin volver a deslizarse por el viejo carril, aquel del que resulte que en razón de viejas costumbres — contra las cuales después de todo se está tan poco precavido que

En la Apertura de la Sección Clínica^[10], encontramos que, “*la clínica psicoanalítica consiste en reinterrogar todo lo que Freud dijo. Es así como lo entiendo, y en mi blablá, lo pongo en práctica*”^[11], trabajo constante, que por demás es el que nos convoca en nuestros encuentros; no es fortuito que, en esta apertura, la invitación sea a interrogarnos, Y a que podamos *dar cuenta*^[12] de aquello que la práctica tiene de azarosa.

¿Qué es lo que puede denominarse *analista causa*? Esto lo podemos ubicar en el discurso analítico, *lo que puede ocupar su lugar*^[13] dirá Lacan, ¿cuál lugar? El de objeto causa, así como en su homofonía con *causer*^[14] que apunta a la posibilidad de que un sujeto pueda hacer su recorrido analítico.

Así el analista *causa*, nos lleva a que él se sitúa *en-acto*, en el *acto analítico*. Hay un movimiento, a nivel de discurso, en el recorrido por los lugares propuestos por Lacan en que el lugar del agente, en el discurso analítico, es el *objeto a* como causa, y este lugar implica al analista, al clínico. Es de ahí que entiendo que Lacan señale que el discurso analítico “*no puede articularse sino mostrando que este objeto a, para que haya oportunidad de analista, hace falta que cierta operación, que llamamos la experiencia psicoanalítica, lo haya traído al lugar del semblante*”^[15], para que se produzca un analista entonces se necesita un movimiento, y es que éste se ubique en una posición, la del lugar del semblante^[16].

son ellas las que conforman la base del discurso llamado universitario—, uno sea nombrado —para, para un título”.

10 Lacan, J. (1976). Apertura de la sección clínica. Ornicar, 3.

11 Lacan, J. (1976). Apertura de la sección clínica. Ornicar, 3. P. 16

12 Lacan, J. (1976). Apertura de la sección clínica. Ornicar, 3. P. 23

13 Lacan Lacan. J. Aín. Seminario 20. P. 12. Versión Crítica. No establecido. Ricardo RodríguezPonte.

14 Hablar, conversar, charlar.

15 Lacan. J. Seminario 19 (Bis). El saber del Psicoanalista. Clase del 2 de Diciembre de 1971

16 La versión de STAFERLA, dice: “Que le discours psychanalytique ne puisse s’articuler qu’à montrer que cet objet(a), pour qu’il y ait chance d’analyste, il faut qu’une certaine opération, qu’on appelle l’expérience psychanalytique, ait fait venir l’objet(a) à la place du semblant;

Entonces tenemos un analista *causa*, que es *causado*, sólo como efecto de su propio análisis. Que inevitablemente, y si el analista opera como se espera que opere, y el sujeto asume su propio análisis, podrá ser desecho del discurso, podrá ubicarse o no, en el lugar de la causa, ¿y qué entendemos por el clínico? Podemos responder que es aquel que se dedica a la clínica psicoanalítica, que *“debe consistir no sólo en interrogar el análisis, sino en interrogar a los analistas, a fin de que den cuenta de aquello que su práctica tiene de azarosa, que justifique a Freud haber existido”*^[17], A partir de ahí podemos pensar en el empalme entre el analista y el clínico, que, como una banda de Moebius, convoca al analista en su formación, a poner en cuestión la teoría misma.

El interrogante entonces que propongo como título, me invita a seguir pensando el asunto, inicialmente había propuesto como título el remanente del final, tratando de hilar final de análisis, analista causa y deseo del analista. Temas que debo seguir interrogando. Lo que sí puedo decir, es que el empalme del analista *causa* y el clínico, podemos, a pesar de la dificultad de la teoría y del análisis mismo, pensarlo más, cuestionarlo y finalmente, construir y teorizar en torno a ello.

¹⁷ Lacan, J. (1976). Apertura de la sección clínica. Ornicar, 3. P. 5.

“La ficción del caso”

Sebastián Fernández Moores

Me interrogo acerca del estatuto del caso clínico para el psicoanálisis y el lugar de la ficción en su escritura. Parto del modo en que Freud plantea dicha cuestión a propósito del hombre de los lobos: *"No puedo escribir la historia de mi paciente en términos puramente históricos o pragmáticos; no puedo brindar ni un historial clínico ni uno del tratamiento, sino que me veré precisado a combinar entre sí ambos modos de exposición. (...) De nada valdrían (...) unos protocolos exhaustivos de cuanto sucede en las sesiones de análisis, por lo demás, la técnica misma del tratamiento excluye su confección."*

Claramente para Freud la redacción de un caso no implica el registro y la reproducción de la manera más textualmente posible de lo que dice el paciente o de lo que ocurre en el tratamiento, eso se ve muy bien en los historiales publicados. El armado de un caso para Freud tiene que ver con la decisión de producir un texto: la escritura del caso de por sí ya implica la selección, el recorte de los dichos, un ordenamiento y por ende ya hay allí cierta toma de posición. Algo que implica ciertas dificultades: *Qué embrollo cuando tratamos de describir un análisis! ¡ Qué pena da tener que presentar en fragmentos el gran trabajo artístico que la naturaleza creó en la esfera psíquica!* se lamenta.

Lacan trabaja la cuestión de la ficción a partir de los desarrollos de Jeremy Bentham, padre del utilitarismo, quien diferencia los elementos cuya constancia de su existencia tenemos a través de los sentidos, de las entidades ficticias, que carecen de este referente en la realidad. Ambos son necesarios para la comunicación, pero los ficticios, si uno no está advertido, pueden confundir su ámbito, dotando de fundamento lo que no lo tiene. Para Bentham todos los elementos abstractos, entre ellos el lenguaje, pasan a ser ficciones, creaciones del pensamiento. Así reduce los elementos ficticios a una mera función representativa.

Apoyándose en esto, Lacan va a plantear que lo ficticio no necesariamente tiene que ir de la mano de lo ilusorio sino que hay que entenderlo como una estructura del lenguaje para tratar lo real. *"Fictitious quiere decir ficticio sólo en la medida en que responde exactamente a lo que nosotros queremos decir cuando formulamos que toda verdad tiene una estructura de ficción... Con lo que admite de real esta ficción verídica"*, plantea en la reseña del seminario 7.

De ahí que la redacción, la construcción de un caso necesariamente implica el uso de la ficción pero no por un mero interés estético o literario, sino como un modo de intentar cernir un Real. Las diferentes reformulaciones que fue haciendo Freud a partir de las lecturas y relecturas de los casos da cuenta de que la clínica no implica meramente la descripción de los fenómenos, sino que consiste en leer pero sobre todo en construir la estructura. ¿Cuál es el sentido de la escritura de los casos? Uno de ellos es la investigación: es necesario dejarse tomar por lo que el caso enseña. Hay un ida y vuelta entre teoría y práctica: el modo en que Freud teoriza incide sobre su práctica; pero que al mismo tiempo el caso puede enseñarle algo novedoso, que le permita modificar la teoría.

Para poder dar cuenta de una ficción que incluye a lo real, Lacan da cuenta en el Atolondradicho de un neologismo: *fixion* (con x) tomado de la palabra en alemán *fixierung* que implica la dimensión de la fijeza. Término que Freud usa en diferentes momentos de su obra: asociado a la represión primaria en su texto “La represión”, a ciertos momentos del desarrollo de la libido y de sus fijaciones en una de sus “Conferencias de introducción al psicoanálisis”, a lo traumático en Más allá del principio de placer y en análisis terminable e interminable asociado al mecanismo defensivo que crea la alteración del yo y se manifiesta como “infantilismo”. La propuesta de Lacan es *“la salida de las ficciones de la mundanidad haciendo fixion (con x) distinta de lo Real: o sea con lo imposible que lo fija desde la estructura del lenguaje*. Ir entonces de las ficciones a la *fixión*, orientación que nos remite a lo que Lacan formaliza como el síntoma en tanto función de letra: $f(x)$, uno que el síntoma extrae del inconsciente y lo hace letra gozada, a la que el sujeto queda fijado. *Fixion* (con x), que además de quedar asociada a la dimensión de la fijación, remite también al verbo en inglés “to fix”, o sea arreglar. No el arreglo de la castración, que es un hecho de estructura, sino arreglárselas con la castración sirviéndose del síntoma, que responde a lo que cada uno inventó para suplir la no relación sexual.

“Es también” continúa con la cita del Atolondradicho, *“trazar la vía por la que se encuentra en cada discurso lo real con que se envuelve, y expulsar los mitos con lo que de ordinario se suple”*. De las ficciones de la mundanidad a la *fixión* (con x), profundización de lo real entonces y expulsión de los mitos. El caso clínico, tal como el análisis, va en dirección contraria a la del mito, el que según plantea Lacan *“da forma épica a lo que se opera a partir de la estructura”*. Por ejemplo, si por estructura el goce no es pleno para el hablante, sino limitado, el mito de Edipo intenta dar cuenta de dicho real responsabilizando al hijo de Layo, culpándolo de un supuesta falta.

Expulsar los mitos implicaría en este caso dar cuenta de la castración, que nada tiene que ver con las faltas de quien paga con la desgracia. De allí que el mito va por el camino inverso al caso clínico que, decía, apunta a cernir un real.

La fixión (con x) en el caso clínico entonces ya no responde a las ficciones de la mundanidad. Si decía que la redacción del caso no es la recopilación de lo que ocurre en un análisis sino que implica ubicar el hecho de estructura, necesariamente deberemos incluir en el mismo el modo propio, singular, que el analizante inventó para arreglárselas con lo Real y cómo el análisis fue incidiendo en su relación con dicha invención que es el síntoma.

“Agotando la significación”...

Jorge Chapuis¹

AP en la EPFCL, ha sostenido diversos lugares institucionales en los foros y en la Escuela en España, actualmente reside en Argentina. Miembro fundador del Centro Investigaciones Psicoanálisis & Sociedad (Barcelona), director editorial S&P ediciones. Autor/colaborador de *Guía topológica para "L'etourdit"* y *Paso a paso hacia una clínica borromea* (con R. Cevasco).

Una "clínica psicoanalítica" no debiera olvidar el trenzado de las "entidades" implicadas y la profunda interrelación de las subjetividades variopintas que participan de un psicoanálisis, que no se reducen a las figuraciones del analizante y el clínico, están las condiciones de contorno... Esas que permiten clinicar:² hacer acostar a alguien para que hable con la esperanza de que se consiga algún beneficio.³

Una clínica psicoanalítica que fuera lacaniana, pondrá todo su peso en el peso del significante. En un significante que tomado del inconsciente freudiano, opera según su nueva designación: une-bévue.

Lo que resta cuando se ha agotado toda su significación que el blablablá busca implantarle.⁴

Mi afinidad con la época borromea de Lacan⁵ me conduce a plantear cómo tal clinicar se desplegaría en un quehacer nodal.

Una clínica lacaniana de nudos, tratará con el significante en enjambre del inconsciente, los que solo se encadenan al ser proferidos.

La elucubración de Freud (un inconsciente supuesto como cadena de los significantes) lleva a producir un sentido: el relato edípico. Lacan dice "yo también colaboré", pero nos empuja a abandonarlo y a clinicar de otro modo y despegarse de la orto-doxa freudiana.

Que yo sepa, Lacan emplea este neo-verbo cliniquer solo otra vez.⁶ Ahí se refiere al análisis didáctico. Sabemos que sostiene que no hay diferencia, un análisis es un análisis y al final se verá su alcance, es decir si se revela didáctico o no. A mi caso me remito.

Clinicar se hace acostado con la ilusión de discernir un decir que importe en lo real. Serán cosas de peso (massives), cuando apunte al peso del significante.

Notas:

¹ Intervención en el VI Simposio Interamericano de la IF-EPCL: "EL ANALISTA Y EL CLÍNICO", Buenos Aires, del 4 al 6 de julio de 2025.

² Esta presentación tiene como eje mi trabajo en el cartel del Seminario de Escuela EPEE, con S.Berta, M.Laje, C.Zafonne y M. Mazucca donde nos ocupamos de la Apertura de la Sección Clínica, J.L., 1977.

³ J.L. Apertura..., 1977 y Respuesta a las notas post Proposición de 1967 que habían circulado entre AEs y AMEs en la E.F.P.

⁴ J.L. Prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, 1977.

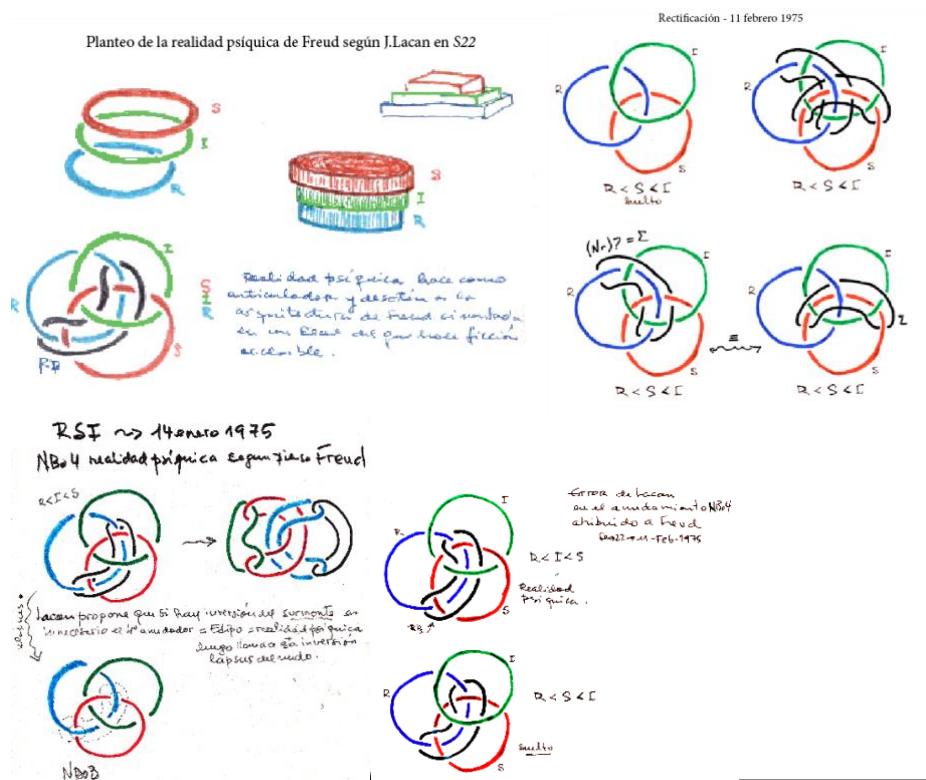
⁵ Desde 1972/73 hasta el final de su enseñanza.

⁶ J.L. Respuesta a las notas... 12 junio

⁷ J.L. Seminario 22, RSI, 1974/1975.

⁸ J.L. Apertura...

⁹ J.L., Apertura...: "Entonces, el inconsciente no es de Freud [digamos no está estructurado tal como él lo imagina], hace falta que lo diga, es de Lacan. Eso no impide que el campo, el campo mismo, no sea freudiano."



Este significante, tomado del inconsciente freudiano, opera según su nueva designación: une-bévue. Según lo que resta agotada toda significación que el blablá busca implantarle.¹¹

El inconsciente no nos guía bien (sobre lo Real).

El nombre lacaniano del inconsciente será l'une-bévue (de Unbewußte): bévue > torpeza, equivoco. La elección del equivoco translingüístico que pone de manifiesto este aspecto porque no es simple homofonía. Ese Un/une incorpora en sí mismo un equivoco. Une indica lo Uno, la unidad, el origen, pero en alemán es IN (de la denegación).

Se trata de un equivoco que es indicador inequívoco: es un equivoco inequívoco.

Lo cual atañe a cuestiones clínicas fundamentales, entre otras: – es cuestión de puro significante

– tratamos con el parlêtre (une-bévue), no solo con el sujeto (inconsciente).

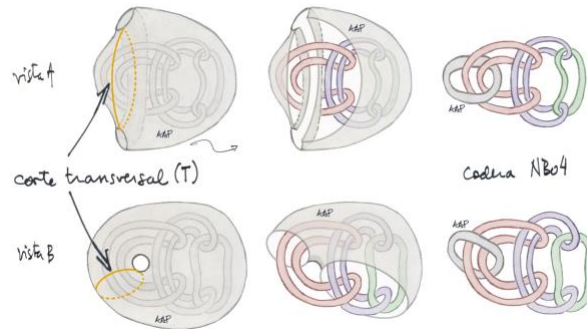
– atañe al cuerpo, por la vía del síntoma.

Clinicando se podrá buscar la envoltura del "amor al padre" para que surja la estructura, y su nominación como sinthome (su escabel), donde I y R juegan de igual a igual con S.

Lacan critica en su seminario (1977) al psicoanálisis basado exclusivamente en lo Imaginario o en lo Simbólico (como antes el suyo el propio), y habla de la necesidad de contra-análisis para esos casos.

¹⁰ "Entrevista de Paolo Caruso", 1966, en Conversaciones con Lévi-Strauss, Foucault y Lacan, Milano, U. Murcia & C, 1969 y Barcelona, Anagrama, 1969: "Estamos en el plano del ritmo, de la cadencia, de la interrupción, de los grupos temporales en los que se pueden hacer distinciones propiamente topológicas –de grupos abiertos y grupos cerrados, por ejemplo."

¹¹ J.L., "Prefacio a la edición inglesa del Seminario 11", y otras referencias: al menos en RSI (sem22), "Joyce el síntoma II", L'insú (sem24).



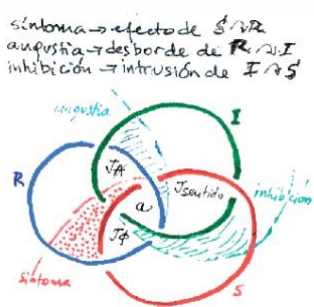
Tratamos con el significante en enjambre, para agujerear la envoltura que el simbólico consolida como "amor al padre", buscando que emerja la nominación de la estructura sostenida por el sinthome (NdP u otro escabel). Cuerpos que viven, se reproducen, y por lo simbólico hablan, piensan, sueñan, gozan... a lo borromeo.

Para el parlêtre, lo Real y lo Imaginario juegan de igual a igual con el Simbólico, pero hay una consistencia más.

Lo simbólico "es lo que providencialmente anuda".¹² La cuestión es cómo se ha dado cuerpo al campo del goce, especialmente a ese "gocce ausente del Otro", justo lo que el Simbólico muerde quitándole el trocito que lo barra.

Porque hay cuerpos en lo real, no cuerpos solo en lo imaginario (estadio del espejo), sino cuerpos que viven, que se reproducen, y por lo simbólico hablan, piensan, sueñan y gozan... a lo borromeo. Hay discriminación y

¹² J.L., Apertura...



circulación (o detención) por los goces, incluso por ese supuesto goce del Otro que no hay.

La articulación borromea de RSI —donde Lacan funda su desvío de la concepción freudiana del inconsciente— correspondería a la articulación de un hablante sin síntoma, digamos ideal... RSI siempre es fallido, al repararlo con el Sinthoma aparece el síntoma.

El inconsciente se produce con el lapsus/fallido... del nudo y con un desdoblamiento de S: inmersión en el lenguaje, de-nominaciones y reparación del anudamiento por la capacidad de sostén que tiene el síntoma, es decir lo sinthomático del síntoma.¹³

Une-bévue conformado por significantes gozados que "no dicen nada" pero que afectan al cuerpo (modelo psicosis), que sintho-matizan. Lo borromeo abre a nuevas concepciones.

No conviene convocar a la metáfora, en especial una interpretación sobre la metáfora paterna, que no aparece necesaria para un parlêtre, habrá otras opciones. La diferenciación entre psicosis y neurosis se afloja. Diversos fallidos RSI y múltiples reparaciones. Se distinguen las neurosis borromeas de otros anudamientos. El nudo del Sinthoma y el Ego-Joyce son ejemplos...

No existe hoy día una clínica nodal más o menos compartida, pero hay algunos practicantes.¹⁴

Clinicar a la borromea se sostiene en la hipótesis mínima de que un momento clínico de un sujeto (esté o no en análisis) puede exponerse en términos de RSI estructurados según un nudo-cadena, y que esta cambia.

Imprescindible: definir los fenómenos clínicos significativos; referirlos a RSI; escribir los nudos; justificar las transiciones entre nudos, etc. Gramática, sintaxis y semántica borromea.

Las conformaciones son múltiples, a veces discordantes.¹⁵

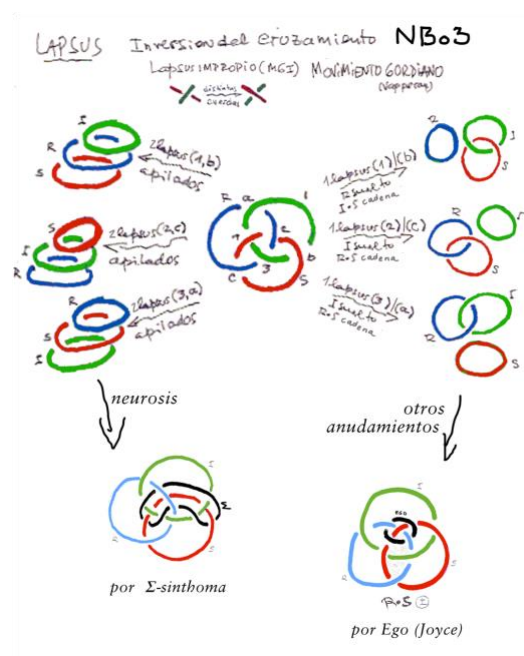
¹³ Nuestro colega francés lo dice muy sencillo: Bruno Geneste, Samuel Beckett, el arte del nudo-decir, Nouvelles Ed. Champ lacaniane, próximamente S&P ed.

¹⁴ Desde hace varios años trabajo con Rithée Cevasco coordinando un taller internacional donde ponemos a discusión casos clínicos formulados desde esa perspectiva en el que participan colegas que están en este encuentro.

¹⁵ Véase publicaciones de F. Schetjman, M. Bousseyroux, Ch. Melman, B. Nominé, etc.

Hipótesis de contexto o presupuesto básico (Lacan lo dice mucho):

Siempre en el parlêtre hay una falla original de anudamiento RSI que hay que reparar.



“Consideraciones sobre la división subjetiva suspendida del analista: deseo, discurso, síntoma”

Gabriela Moreira

PhD. Psicoanalista con consultorio en Los Ángeles, miembro del Foro de California y de la Escuela de Psicoanálisis del Foro del Campo Lacaniano. Doctora por la Universidad de São Paulo, Brasil. Entre sus publicaciones se incluyen: Psicoanálisis y teoría política, Reflexiones sobre la autoridad: Un diálogo entre Hannah Arendt y Jacques Lacan, El goce como categoría política, El tratamiento de la ansiedad a través de la fantasía y el delirio.

En la situación analítica, existe una disimetría entre el analizante y el analista a nivel de la división subjetiva. Es decir, mientras el primero hace de su división subjetiva el motor del análisis, el segundo la suspende para actuar en la dirección del tratamiento.

Freud es claro al respecto:

No puedo aconsejar a mis colegas con demasiada urgencia que se modelen durante el tratamiento psicoanalítico como el cirujano, que deja de lado todos sus sentimientos, incluso su simpatía humana, y concentra sus fuerzas mentales en el único objetivo de llevar a cabo la operación con la mayor habilidad posible. (1912)

En esta línea, recomienda a los analistas que se abstengan de actuar en función del deseo sexual que puedan desarrollar por los pacientes. Por su parte, Lacan habló del deseo del analista, del discurso del analista y del analista síntoma.

Para ambos, la posibilidad de sostener esta posición deriva directamente del análisis del analista. Freud se refiere a esto como purificación psicoanalítica: «[el analista] debe haber pasado por una purificación psicoanalítica y haber tomado conciencia de los complejos propios que podrían interferir en su comprensión de lo que el paciente le dice». (ibíd.)

Lacan habla de llevar el análisis a un punto de inflexión: «Aquellos que no saben llevar sus análisis didácticos al punto de inflexión [...] no saben nada de lo que es necesario obtener del sujeto para garantizar la dirección de un análisis [...]» (1953/1998, p. 642) Su relato del punto de inflexión habla de un cambio en la relación del sujeto con su deseo:

[el punto de inflexión] en el que se revela, titilantemente, que todas las demandas articuladas en el análisis -y más que ninguna otra, la que estaba en su comienzo, la de convertirse en analista, que luego se agota- no eran más que transferencias destinadas a mantener un deseo inestable o dudoso establecido en su problemática (ibíd.).

El punto clave aquí se refiere a la posibilidad, dada por el análisis, de acceder a un tipo de deseo que no sea inestable o dudoso. Esa inestabilidad del deseo tiene que ver con su orientación por las coordenadas del fantasma, ya que se dirige hacia un objeto que siempre lleva la marca de la falta -ayudar, comprender, guiar siempre será incompleto.

Atravesar el fantasma, a su vez, permite al sujeto sostener un deseo que no tiene objeto, sino que sólo está animado por un objetivo: obtener la diferencia absoluta. Es lo que Lacan llama el deseo del analista, que insta para él una nueva modalidad pulsional. El analista permanece libidinalmente investido en su función al tiempo que suspende los caminos habituales que recorrería la pulsión si siguiera la configuración fantasmática.

Lacan también abordó la posición del analista desde un punto de vista discursivo. Afirmar que el agente del discurso del analista es el objeto a es también una manera de señalar la suspensión de la subjetividad del analista. Él asume la posición del semblante del objeto - una voz que calma, se entromete; una mirada que admira, examina, mira hacia otro lado; un pecho que ofrece algo; la mierda a desechar. Nunca un objeto completo u otro sujeto, el analista es sólo un residuo que causa al analizante a desear y a hablar a partir de su división. Los efectos de su operación se encuentran en los intervalos de un movimiento siempre renovado de la cadena significante.

Pero al extraer consecuencias de la dirección del análisis hacia lo real, Lacan centra su atención en el síntoma, que es una vía encontrada por el sujeto para obtener satisfacción a pesar de la imposibilidad de la relación sexual. En este sentido, el síntoma es una manera de hacer algo con el reconocimiento de lo imposible. A partir de esto, el analista adquiere un nuevo rol en el tratamiento - es un partenaire del síntoma del analizante, encarnando lo real y funcionando como complemento del goce. Para Izcovich (2018, p. 180): «Este es un verdadero punto de inflexión en la teoría de Lacan».

El analista asume el papel del enigma, al que el inconsciente del analizante dirige sus formaciones como un intento de responder a sus preguntas sobre el sexo y la existencia. Y a partir de esta

asociación temporal con el analista, el analizante puede crear un nuevo saber-hacer para hacer frente a lo imposible que se presenta en sus preguntas.

El analista síntoma se diferencia del analista de la causa del deseo en el sentido de que no contribuye a mantener el movimiento constante producido por el deseo, sino que promueve una reducción. Reducción no significa aquí hacer los síntomas menos nocivos, sino reducir la proliferación de síntomas a un síntoma central que se radicaliza hasta alcanzar un punto irreductible, produciendo lo incurable. En otras palabras, los síntomas que se forman por la combinación de significantes pasan a ser escritos por un significante que se retira de la cadena significativa, alcanzando el estatus de letra o marca.

La posibilidad de encarnar lo real para el analizante deriva de la producción de una marca ocurrida en el propio análisis del analista. A esto se refiere Lacan (1973) cuando dice que «el analista debe llevar la marca». Aquí vemos la conexión necesaria entre la capacidad de sostener la posición del analista y llevar un análisis hasta el final.

Referencias

Freud, Sigmund (1912) «Recomendaciones a los médicos que practican el psicoanálisis». The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volumen XII, pp. 109-120.

Izcovich, Luis. Las marcas de un psicoanálisis. Londres: Routledge, 2018.

Lacan, J. (1953) «La dirección del tratamiento y los principios de su poder». En: Escritos. Río de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

_____. (1973) «Nota italiana». En Otros Escritos. Río de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

MESA 2 - TRANSFERENCIA Y ACTO ANALÍTICO

Oscar Quiroga (FA-BA)

¿Qué dimensión se pone en juego en el acto analítico?

Santiago Thompson (FA-BA)

¿Qué entendemos por principio de abstinencia?

Vanina Muraro (FA-BA)

Interpretación y caída libre

Gabriela Zorzutti (Foro Colorado)

La voz media y el *Wunsch freudiano*

Daniela Ferri (FA -Patagonia)

Poner el acto en posición de agente

“De la interpretación a la transferencia, y retorno”

Oscar Quiroga

Lic. en Psicología (UBA). Doctorando en Psicología (UBA). Psicoanalista. JTP de la materia Psicoanálisis Escuela Francesa I (Cátedra Dr De Olaso). Enseñante del Colegio Clínico del Río de La Plata 2023-24. Autor de los libros "El nombre propio y la nominación. Un recorrido genealógico", Letra Viva 2019, de "Las paradojas del sujeto. Una genealogía" Escabel Ediciones 2024. Coordinador del Colegio Clínico del Río de la Plata 2025-2026. Miembro del Foro Argentino del Campo Lacaniano - Polo Buenos Aires, y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano.

Desplazar el punto de interrogación, desde la función del significante en la producción del efecto de sentido, hacia el problema de que aquel no puede significarse a sí mismo, traslada el asunto desde los elementos del conjunto hacia la estructura misma del Otro. Tanto Freud como Lacan, se topan con esto en la medida en que la praxis los dirige a lo que hace de obstáculo a la cura. Este cambio de acento afecta, entonces y necesariamente, a dos coordenadas centrales de la práctica: interpretación y transferencia.

La primera es considerada a partir de la escansión significativa, volviendo operativo el equívoco, aún el malentendido. Rápidamente, la interpretación pone sobre la mesa aquello que hace obstáculo al entendimiento y al razonamiento, porque ellos se basan en la creencia de que se entiende o se comprende lo que se dice, algo del orden de un pensamiento esférico, al cual Lacan le opone una pregunta: ¿qué topología del lenguaje es acorde al planteo analítico?

La paulatina relevancia de lo real como impasse la resitúa, estableciendo que su eficacia tiene en el malogro su resorte central. Se trata, en la interpretación, de aislar los significantes en su sin sentido, eso que denominará significante-letra. A través de este significante se apunta a la posición del objeto a en el fantasma.

Se vuelve efectivo entonces un desplazamiento por el cual la interpretación ya no se dirige al S_2 , sino al S_1 , vía el cual se apunta a inconsistir e incompletar al Otro, tomado como conjunto. Desde esta óptica, la interpretación apunta a lo indeterminado, lo que está más allá del tejido significativo, el discurso del Otro. Este pasaje conlleva, inevitablemente un cambio de acento en la elaboración de la transferencia.

Esta última es su “preocupación”, así la define. Y ello tanto por su contexto como por una pregunta que se formula en *Los cuatro conceptos*: ¿qué hacen los analistas con la transferencia negativa?

Dado que se entiende que en ella se pone en juego, a través del obstáculo, algo que está más allá del Sujeto Supuesto Saber.

Hay lo pensable de la transferencia, la cual se soporta del lugar del sujeto al que se le supone saber. Ahora, más allá de éste se recorta el lugar del deseo, el cual pervive como un resto de las vueltas dichas de la demanda, escapando al saber. Pero para que este recorte se ponga en juego, y habilite la posibilidad del trabajo, se requiere, del lado del analista, un rehusarse que opera una torsión que lleva de la demanda al deseo a través de la identificación. ¿Se torna posible pasar de la demanda al deseo sin atravesar el campo pulsional? Para responder a esta pregunta introduce la operación transferencial del deseo del analista.

Los puntos de referencia de la práctica analítica se sitúan, entonces, más allá de la verdad, y en esto el psicoanálisis, con Lacan, se inscribe en un contexto. Sin ese más allá se caería en una impostura, por cuanto se postergaría el juicio sobre la acción del analista en la cura. Se trata del movimiento por el cual se puede ir más allá de las creencias, diría que es la separación más allá de la alienación.

A un analista se le demanda, y dicha demanda no es abordada por el sesgo del objeto que parece reclamar, sino por el lugar del Otro que pone en juego. Allí el sujeto “armó” un menú, y la posibilidad de concluir es el margen para armar otro, no sin las marcas del Otro, pero que no esté ofrecido a su consistencia.

¿Cómo poner al trabajo la posición del objeto a del fantasma? Topologizando la transferencia. Si el Sujeto Supuesto Saber ilusiona con la demanda de amor, conminando al psicoanalista a ocupar el lugar del Ideal que garantice; el deseo del analista, a través del rehusamiento, la vuelve a llevar a la pulsión. Entonces produce una doble incidencia: permite atravesar de la demanda al deseo; en la misma medida en que mantiene la mayor distancia posible entre la posición del I, donde el sujeto se ofrece al amor del Otro, y la posición del objeto a, identificación que es soporte en el fantasma.

Con este movimiento se forja el pasaje desde lo idealizante de la demanda hasta la causa del deseo. En la transferencia, por ende, se juega el cambio de posición del analista desde el lugar del supuesto saber a la posición de semblante del objeto, movimiento habilitado por el deseo del analista como operador transferencial. Esa travesía que es la del fantasma fundamental lo lleva a Lacan a plantear: “... la experiencia del fantasma fundamental deviene la pulsión.” (1991: 281).

Del lado del sujeto, entonces, se abre el margen que distancia el “vivir la pulsión”, del goce mortificante del fantasma, ofrecido a la consistencia ilusoria del Otro. Entonces resulta lógico que se interrogue por el orden de verdad de la práctica analítica, ¿cómo pensar la verdad a partir de este pasaje? Me parece que es a través de la formación analítica que puede responder a ello, porque al analista se le “exige” (un término fuerte) haber llegado allí. El asunto entonces es poder definir el final de dicho lazo, y esto es algo que nos concierne como Escuela, porque implica la experiencia del pase.

Entonces retorno. ¿De qué manera se opera esa torsión? Vía un corte. Si a nivel del significante, la interpretación funciona como escansión; respecto de la posición del objeto a incide como corte. *La lógica del fantasma* despliega esa diferencia a nivel de la estructura de la interpretación. Se hace posible entonces conjeturar que es la paulatina importancia que lo real como impasse a lo simbólico le imprime a la práctica del psicoanálisis, lo que forja el paso por el cual se dirige desde la interpretación a nivel del equívoco significante; hasta la incisión y la cisura. El Acto Analítico es la consecuencia de un trabajo, un recurso allí donde la praxis debe ocuparse de lo que es reacto a la palabra, y no entra en el saber. Y conlleva la necesidad de interrogar el campo transferencial más allá de esa suposición que ilusiona. Entonces, no hay posibilidad de concluir, sin un acto.

Referencias

- Lacan, J. El seminario, libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis. Buenos Aires. Paidós. 1991.
- Lacan, J. El seminario, libro 14: La lógica del fantasma. Buenos Aires. Paidós. 2023.
- Lacan, J. El seminario, libro 15: El acto analítico (1967-68). Inédito.
- Lombardi, G. El juicio íntimo del analista. Revista Aun N°3. 2012.

“¿Qué entendemos por “principio de abstinencia”?”

Santiago Thompson

El así llamado "principio de abstinencia" freudiano ha dado lugar a múltiples interpretaciones, cuyo punto de partida es la circulación de tal denominación, de raigambre postfreudiana. Hoy, los medios digitales nos permiten corroborar rápidamente que tal sintagma no existe en la obra de Freud. La propuesta tuvo su primer bosquejo en el texto "Puntualizaciones sobre el amor de transferencia", de 1914, y es abordada en "Nuevos caminos de la terapia analítica", alocución de 1918. Lo que Freud ubica allí es lo que denomina "un principio soberano".

Introduce tal principio como respuesta a la propuesta de Ferenczi acerca de la actividad del analista. Freud sostiene: "En la medida de lo posible, la cura analítica debe ejecutarse en un estado de privación –de abstinencia–". El equívoco más común respecto de este enunciado es entender que se trata de que el analista se mantenga abstinento o neutral.

La llamada neutralidad analítica se esboza tanto en "Consejos al médico" como en "Sobre la iniciación del tratamiento", donde se trata de indicaciones negativas que apuntan a que, desde su posición, el analista favorezca el cumplimiento de la regla fundamental: la atención parejamente flotante, dejar a un lado la propia individualidad, el borramiento del yo por parte del analista. En 1918 Freud vuelve sobre algunas indicaciones en esa línea, que apuntan a los *medios* de la cura, a potenciar los poderes de la palabra.

En cambio, este principio apunta a operar sobre el síntoma, delimitándolo, aislándolo como lo analizable. Se trata de su puesta en forma. Es, entonces, una indicación que hace a los *fin*es de la cura, a la incidencia en la economía libidinal.

La actividad del analista implica que "en la cura es preciso mantener el estado de privación". Para sostener este estado, el analista interviene, opera e incide sobre el mantenimiento del síntoma.

Freud afirma en este contexto: "Por cruel que suene, debemos cuidar que el padecer del enfermo no termine prematuramente en una medida decisiva". Es central para la orientación en la clínica precisar a qué se refiere con "padecer". Entiendo que tal padecer es aquel que emerge de la disyunción entre lo que se presenta como síntoma y la unidad yoica. Se trata de mantener al síntoma en un estado egodistónico, evitando que se restituya la egosintonía anterior.

Freud alude a "la descomposición y desvalorización de los síntomas" como un saldo inicial del tratamiento, efecto de cierre que produce la transferencia sobre la división entre el síntoma y la unidad imaginaria del yo. El alivio inicial que supone el lazo transferencial desvaloriza el padecimiento, dando lugar a lo que Soler alguna vez llamó "sujeto indeterminado analizante": lo que previamente se presentaba como disyunción, deviene un "ser analizante" que produce una curiosa egosintonía del síntoma.

A esta inercia transferencial responde la operación del analista: ¿en qué consiste tal operación? En producir el síntoma como en cuanto manifestación de un saber que divide y concierne al sujeto que lo padece. Así leo la "privación sensible" a la que se refiere Freud: se trata de privar al ser hablante de la nueva unidad que le proporciona el "ser analizante".

Apunta también a las nuevas satisfacciones que ya no van acompañadas de padecimiento. Freud se niega en acompañar al analizante en tales empresas insensatas: el analista debe exigirle la renuncia (*Verzicht zu verlangen*) a tales aberraciones. No sostiene ante ellas una posición neutral, por el contrario, recomienda "una enérgica intervención contra las satisfacciones sustitutivas".

Esta lectura se ratifica a la luz de lo expresado en "Análisis terminable e interminable", cuando Freud alude al "precepto según el cual el análisis tiene que ejecutarse 'en la frustración' (*Versagung*, que se puede traducir como 'denegación' o 'decir que no')". En lugar de "privación" (*Entbehrung*), ubica este término, el mismo que emplea a la hora de conceptualizar los caminos de formación del síntoma.

Freud advierte que el ser hablante "busca la satisfacción sustitutiva sobre todo en la cura misma". Ante lo cual "lo adecuado al fin es, justamente, denegarle (*Versagen*) aquellas satisfacciones que más intensamente desea y que exterioriza con mayor urgencia". Denegar aquí implica no satisfacer la demanda para que el deseo subsista. No promover el cierre que en grafo lleva del lugar del Otro al s(A), para abrir el campo del deseo. Precisemos que no se trata de "no responder a la demanda". Lacan contradice la posibilidad de no responder a nivel de la demanda cuando, al recortar el lugar del analista a partir de su posición de oyente, señala que este supone "una secreta intimación que él no podría apartar ni siquiera callándose". Se tratará, en todo caso, de no ratificar la demanda en cuanto tal, es decir, no hacer consistir su enunciado.

En este principio soberano encontramos un antecedente freudiano del deseo del analista. Lacan entiende que, si la transferencia en su faz amorosa lleva a un cierre del inconsciente, es el deseo del analista el que vuelve a relanzar el trabajo analizante: "si la transferencia es lo que de la pulsión aparta la demanda, el deseo del analista es aquello que la vuelve a llevar a la pulsión". En el mismo sentido, Freud procura que el deseo no se anegue en la cura, que reste el deseo en la demanda en juego en la transferencia. Es por la operación del analista, el cual interviene con una privación sensible sobre la inercia transferencial, que la cura retoma la vía analítica para incidir en el núcleo pulsional del síntoma.

El principio revisitado aquí trasunta un deseo freudiano que orienta la cura en función de operar sobre el nudo libidinal que está en el corazón de la neurosis. Este principio, apunta a aquello que en última instancia opera en un análisis, oponiéndose a tanto la inercia transferencial como a la implicación del sujeto en su conducta, efecto de la defensa secundaria, que hace del síntoma inaprehensible.

“Interpretación y caída libre”

Vanina Muraro

Nuestra práctica clínica nos enseña a distinguir las determinaciones inconscientes en las producciones de nuestros analizantes. Una escucha entrenada reconoce esa coerción en un giro poco habitual de la lengua, en algún significante que insiste o se destaca por su rareza. En las trazas de ese forzamiento descubrimos los ecos de un conflicto: aquello que puja por ser oído se abre paso de modos insospechados en su afán por burlar la censura.

El procedimiento recuerda la novela de André Gide, numerosas veces comentada por Lacan, *Los monederos falsos* (Gide, 1925). Sus personajes, hombres jóvenes que salen a la vida son los artífices de una curiosa empresa: acuñar monedas de centavo y ponerlas en circulación. La estafa obedece más a un anhelo de diversión que a ansias económicas y desnuda una circulación vacía, de puro semblante en el mundo adulto, en el que padres y maestros no pueden más que mostrarse impotentes. El comportamiento me evoca el juego que practicábamos los adolescentes para poner al descubierto la impostura de nuestros maestros cuando disimulada en una monografía escondíamos una frase sin sentido, sólo destinada a develar la ausencia de lectura del corrector, la impostura del Otro.

Se trata de un gesto de denuncia, pero también de llamado; apelación a un lector o a una escucha atenta. Esa atención -parejamente flotante, propone Freud- sólo puede ser ofertada por aquel que se halla más libre de las ataduras a las que nos somete la manía de comprender y las determinaciones de un inconsciente virgen, es decir, por un analista.

Un analizante que intenta desmentir su preocupación por las cuestiones de dinero a las que califica de banales y propias de hombres mediocres, se sueña en la verdulería. El soñante es pintor y el material onírico está plagado de referencias a los colores y a la belleza de las frutas; asocia un modelo de *naturaleza muerta* como el de tantos artistas. Cuidadosamente las sopesa, siente sus aromas, busca las que están en su punto justo, elige finalmente la mercadería y sale del local “apenas con cinco mangos”.

Envuelta en una novela se hace escuchar la frase que alude a las penas y a la estrechez económica y a la castración. La pequeña ficción del sueño parece conformada para incluir ese sintagma preciso y la asociación otorga la clave: la referencia a la muerte. Observamos un procedimiento creativo, que se sirve del equívoco, de la alusión y evoca un sentido audible en el

seno de la parroquia. El analista si no es un Otro burocrático alienado al sentido común, siempre a contrapelo de la interpretación -insiste Lacan- como aquellos representantes escolares, es sensible a esa riqueza. Menos atenazado por sus propias determinaciones inconscientes, oye. Detecta el foco de esa composición plástica que constituye el sueño y tira del hilo de ese otro sentido que vibra: entre sonido y sentido (tal como dice Valery de la poesía) interpreta.

Dos inconscientes muy diversos que conversan, uno atenazado por la vigilancia yoica y otro ya desasido de las ataduras del sujeto se encuentran en el diálogo analítico y aún más puntualmente en la labor interpretativa.

La regla analítica invita a deslizarse, deponiendo cualquier tipo de resistencia -de sistematización o de pudor. Rodar, caer en el sin sentido a partir del sentido, en el sentido a raíz de un tropiezo de la lengua o de un chiste, recaer en algún sentido viejo conocido, recalar en un sentido inédito o, en el mejor de los casos, inventar algo que descompone la metonimia. Una caída que lejos de ser libre, en nuestro soñante, revela las ataduras y su penar que lo divide.

Decimos que el analista está advertido de sus propias determinaciones inconscientes, puntos ciegos de su percepción; inconsciente purificado... nada de esto suena libre o despreocupado. Sin embargo, la escucha recae en caída libre sobre aquello que vibra, no pretende hallar esto o aquello, no busca, encuentra.

El analista es aquel que de su inconsciente se ha sometido al rito hasta subvertirlo. Entre las referencias que me han ayudado a comprender esa operación de separación de la debilidad del sentido quisiera compartirles dos en esta ocasión.

La primera corresponde a Iuri Tinianov, formalista ruso; es muy sucinta. En su texto ensayístico “¿Cómo está hecho el Quijote?” el crítico propone que la parodia es la tumba del procedimiento. La parodia es un tipo de [sátira](#) o imitación burlesca que se lleva a cabo con fines humorísticos, echando mano a recursos como la [ironía](#) y la caricaturización. Si el Quijote es la última novela de caballería es porque una vez que se ha parodiado el género, este culmina. Me gusta esta referencia que apela al registro de lo cómico, al humor que hace un uso benéfico del superyó, para transformar la solemnidad del drama en comedia. Además, en el horizonte reside la posibilidad de realizar una obra, aunque esta no sea de la envergadura de la que compuso Miguel de Cervantes Saavedra.

La segunda referencia es de un autor argentino, novelista santafecino, Juan José Saer; pertenece a su libro: *El río sin orillas*. Saer escribe: “Es sabido que el mito engendra la repetición

y que la repetición la costumbre, y que la costumbre el rito y que el rito el dogma; y que el dogma, finalmente la herejía”. (Saer, 2020: 12).

Ese recorrido que plantea el escritor que transcurre del mito -estructura rígida y común- a la repetición y de allí a la costumbre que se ritualiza hasta hacerse dogmática e inaudible para conducir, en el mejor de los casos a la creación herética me evoca el camino del análisis llevado hasta las últimas consecuencias.

Finalmente, el diálogo analítico, expresión oximorónica, se produce entre esos dos hablantes tan dispares.

“La voz media en el *Wunsch* freudiano”

Gabriela Zorzutti

Lic. en Psicología por la UNMDQ, Doctoranda de la UBA, AME de la EPFCL. Miembro actual del CIG. Ha sido representante anglófona del CRIF, miembro de la COLAGE y secretaria del pase en la CLGAL 19-20. Es miembro fundador del Foro Analítico de Colorado y actual Directora del Colegio Clínico de Colorado. Miembro del Polo Buenos Aires del Foro Argentino y del Foro de Río de Janeiro.

Ya desde el Proyecto Freud había señalado que hay algo (*etwas*) en el inconsciente que estructura el deseo -*Wunsch*- indestructible, eso no cesa de escribirse. El inconsciente hace/crea formaciones en las que el deseo encuentra una articulación cifrada.

Es útil al analista acercarse al inconsciente como una experiencia gramatical, *litteraria*. Para trabajar con letras/restos, para poder leer, la gramática orienta el camino a la estructura del pensar inconsciente. De hecho cuando Freud buscaba explicar la pulsión, se ve llevado a pasar por la estructura gramatical de las voces verbales. No hay lectura posible sin distancia, la gramática da la perspectiva del juicio hecho, la posición tomada, en efecto, la perspectiva resulta de esto. Y tal como en el psicoanálisis, en el centro de su estructura algo se escapa: el punto de fuga que estructura toda perspectiva posible, ser de lo que se escapa.

La gramática puede considerarse como lo real del lenguaje, ya que al igual que lo real no tiene sentido alguno. Y tanto lo real como la gramática pasan por lo escrito, pasan por la letra. Gramática deviene de Gramma que, además de darle nombre a la gramilla que gustosamente comen las ovejas que creen usar el lenguaje para comunicarse; *gramma* es también el nombre de una marca, la letra, marca particular, es decir admite lectura.

En este sentido la escucha analítica es una práctica invocante, donde la cosa está más cerca de leer que de oír. Es una escucha que *lettraliza*, que toma de lo que queda, de lo dicho, del *bla bla* del analizante algo que se escribe. “Lo que rige lo escrito, como dice Héctor López, es la preeminencia del texto sobre la libertad del discurso; de lo hablado sólo habrá de quedar ese *factor* que es el ‘texto’”: pegan a un niño, por ejemplo.

La voz es una categoría del verbo que indica cómo afecta la acción verbal al sujeto. En griego la voz media se usa cuando la acción verbal alcanza al sujeto, es decir, cuando el sujeto es también objeto del verbo, pero, claro, cualquier objeto... -directo, indirecto, circunstancial-... viene bien.

Son numerosos los filósofos y teóricos del lenguaje entre ellos Benveniste, Barthes, Agamben, que han enfatizado el hecho de que la voz media suspende estrictamente la división sujeto-objeto e introduce una reflexividad, una inmanencia a la acción verbal. Ya no es “hago algo” o “algo me es hecho,” sino “algo pasa, se hace a través mío, me concierne.” El sujeto está concernido en el evento del verbo medio, pero no como el agente soberano, la acción no se origina completamente allí.

A su vez el deseo del inconsciente causa efectos tales como el sujeto, del que sabemos por las formaciones que lo presentan: el signo sintomático, los actos fallidos, pensar en sueños, etc.— pero el sujeto, en tanto efecto, no es el autor soberano de ese deseo. Más bien está atrapado en sus movimientos, muchas veces sin saberlo.

La voz media no es una mera curiosidad lingüística, sino el análogo gramatical de cómo el deseo y la verdad atraviesan al sujeto, causándolo cada vez, y sin pertenecer nunca plenamente a su «yo» consciente, ni tampoco al sujeto que de ese deseo resulta. Es el modo mismo del discurso analítico: una tercera posición más allá del «yo hago» y del «se me hace», en la que el sujeto se convierte en el lugar donde eso *-etwas*, el inc, la cosa, la falta, el deseo- habla.

Por lo tanto el deseo no es del analizante *per se*, el trabajo de articular algo legible pero irreconocible es el trabajo del artefacto inconsciente, y el deseo que así se articula le pertenece. Este inconsciente, estructurado como un lenguaje, habla descentrado del sujeto, en tercera persona, y en una voz, la media, que cancela la división sujeto/objeto. La voz media, en tercera persona, es la marca gramatical de un acto que no es de persona alguna, sino de algo, *etwas*, algo que habla, que se articula como decía Lacan. Una voz en la que es imposible distinguir si lo que habla es agente o paciente, no podría nunca tener al sujeto dividido como soporte ese decir. El uso de la tercera persona apunta al deseo, que siendo del inconsciente, no es “del” sujeto, sino de lo que habla descentradamente, marca de la “no-persona” decía Benveniste, la cosa perdida, la falta estructural, algo alucinatoriamente cercano a la experiencia de satisfacción, aquella que Freud designara como el origen mítico del deseo. Una experiencia que deja marca, vitaliza mortificando lo suficiente para soportar la práctica de un desear sin tregua: la de ser hablante.

La escucha analítica orientada por esos pastos fértiles de la gramática, reteniendo de lo que suena sólo lo que se escribe, produce una estilización de las amarras del ser-hablante, trabajo de saber sostenido en un anclaje transferencial específico: el par síntoma | analista, que a partir de ahí estará en condiciones de desarrollar una suposición subjetiva al saber que allí se registra trabajándose.

Se puede pensar el pase al analista, como un pase gramatical, un pase a la posición de la cosa que actúa, un semblante de objeto que causa de deseo dejando dispuesto el lugar del sujeto a otro hablante. El pase toma nota de la efectividad, de la actividad de un deseo en particular, el del analista, marca de haber pasado al analista. ¿Producirá formaciones del inconsciente? Pues, como dice Lacan, sólo hay formaciones del inconsciente, producidas como algo que habla a contrapelo de lo que se intenta transmitir. Lo que el pase pone en escena es la causa efectiva del deseo en ejercicio, provocando formaciones del inconsciente. Estos efectos, en tanto consecuencias, permiten retroactivamente leer el acto de un analista, algo en acto en el lugar de la causa.

“Poner el acto en posición de agente”

Daniella Ferri

AP Miembro de la Escuela de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. Miembro fundadora del ex Foro Patagónico. Miembro del Foro Argentino EPFCL ALS. Enseñante del Colegio Clínico de la Patagonia. Coordinadora de espacios de supervisión del Colegio Clínico de la Patagonia.

“porque todo sujeto está interesado en el saber que gobierna su posición”

Jacques Lacan, 1968.

Siguiendo la tesis de que *“un control tiene valor analítico si ayuda al controlante a poner el acto en posición de agente. Y como el acto supone el deseo del analista, es la misma cosa que decir que tiene valor analítico si este permite al deseo operar”* (Soler, 2009, p.153) comencé a interrogarme sobre la función del controlador en el dispositivo, específicamente sobre su operatoria.

Para el control no hay reglas, Lacan se dedicó a limpiar el campo de la formación didáctica de las reglas que la IPA imponía. Soler, hace pasar la práctica del control por los discursos de Lacan, para situar su valor analítico. Sin reglas no implica sin un ordenamiento. Los discursos son ordenadores, establecen lugares y funciones, tratando los goces de modos diversos. En cada discurso la relación al saber tiene sus particularidades. La práctica del control por su historia institucional relativa a la formación didáctica, ha quedado vinculada más a un acto educativo que una enseñanza. Considero que, en el control, se conjuga el saber del analista- el que resulta de su experiencia- y su transmisión. ¿De qué saber se trata? El controlador no es un profesor, y el acto educativo no es el acto que aquí se trata. Entre lo educativo y lo enseñante, interpongo el deseo de transmisión, que es sostén de un acto de otro orden.

El controlador, tampoco es el analista. Podríamos decir que en la estructura, analista y controlador están hechos de la misma estofa, por haber llevado su análisis hasta el final, y haber cernido un deseo inédito que lo autoriza (de sí mismo) a ocupar ese lugar. Un saldo del final -caída del sujeto supuesto saber- se lee en el deseo de transmisión que opera en el control. Autorizarse a ocupar ese lugar, en la formación de los colegas, está en torno a eso. El controlador, en su hacer, hace Escuela,

el controlante también. Ambos convocados por la puesta en forma de un deseo singular soporte de un saber hacer.

Voy a tomar una vía que se impone en la experiencia. Los colegas demandan un control, en tanto se ven superados por su acto. Hay una afectación que concierne a la persona del analista, más allá de la eficacia de su acto. Un afecto contra- transferencia. Ya sea por no haberse animado, y entonces quedarse inhibido ante él, ya sea por tener la sensación de haberse excedido. La pregunta “¿Qué hice?” insiste cada vez. Eso se impone.

El controlador no es un profesor, el saber que adquirió en su experiencia no puede enseñarlo, solo es posible que una transmisión suceda en acto, si el saber queda descolocado del lugar del agente. El saber (S2) hace obstáculo al acto, en tanto produce la división del sujeto, tenemos esa experiencia. Me pregunto: ¿qué operatoria se pone en juego, para que el saber no obstruya el deseo del analista? El saber que deja de saldo el análisis es un saber acerca del inconsciente. Eso no puede más que transmitirse sin mediar sujeto, es un saber hacer, saber sin sujeto. El analista en su función se presta al juego signifiante de la transferencia haciéndose un saber supuesto para el sujeto. La asociación libre y la interpretación comandan el trabajo. ¿Qué saber se le supone al controlador?

Al controlante, en cambio, no se le pide que hable de cualquier cosa, se le pide que hable de *eso* que se impone en su caso. ¿Cómo es que, hablando de eso, el acto quedaría colocado en posición de agente? Lo real que aparece allí, pone en jaque el saber supuesto. ¿*Qué hice?* Denota el horror al acto. Es un hecho de la experiencia que el controlante se hace siempre la misma pregunta. Sostenerla en el control es la vía regia para despejar lo que hace obstáculo. Si la transferencia se pone en contra, la incompetencia del analista se presentifica. Si el analista no encuentra en el deseo que lo sostiene en su función las garantías de su acto, queda des-a-comodado.

El controlador señala esos nudos, embrollos, embarazos en los que el deseo del analista queda atrapado. Señala sin responder, sin decir demasiado, sin corregir el estilo del controlante, y pone en cuestión su relación al saber, al saber y no al conocimiento. “No busca sacar al controlante del punto cero de saber. Rubicón del acto” (Soler, 2009, p.155)., En el mejor de los casos -en el encuentro entre controlador controlante- se produce un trabajo de elaboración, un “*llamado a interesarse, por lo menos, a saber, cómo lo asume*” (Lacan, 1966, p.132). Haciendo referencia al lugar que es llamado a ocupar en la dirección de una cura.

“¿Qué hice?”. Desde dónde se responda a esa pregunta dará su valor al control. La práctica del controlante es el referente. Poner el acto en el lugar del agente implica una operatoria tal que desate los embrollos que se arman en torno al saber supuesto, hacer pasar -transmisión- por el agujero del saber la resonancia significativa. El controlador no dirige la cura, ni dirige al controlante, en el mejor de los casos sostiene la pregunta por el acto.

La aporía del acto radica en ese núcleo opaco cuya aparición es imposible e incontrolable. Solo por sus efectos sabemos que aconteció, y es trabajo del clínico dar sus razones. Lacan nos advierte, que el mayor desconocimiento de lo que pasa en torno al acto analítico *“arrastra inmediatamente a quien lo asume y tanto más cuanto más seguro está y cuanto más capaz es...llevándolo a la negación de la posición analítica”* (Lacan, 1967, p.50).

Referencias

Lacan, J. 1966-1967. El Seminario. Libro 14, La lógica del fantasma. Ed. Paidós.

Lacan, J. 1967-1968 El Seminario. Libro 15, El acto psicoanalítico. Versión no establecida.

Lacan, J. 1968-1969. El seminario. Libro 16, De Otro al otro. Ed. Paidós.

Soler, C. 2009. *El control ¿qué discurso? El Florilegio del Mensual*. Ed. Asociación Foro del Campo Lacaniano de Medellín.

Soler, C. 2014. *Finales de análisis*. Ed. Manantial

MESA 3 ¿QUÉ ES UN CASO CLÍNICO?

María Laura Cury Silvestre (EPFCL- FCL São Paulo)

Viñetas clínicas: ¿qué es posible transmitir?

Martín Alomo (FA-BA)

El deseo de analista en la presentación de enfermos

Daniele Salfatis (EPFCL- FCL São Paulo)

Enigma, enigma, enigma: del Complejo de Edipo al deseo. de analista

Silvana Castro Tolosa (FA-BA)

El caso clínico: un tipo textual psicoanalítico.

Tomás Otero (FA-BA)

El problema del síntoma y de la estructura en la clínica de la
perversión.

“Viñetas clínicas: ¿qué pretendemos transmitir?” (traducción de Fernando Martínez)

Maria Laura Cury Silvestre

En el Simposio Interamericano de 2023, Ricardo Rojas nos dejó una provocación contundente, algo característico de sus intervenciones. Quiero entonces, de entrada, decir que le estoy inmensamente agradecida por haberla planteado públicamente, porque, al fin y al cabo, hoy, incluso sin su presencia física, estamos aquí trabajando a partir del debate que una vez más, y con mucho rigor, él incitó en nuestra comunidad. Tomé la cuestión por la siguiente vía: ¿por qué nosotros, lacanianos, advertidos de que el decir escapa al relato, usamos viñetas clínicas para transmitir lo que sucede en los tratamientos? Si “los sujetos de un tipo, por tanto, no son útiles para los de su mismo tipo”¹, ¿qué sería posible extraer de la clínica para que un recorte pueda apuntar a la transmisión?

En portugués, el término viñeta² significa adorno, ilustración, ornamento, alegoría, y, en algunos lugares, encontramos ‘relato breve’. Según Guy Le Gaufey, a pesar de la variedad de significados, “es notorio que cumplen todas la misma tarea [...]: *ilustrar*, mediante un ejemplo demostrativo, un enunciado demasiado árido y por tal motivo calificado de ‘teórico’³”. Una declaración poco simpática, que no asocia en absoluto una viñeta con la transmisión de la clínica.

Lacan, en el Congreso sobre la transmisión, en 1978, dice que su Proposición del 67 instauró el pase, apostando por algo que se llamaría transmisión, “si es que hubiese una transmisión del psicoanálisis. Tal como llego a pensarlo hoy” – dice él – “el psicoanálisis es intransmisible. [...] Es desagradable que cada psicoanalista esté forzado – ya que es preciso que esté forzado a eso

¹ Lacan, J. Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos Escritos, in: Outros escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003 (citado por Rojas em seu texto no referido Simpósio).

² Dicionário Houaiss da língua portuguesa, Antonio Houaiss e Mauro de Salles Vilar, elaborado pelo Instituto Houaiss de lexicografia e Banco de Dados da língua português S/C Ltda., Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

³ LeGaufey, Guy El notodo de Lacan: consistencia lógica, consecuencias clinicas – 1.a ed., Buenos Aires: El cuento de plata, 2007, p.151 (tradução nossa).

– a reinventar el psicoanálisis⁴”. Para abordar la transmisión, por tanto, ya estamos suficientemente advertidos de que no se puede enseñar en el molde profesor-alumno, ni apostar por el informe o la narración, porque precisamente se trata de un decir que escapa a lo dicho y apunta a lo real, que es bastante complejo.

Lacan, en 1974, afirma que “es indispensable que el analista sea al menos dos: el analista que produce efectos; y el analista que, a tales efectos, los teoriza⁵”. Y en 1977, en la Apertura de la sección clínica: “Propongo que la sección que en Vincennes se titula ‘clínica psicoanalítica’ sea una manera de interrogar al psicoanalista, de presionarlo para que declare sus razones⁶”. El clínico, por tanto, es quien interroga al analista y lo pone en el banquillo. Creo que, con eso, él nos dejó una tarea, y la indicación de por dónde deberíamos orientarnos: ¿no sería el tema de este simposio, “El analista y el clínico”, precisamente la paradoja que deberíamos sostener?

También mi título, con la pregunta “¿qué pretendemos transmitir?”, me incomodó al punto de querer cambiarlo por “¿qué pretendemos?”, excluyendo la referencia a la transmisión, ¿no me resultaría incómodo justamente por estar él mismo habitado por la misma paradoja que todos los días nos pone en el banquillo?

Es necesario renunciar a la dulzura del duro deseo de dormir en nuestro sillón, y sostener la posición oscilante ‘entre’ causa e interrogación clínica. La transmisión es contingente, ya estamos advertidos. Pretender transmitir algo ya es, por lo tanto, paradójico y ahí están el cartel y el pase para orientarnos. Sin embargo, si estamos aquí es porque estamos de alguna forma concernidos por la transmisión de la clínica. Sabemos que este simposio no es un dispositivo de transmisión. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Pretendemos estar a la altura de la tarea que Lacan nos dejó, orientados por la ética que es la nuestra: “la necesidad del analista de ponerse a

⁴ Lacan, J. *Conclusões Congresso sobre a transmissão*, in: Documentos para uma Escola II: Lacan e o passe, Letra Freudiana, 1995, p.66.

⁵ Lacan, J. O seminário, livro 22: RSI, p.29-30

⁶ Lacan, J. Abertura da seção clínica (texto publicado em *Ornicar?*, n.o 9, 1977

prueba en la provocación insistente de la transmisión de lo intransmisible en que consiste el desafío ético propio del psicoanálisis en su relación con lo Real⁷”.

Beatriz Oliveira, en el texto “Formación, investigación y transmisión en psicoanálisis”, retoma la articulación de estos tres términos y deja bastante claro que no es posible pensarlos separadamente. Destaco un pasaje en el que toca una cuestión crucial: “la construcción del caso clínico, así como su formalización, implican que el analista se disponga a testimoniar de su clínica y de la dirección del tratamiento, lo que pone a prueba justamente lo que hay de intransmisible en relación al deseo del analista y su acto⁸”. Por tanto, en esta tarea de reinventar el psicoanálisis, el analista no puede excluirse. Esta indicación ya está en el Lacan de 1965:

«Si el clínico, si el médico que presenta no sabe que una mitad del síntoma [...] es su responsabilidad, que no hay presentación de un paciente, sino de un diálogo entre dos personas, y que sin esta segunda persona no habría síntoma, está condenado [...] a dejar que la clínica psiquiátrica se estanque en el camino del que la doctrina freudiana debería haberla sacado.⁹»

A partir de esto, me pregunto si toda viñeta clínica, que no es un caso construido y formalizado, estaría necesariamente en una perspectiva objetivante de ciencia, en la que el objeto de estudio está separado de lo clínico, al modo de la clínica psiquiátrica clásica, como insiste Le Gaufey en la obra que cité anteriormente. Luiz Carlos Nogueira, por su parte, nos recuerda amablemente que “la transmisión de la clínica psicoanalítica supone la convivencia con esta práctica. El lenguaje para esta transmisión fue siendo creado por Freud, inicialmente. Lacan, después, produjo un código matemático en el sentido de establecer un rigor de investigación¹⁰”.

⁷ Finguermann, D. A (de)formação do psicanalista: as condições do ato psicanalítico, São Paulo: Escuta, 2016, p.163.

⁸ Oliveira, B. “Formação, pesquisa e transmissão em psicanálise”, Rede clínica/ Ana Paula Lacorte Giansesi, Beatriz Helena Martins de Almeida, Rita Bicego Vogelaar (organizadoras), São Paulo: Escuta/Fórum do Campo Lacaniano, 2016, p.21.

⁹ Lacan J. Problemas cruciais para a psicanálise (seminário inédito, versão para circulação interna do Centro de Estudos Freudianos do Recife, aula de 5 de maio de 1965).

¹⁰ Nogueira, L. C. A psicanálise. Uma experiência original – O tempo de Lacan e a nova ciência. Tese (livre-docência), IPUSP, São Paulo, 1997, p.1.

¿Será entonces que cada uno de nosotros, dispersos dispares, podremos también construir ese lenguaje con el tiempo, a partir de los diferentes momentos de nuestra formación?

Creo que la viñeta clínica puede, sí, ser una forma de hablar de la clínica que aún no puede decirse de otra manera, y no una mera ilustración. Hablo por mí: ellas tienen una función en la formación de un analista y en su compromiso con la responsabilidad paradójica de la transmisión de lo intransmisible, pero eso debe ser un trabajo advertido y articulado, para que no caigamos, con una viñeta, en el encanto somnífero de un relato banal.

Dejo sin respuesta la pregunta sobre qué es posible extraer de la clínica para que una viñeta pueda apuntar a la transmisión, pero, al fin y al cabo, ¡he aquí mi primer texto sin una viñeta!

“El deseo del analista en la presentación de enfermos”

Martín Alomo

Psicoanalista. Miembro del Foro Argentino del Campo Lacaniano y de la Escuela Internacional de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Doctor en Psicología. Magíster en Psicoanálisis. Especialista en Psicología Clínica. Docente del Doctorado en Psicología y de la Maestría en Psicoanálisis, UBA. Jefe de Servicio de Rehabilitación y Presidente del Comité de Ética en Investigación, Hospital “Dr. Braulio A. Moyano”, Ministerio de Salud, GCABA. Entre otros libros, es autor de *La función social de la esquizofrenia. Una perspectiva psicoanalítica*. (Eudeba 2020).

Espectacular y diametralmente opuesta a la escena del consultorio, la práctica conocida como “presentación de enfermos”, cuando se la realiza en el marco del psicoanálisis, importa una potencia de transmisión sostenida por la puesta en juego del deseo del analista.

Freud y Lacan, en los albores de sus respectivas teorizaciones, fueron tocados por la potencia clínica del dispositivo de presentaciones. El primero, a través de su maestro Charcot, durante su estadía en París como joven becario; el segundo, en las presentaciones de Clérambault, su “único maestro en psiquiatría”.

La intervención del deseo del analista en el dispositivo de presentaciones psiquiátricas lo desarticula y lo reinventa. En nuestras presentaciones, el deseo del analista propicia la inversión freudiana del saber respecto del saber del psiquiatra y, de esa manera, abre la posibilidad a la subversión lacaniana del advenimiento de un sujeto, siempre eventual.

La participación de Freud en el dispositivo conducido por Charcot en La Salpêtrière fue la causa del cambio de rumbo de sus inquietudes científicas, orientándolo al estudio de las histerias.

En lo que respecta a Jacques Lacan, aprendió de Clérambault la escucha fina que importaría a su práctica analítica, referida a una clínica de la especificidad y del detalle. Su enseñanza está poblada de referencias fundamentales, como los ya célebres ejemplos “*truie*” y “*galopiner*”; o la conocida “psicosis lacaniana”, el caso de las palabras impuestas; o el sorprendente y tardío “Aportes del psicoanálisis a la semiología psiquiátrica” en el servicio de Daumezon.

El Charcot de Freud y el Clérambault de Lacan señalan la importancia del dispositivo de presentaciones clínicas en los orígenes del psicoanálisis.

Por otra parte, es necesario señalar que se trata de una práctica signada por la polémica. Dentro del campo del psicoanálisis, hay posiciones encontradas al respecto. Tal vez sea Maud Mannoni la principal representante de las posiciones contrarias.

En cuanto al uso analítico del dispositivo, este comienza por la transferencia. Por lo general, un clínico perteneciente a un equipo, a un grupo de trabajo de un hospital, convoca a un analista para que realice una presentación con algún paciente del servicio.

Los motivos que producen la demanda del dispositivo son variados, pero por lo general responden a un momento de dificultad de la conducción del tratamiento, ya sea en el inicio, durante la marcha o sobre la finalización del mismo. La invitación al paciente es realizada por el clínico a cargo del tratamiento.

En el caso de que el paciente acepte la propuesta, se encontrará con una sala -habitualmente un aula del hospital- con un grupo de residentes, el plantel profesional del servicio y futuros colegas. Frente a este auditorio, cuyo número dependerá de las características de cada servicio, el paciente tendrá la ocasión de conversar con un analista, ante la escucha atenta de todos los presentes.

Concluida la entrevista, el paciente se retira de la sala y comienza el diálogo. Ahora sí el auditorio, que se había mantenido silente hasta entonces, toma la palabra.

La presencia del público en el dispositivo encarna vivamente un vacío silente. ¿Cómo podemos conceptualizar teóricamente este vacío silente encarnado por el auditorio? Si el público abre con su presencia la dimensión de un vacío en posición tercera, ¿cómo pensar dicha terceridad en su articulación con las condiciones estructurales del Otro?

En el momento de discusión posterior a la presentación, el cuerpo silente ahora habla y da vida a lo que de la conversación entre paciente y analista pudo pasar al auditorio. Este es el primer modo de sopesar los efectos del dispositivo sobre los asistentes. Efectos didácticos, compromiso con la clínica, entusiasmo.

En cuanto a los efectos en los sujetos, solemos constatar los siguientes: a) localización de la posición subjetiva; b) esbozo del recorte de un síntoma; c) formalización de una demanda específica; d) cesión inaugural de algún contenido delirante, hasta entonces rehén de la reticencia desconfiada; e) producción de un sujeto. Estos modos de comprometerse el entrevistado en la presentación sugieren la siguiente pregunta: ¿hay correspondencia entre los modos de presentación del sujeto y el tipo de efecto clínico que estaríamos en condiciones de recoger en un momento ulterior, a través del profesional responsable de conducir el tratamiento?

Además, como el dispositivo siempre es demandado por alguien -ya hemos señalado este punto- ¿podríamos detectar algún tipo de correspondencia entre las características de la demanda

del dispositivo y los efectos de cada presentación? Encontramos respuestas para esta pregunta en los seguimientos de los casos, reuniones de equipo y supervisiones posteriores.

La presentación de enfermos, al tratarse de una única vez, resulta un dispositivo privilegiado para estimar el efecto del encuentro con un analista. Con el valor agregado de la transmisión del psicoanálisis, en acto. Para quien pueda oír, es el paciente quien enseña y si hay un presentado es el analista. Él hace lo que puede, nunca del todo a la altura de las circunstancias, siempre tanteando y dejándose guiar por el entrevistado, dejándose aprehender por la particularidad de quien habla, de quien testimonia, sumiso a sus posiciones subjetivas.

“Enigma, enigma, enigma: del complejo de Edipo al deseo de analista”

Daniele Salfatis

Psicoanalista, Especialista em Linguagem por la COGEAE-PUC-SP, Maestría em Logopedia por la PUC-SP, Miembro Del Foro São Paulo, Miembro del Escuela.

Lo analítico y lo clínico, ¿cuál sería esa diferencia? O aún, el caso clínico, ¿cuál es la diferencia en la orientación del caso clínico en Lacan y en otros? No hay manera de saber qué orientaría esta multiplicidad de supuestos otros. Podemos decir que la práctica clínica está orientada por el psicoanálisis lacaniano. Así, el presente escrito pretende trazar una línea, de aquello que se coloca como denominador común para el analizante y para el analista: el enigma.

Al principio de un análisis, en las entrevistas iniciales, se nos presenta un síntoma, un sufrimiento, una escena que en ese momento es un índice de lo que no sabemos. Un enigma encarnado en la persona que dice algo de sí misma sin saber lo que dice, envuelta en su inconsciente.

Como en una película en la que nos muestra una escena presente, enigmática, y, a lo largo de la trama, la escena retorna y nos hace cuestionar, parece explicar algo más, y luego no explica nada más. Funciona como una goma elástica que de vez en cuando retorna, aparece y vuelve a hacer enigma.

En tiempos de tantos saberes al alcance de la mano, en tiempos *googolianos*, o donde la IA tiene máxima autoridad y respuestas instantáneas, el analista sólo puede sostener su ejercicio clínico a partir del enigma. El saber, en términos de certeza del conocimiento, impide el manejo de aquel que escucha y observa a su analizante preguntándole qué tiene que decir sobre su sufrimiento, qué tiene para mostrarme, sin ponerlo en una máquina de resonancia que nos daría la imagen más allá de su alcance.

Otras clínicas tienen conocimiento, escupen saberes y saben, fálicamente, decir de qué padece el paciente, pasivo. Por otro lado, para el psicoanalista, que no retrocede frente al no saber, que está advertido de lo imposible del universal y de la totalidad y, además, consciente de que no somos señores en nuestra propia casa, mucho menos seremos señores de la casa ajena.

Freud adopta el enigma en los tiempos más tiernos de su obra cuando observa a las histéricas y pregunta qué hay para ser dicho. ¿Qué hace que este cuerpo se retuerza que parece tener relación con la historia de aquella mujer?

En "La Interpretación de los Sueños" (1900), Freud nos invita a tangenciar el inconsciente, a desdoblar el rebus que insiste en velar el sueño y los laberintos deseosos.

El Complejo de Edipo, más allá de la relación entre padre, madre e hijo, inserta al sujeto en su posición significativa dentro de un relato anterior a su existencia. Un relato que nunca conocerá por completo. Una posición de la que sólo será consciente a partir de su síntoma, de su marca de diferencia con los demás personajes de la trama familiar.

En el mito, por más que Edipo corra del destino anunciado, tropieza con piedras dejadas en su camino. Y acaba por descubrir que aquello que pensaba haber evitado con tanto celo; se descubre asesino de su padre. "Edipo sabe sin saber que sabe, al mismo tiempo en que actúa movido por el desconocimiento activo de ese saber." (Jorge, 2010, p.188).

Edipo, que desvela el enigma de la Esfinge, cree tener el conocimiento de su destino, cree saber qué camino le alejará de su destino nefasto, acaba sorprendido por nunca haber sabido que sus pasos eran erráticos, que el enigma de la muerte de su padre lo acompañó todo el tiempo. Él era, para sí mismo, un enigma, aunque creyera en la verdad engañosa de que había burlado la profecía.

Lacan, en el seminario 23, al traer el *sinthoma*, habla del carácter enigmático con el que el nombre del padre, perversión (*père version*), amarra lo real, lo simbólico y lo imaginario, retomando el complejo de Edipo.

"Digo que es necesario suponer un tetrádico lo que hace lazo borromeano - perversión quiere decir solo versión en dirección al padre - en suma, el padre es un síntoma, o un *sinthoma*, si quieren. Establecer el lazo enigmático de lo imaginario, lo simbólico y lo real implica o supone la ex-sistencia del síntoma." (p. 21). "El Complejo de Edipo es, como tal, un síntoma." (p. 23)

Es a través de la inquietud de no comprender lo que le hace sufrir, que el sujeto dirige su enigma al sujeto supuesto saber. El analista, por su parte, se mantiene enigmático para que el

analizante siga construyendo algún saber sobre sí mismo que le sirva como embarcación en la travesía de su fantasía.

Mantenerse como sujeto supuesto saber, acompañando la travesía, solo es posible a través del mantenimiento del enigma que rodea el deseo de analista. Un deseo que pone en acto la diferencia absoluta, deseo de sostener lo que hay de único en la escucha de aquel, y que, en cuanto algo es tocado, escapa, se deforma, y otro enigma - o el mismo con otro disfraz - surge.

La inquietud inherente al deseo, deseo que cada vez es otra cosa, deja al analista con un pie en la canoa de la clínica, que lo indaga y lo hace cuestionar la teoría; y su otro pie en la teoría, que por su parte, lo arroja de nuevo a la clínica para inferir algo escuchado. Por supuesto, a continuación, la clínica vuelve a inquietarnos y regresamos al incesante saber que no cesa de no escribirse. Podemos incluso evocar un tercer pie, aquel que nos hace decir en supervisión lo que nos instiga porque no se muestra todo, nos provoca inquietud, y nos hace dudar de lo que suponíamos saber hacer.

El enigma nos hace esos dos, como decía Lacan: aquel que escucha y aquel que vuelve a la teoría cada vez. El enigma nos pone a trabajar, nos causa, nos provoca. Al final de un análisis, el enigma puede no hacer más sufrir, no más gozar de nosotros, pero, quizás, podamos gozar de él. Como escuché de una AE, hasta el punto de que el sueño ya no necesita ser escudriñado. Ahora, como analistas, seguimos haciendo de aquellos que se acuestan en nuestros divanes nuevos enigmas, que nos lanzan hacia el conocimiento incierto, cojeando, de la teoría, de nuevo. Al fin y al cabo, la verdad nunca se dice por completo; la palabra de Lacan no es definitiva, no nos trae certezas.

Es el fracaso frente al enigma lo que nos hace hacer piruetas, a cada retorno a la teoría, a cada nueva sesión, con cada significante que salta para ser escuchado enfáticamente nueva-mente.

Referencias

FREUD, S. (1900). Interpretação dos sonhos. *In: Obras Completas*, vol.4. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

JORGE, M.A.C. Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan, vol.2: a clínica da fantasia. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2010.

LACAN, J (1975-76). O Seminário, livro 23: O sinthoma. Tradução de Sergio Laia. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2007.

“El caso clínico: un tipo textual psicoanalítico”

Silvana Castro Tolosa

Psicoanalista. Magister en Psicoanálisis por la Universidad de Bs As. Docente e investigadora. Coordinadora Técnica del Servicio Asistencial de Extensión Universitaria "Clínica de Adultos I". Miembro del Foro Argentino del Campo Lacaniano, Polo Bs As. Miembro de la IF-EPFCL

“Soy de la opinión de que podría ser valioso para la ciencia y para el conocimiento de verdades religiosas, posibilitar cualquier tipo de observaciones sobre mi cuerpo y mis vicisitudes personales por parte de personas especializadas” señalaba Schreber allá por el 1900 en el prólogo a sus *Memorias* que hoy en día continúa siendo el libro más citado de la psiquiatría y del psicoanálisis.

Sostenemos que la escritura forma parte del trabajo del analista porque -desde Freud- reconocemos el *valor científico* de aquellas producciones que nos permiten reflexionar sobre la posición del analista, los avatares de las estructuras clínicas, así también como someter a revisión la propia teoría psicoanalítica en los diferentes contextos de nuestra práctica. Ese binomio *práctica y teoría* puede reversionarse en términos de *escucha y escritura* en el ejercicio de armado de un caso clínico, cuyo primer paso es el establecimiento de una lógica que, la más de las veces, se encuentra determinada por el síntoma.

Fue Schreber, un adelantado a su época, quien señaló ese valor científico, pero resultó ser Freud, autor del historial, quien destacó el precio de ese material para la comunidad psicoanalítica. Lo hizo al señalar que una de las características principales de las psicosis es su afán por testimoniar y al encontrar en esa verdad testimoniada por Schreber, la clave para plantear que el delirio es la respuesta elaborada por el sujeto frente a la enfermedad y no la enfermedad en sí.

Esa lectura tan esclarecedora como contundente está en la base de nuestra práctica y se la debemos a Freud, que según él mismo confiesa, no le temía a la crítica ni lo horrorizaba la autocrítica. En los párrafos finales del Historial, Freud cuestiona todo, hasta llega a pensar en la similitud del delirio schreberiano con su propia teoría sobre la movilidad de la libido y no nos evita, pero, sobre todo, no se evita él mismo, trazar un paralelismo que pudiera perjudicar su enseñanza. Freud se deja enseñar por Schreber y esa operación de lectura y escritura es -creo yo- relevada por Lacan al escribir su propuesta posible para todo tratamiento de las psicosis. Lacan nos indica no retroceder frente a las psicosis, pero no hay manera de avanzar si no volvemos a

Freud. ¿Qué enferma? ¿Qué soluciona? De eso se trata el Historial de Schreber, de una mirada que lo revolucionó todo.

En pleno desencadenamiento de la pandemia, a mediados del 2020, recibo con mucha urgencia una derivación por parte de una colega que me dice “se trata de una joven muy esquizofrénica, hija de una pareja que atiendo. Necesita sí o sí presencialidad, porque asume que la escuchan si habla por teléfono o se comunica por internet”. Recibo casi clandestinamente en mi consultorio a Carina, quien solo me habla de su trabajo en el club, de cómo ayuda a su madre en tareas domésticas y de que extraña jugar al tenis con su papá. Sus padres solicitan una entrevista conmigo y allí me cuentan que su hija fue diagnosticada como esquizofrénica hace unos 10 años, cuando luego de un robo nocturno en su casa, Carina quedó en un estado de shock del cual sólo salió diciendo cosas como “yo sabía que me iban a venir a buscar”, “todo esto está armado”, “ellos me iban a avisar”. La madre relata que todos los espejos de la casa tienen que estar cubiertos, que Carina duerme vestida (hasta con zapatillas puestas) y que se baña con la luz apagada. Todos los días, luego del almuerzo, Carina se dispone sobre el sofá del living y en posición fetal pasa un buen rato murmurando, a veces se mece y suele derramar algunas lágrimas. Su madre la abraza hasta que Carina se reincorpora, y el día continúa rutinario, lo más parecido a sí mismo posible. Así, todos los días desde hace 10 años. Ella, en las sesiones conmigo no menciona nada de todo esto, simplemente nada. Alguna vez que se enfermó y no pudo venir, aproveché para preguntarle qué tal le parecía ir al médico y cómo se llevaba con el estar enferma y solo me dijo “no puedo hablar de eso con vos, es por tu bien”.

Cumplidos unos 3 años de tratamiento, cerca de la fecha de su cumpleaños, Celeste me pide tener una sesión telefónica, en el mensaje dice: “hay algo que nunca te conté”. Al comunicarnos me cuenta que sabe que van a venir por ella nuevamente, y que está aterrada. Me pide que hable con su psiquiatra para que veamos cómo podemos ayudarla. Le pregunto acerca de eso que ella sabe y me dice “mi tía me dijo que nos encontraríamos en KILL para comprar mi regalo, y ahí yo me di cuenta de todo... muerte... están usando a mis seres queridos para mandarme mensajes”. Yo le respondí “yo no soy un ser querido”. Ella se rio mucho y me dijo “claro, por eso te estoy llamando”. Pasado un período de desestabilidad que remitió bastante rápido, Carina sólo quiere sesiones virtuales o telefónicas porque dice “que es mejor que nos escuchen y que todo quede grabado”. Si alguna vez recibe un mensaje, me pide vernos, pero en algún lugar público, no quiere que nos encerremos en el consultorio y que se piensen que no queremos ser oídas, que ocultamos

algo. Me dice “acá en el café, con el ruido que hay puedo contarte todo, ellos no nos van a escuchar”.

Si bien su momento diario de diálogos internos y murmullos continua, Carina pudo ir a la playa, ponerse un bikini. Cortarse el pelo y hasta maquillarse para el casamiento de su hermano. La otra semana me dijo “¿cómo aguanta la gente que no hace terapia? No se puede querer a todo el mundo, también hay que tener alguien con quien hablar de cómo te quieren todos”.

El testimonio *pasa* a manos de quien opera una lectura sobre él: el material clínico deviene caso clínico por esa operatoria de quien es una suerte de constructor del caso en su escucha. Escribir casos es dejarnos enseñar por quienes escuchamos.

“El problema del síntoma y la estructura en la clínica de la perversión”

Tomás Otero

Es psicoanalista. Doctor en Psicología y Magíster en Psicoanálisis por la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano y del Foro Argentino, Polo Buenos Aires.

La perversión se presenta en psicoanálisis como un campo insuficientemente delimitado, con una casuística exigua y una falta de consenso respecto al diagnóstico y la dirección de la cura que no es sin consecuencias en la clínica.

Me interesa plantear la idea de que en la práctica psicoanalítica no nos encontramos con las formas clásicas y floridas de la perversión, aquellas que tan bien ilustraron las plumas de Sade y de Sacher-Masoch. Como sostiene Deleuze el cuadro de signos que conciernen al sadismo y al masoquismo son “prodigiosos ejemplos de eficacia literaria”¹¹. Pues, los psicoanalistas nos confrontamos en el campo de la perversión con la siguiente pregunta: ¿Cómo separar el caso de la literatura, si en ningún otro campo clínico la obra literaria nos mostró con mayor claridad las formas que encarna el deseo en la perversión?

No hay en la obra de Freud ni en la enseñanza de Lacan un solo caso paradigmático de perversión que nos enseñe el modo en que la particularidad del síntoma dilucidado bajo transferencia responde a la estructura, a diferencia de las neurosis y las psicosis. En consecuencia, tomando por premisa que un análisis comienza por la puesta en forma del síntoma propongo desplegar la siguiente pregunta: ¿En la clínica de la perversión podemos delimitar un tipo de síntoma que representa a la estructura?

1) El primer punto a zanjar es el alcance que tiene el mecanismo de la *Verleugnung* para dar cuenta de esta estructura.

Se ha hecho un estandarte de la desmentida como el mecanismo fundante de la subjetividad perversa y esto tiene su resorte en el célebre texto de Freud sobre el fetichismo de 1927. Es conocida por todos la tesis de que el fetiche se fija como el sustituto del falo materno y que esta operación lleva por premisa la desmentida de la castración, lo que deja como efecto una escisión en el yo que responde a ambas posiciones que asume el sujeto frente a la castración –la negación y la aceptación.

¹¹ Deleuze, Gilles (1967) *Sacher-Masoch y Sade*. Ed. Universitaria de Córdoba, Córdoba, 1969. p. 15.

Un poco más que una década después del texto sobre el fetichismo, en el capítulo VIII de *Esquema de psicoanálisis* (1940[38]) Freud vuelve sobre el tema y afirma con todas las letras que la *Verleugnung* y la *Ichspaltung*, no son para nada exclusivas del fetichismo sino que éste es solo un objeto particularmente favorable para su estudio, extendiendo la desmentida y la escisión del yo a otras constelaciones de la vida anímica por fuera del fetichismo.

Es notable que cuando Lacan retoma el trabajo de Freud sobre el fetichismo en el *Seminario 4* desplaza la lógica de la *Verleugnung* a la *función del velo* donde se proyecta la imagen que se eleva a título de fetiche. Lacan no solo no habla de *Verleugnung* en las coordenadas del fetichismo sino que en el momento de la historia en que la imagen se detiene en la antesala del horror, él lee allí los signos de la represión¹².

Por lo demás, en oposición a una larga lista de teóricos del psicoanálisis que han insistido en reducir la subjetividad perversa al paradigma fetichista bajo la premisa de concebir la *Verleugnung* como el mecanismo específico de la estructura, y el fetichismo como síntoma patognomónico de la perversión me parece un salto estéril que carece de justificación argumental ubicar el mecanismo de la desmentida como fundante de dicha estructura.

2) El segundo punto a destacar es el modo en que se articula para Lacan el síntoma en la perversión. En el seminario dedicado al *Witz* Lacan nos va a remitir a un notable trabajo de Hanns Sachs “Génesis de las perversiones” de 1923 para decir: “Todo el artículo de Hanns Sachs sobre la génesis de las perversiones está hecho para mostrar que hay en toda formación llamada perversa, sea cual sea, exactamente la misma estructura de compromiso, de elusión, de dialéctica de lo reprimido y de retorno de lo reprimido que en la neurosis”¹³.

La pregunta que se desprende entonces es si aun articulándose bajo la dialéctica de la represión y el retorno de lo reprimido el síntoma del sujeto perverso guarda alguna particularidad que permita discriminarlo del síntoma de la neurosis. Si así fuera esa particularidad no ha sido especificada ni en la obra de Freud ni en la enseñanza de Lacan.

3) Y el tercer punto es distinguir el síntoma en la perversión respecto a la puesta en escena del fantasma que más bien escamotea la propia división del sujeto perverso. Pues, mientras la

¹² Cf. Lacan, J. (1956-57) *El Seminario. Libro 4: La relación de Objeto*. Paidós. Bs. As. 2007. p. 160.

¹³ Lacan, J. (1957-58) *El Seminario. Libro 5: Las formaciones del inconsciente*. Paidós. Bs.As. 2005.pp. 241-42.

defensa funciona, el perverso lleva a cabo su actividad en regla con su fantasma en la mira de que su división de sujeto sea transferida al campo del Otro. Esta es la situación de la perversión por antonomasia, cuando la respuesta que ofrece el fantasma sirve como autotratamiento a la propia división subjetiva y no lo sintomático de la estructura que en todo caso acontecerá cuando esa respuesta vacile o sea conmovida.

Ahora bien, sabemos que Lacan sostiene que el síntoma representa a una estructura¹⁴, que hay tipos de síntoma, y que esos tipos clínicos responden a la estructura¹⁵.

No obstante, despejado que el fetichismo sea un síntoma típico de la perversión como argumenté antes, a nivel del síntoma en la perversión no hay una particularidad que permita el diagnóstico bajo transferencia como podemos situar a nivel de la conversión en el síntoma histérico, el pensamiento que embaraza al alma¹⁶ en la neurosis obsesiva, el miedo en la fobia, el delirio en la paranoia, el lenguaje de órgano en la esquizofrenia o el dolor de existir en estado puro en la melancolía, que representan a estos diferentes tipos clínicos.

Está claro que podríamos tentar un diagnóstico de perversión de acuerdo a la posición que el sujeto asume en su fantasma o frente al Otro bajo transferencia. La pregunta que se desprende como corolario y que quisiera abrir al debate es si podemos arribar a un diagnóstico de estructura subjetiva perversa sin un síntoma típico que responda a ella.

Referencias

- Deleuze, Gilles (1967) *Sacher-Masoch y Sade*. Ed. Universitaria de Córdoba, Córdoba, 1969.
- Freud, S. (1927) “Fetichismo”. En *Obras Completas*. Amorrortu . Vol XXI. Bs. As. 2006.
- Freud, S. (1940[38]) “Esquema de psicoanálisis”. En *Obras Completas*. Tomo XXIII. Amorrortu. Bs. As., 2010.
- Lacan, J. (1956-57) *El Seminario. Libro 4: La relación de Objeto*. Paidós. Bs. As. 2007.
- Lacan, J. (1957-58) *El Seminario. Libro 5: Las formaciones del inconsciente*. Paidós. Bs.As. 2005.
- Lacan, J. (1966-67) *El Seminario. Libro 14: La lógica del fantasma*. Paidós. Bs. As.2023.
- Lacan, J. (1973) “Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los Escritos”. En *Otros escritos*. Paidós. Buenos Aires, 2012.

¹⁴ Cf. Lacan, J. (1966-67) *El Seminario. Libro 14: La lógica del fantasma*. Paidós. Bs. As.2023. pp.324-25.

¹⁵ Lacan, J. (1973) “Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los Escritos”. En *Otros escritos*. Paidós. Buenos Aires, 2012. p. 583.

¹⁶ Cf. Lacan, J. (1973) “Televisión”. En *Otros escritos*. Paidós. Buenos Aires, 2012. p.538.

Lacan, J. (1973) "Televisión". En *Otros escritos*. Paidós. Buenos Aires, 2012.

MESA 4 - PRESENTACIÓN DE CASOS A

Ana Díaz Patrón (FA-Salta)

La clínica que interroga al quehacer del analista

Rosana Maldonado Torres (EPFCL- FCL Río)

El pasado me condena

Viviana Venosa (EPFCL- FCL São Paulo)

¿Cómo leer la letra?

Julia Minaudo (FA-BA)

El caso, un problema “de ...dos”

Soledad Carro (FA-Patagonia)

El pasador... ¿un analista?

“La clínica que interpela al quehacer analista”

Ana Díaz Patrón

AME de la EPFCL. Integró diferentes dispositivos de la IF-EPFCL, como CRIF, CR, COLAGE, dispositivos locales de Escuela. Fue miembro fundador y coordinadora del Polo Salta. Enseñante del Colegio Clínico del Polo Salta desde el año 2007. Practica el psicoanálisis en la ciudad de Salta.

Las palabras de una paciente, cinco años después de un final abrupto, “Vengo a agradecerte por lo que hiciste por mí, por todo lo que me ayudaste. Vos no te das cuenta, pero me ayudaste muchísimo”, me sorprendieron y, luego, me llevaron a repensar este caso en el que había sido puesta en jaque por lo real de la clínica y obligada a implementar movimientos en este sentido. ¿Qué había hecho como analista para ayudar a esta paciente que apenas atendí por dos meses, con un corte final sentido como fracaso?

Bárbara venía de un largo tratamiento por anorexia y bulimia, mal-tratada, sobremedicada, diagnosticada como psicosis, y coagulada en el significante “enferma”. Intenté acompañar una baja de medicación, devolverle la palabra, escuchar a un sujeto que no era escuchado, y al mismo tiempo intentar una separación de ese significante que la marcaba.

Había terminado unos pocos meses antes ese tratamiento, pero continuaba con medicación psiquiátrica. Accedí a un pedido de ella de acompañar una baja de medicación. Yo había seguido ese tratamiento a través de la madre, mi amiga, y sabía de ciertas maniobras de control, encierro, sobremedicación, cometidas por el equipo actuante. Lo pensé como un desafío y una oportunidad de poder ayudar desde otro lugar a una persona tan mal-tratada.

Me comuniqué con la psiquiatra de Bárbara sobre la posibilidad de bajar la medicación, respondió negativamente, subestimando mi saber porque “yo no sabía de los neurotransmisores, que seguramente era psicoanalista y, peor aún, lacaniana”. Y cortó el tel.

Ante eso, decidí apelar a un médico clínico, además médico de la familia de Bárbara quien aceptó atenderla para disminuir las dosis de antidepresivo, ansiolítico y antipsicótico.

Comencé a atenderla y me encontré con un sujeto que se dejaba maltratar, con miedo a la mirada del otro, a lo que ésta pudiera decir de ella, y con inseguridad en el tema del cuerpo. Y con

una madre feroz que culpaba, vigilaba y controlaba a través de la mirada, que exponía la intimidad de su hija ante otros, y que usaba la medicación como amenaza: “(Ella) me hace sentir que la necesito y no quiero vivir más con pastillas”, decía Bárbara. La madre sostenía el lugar de enferma de su hija, había tomado el cuidado de su hija “enferma” como forma de justificar su existencia. Y enferma era, justamente, ese lugar al que Bárbara estaba fijada.

Un padre proveedor, que no quería que falte nada, a quien muchas veces había sentido como defensor del control materno. Su problema de anorexia comenzó a los 14 años, momento en que tomó una campera del padre para usarla todo el tiempo escondiendo el cuerpo debajo de ella, pero las miradas seguían estando. Dejó de comer “y ahí empecé a estar en boca de todos”, dice. Entonces decidí apelar al padre para que acompañara a su hija, y respondió de manera contenedora y amorosa con ella.

Una noche, llamó la madre de Bárbara a mi teléfono particular, denunciando algo de su hija, entonces le pedí que me pasara con ella, y cuando atendió hubo este diálogo:

- ¿Cómo estás Barbara?
- Bien, dijo
- ¿Está todo bien?
- Si, todo bien
- Bueno, nos vemos el lunes en el consultorio.

Y corté. E inmediatamente, el teléfono comenzó a sonar sin parar, no atendí. Lo que se deslizaba por debajo de este movimiento era, “No escucho a tu mamá, te escucho a vos”, dando estatuto de sujeto a alguien puesto en lugar de objeto a maltratar, invadir, controlar, manipular.

Como efecto de esto, se dio un movimiento subjetivo en Bárbara, decía “Nunca me hice valer”, “Me dejaba maltratar por mis amigas”, “Siempre tenía que dar explicaciones como mi hermana” “Pero ahora ya no doy explicaciones”.

Estaba como petrificada en una imagen, y la mirada devolvía o decía de esa imagen. “Siempre quise que me miren pero cuando camino en la calle siento que pasa una cosa caminando

y no me gusta. Soy como una muñeca”. Como había comenzado con un taller de pintura, le propuse que pague con pinturas, ya los padres pagaban con obra social.

Esa maniobra estaba dirigida al objeto mirada, comenzar a ser mirada por algo de otro orden que por un cuerpo. Que pueda dar valor a una creación propia y ser mirada desde su propia producción.

Poco después, fue internada por sobreingesta de medicación. Según el médico del hospital, no era una cantidad importante, y los padres lo trataban como intento de suicidio. El médico clínico me planteó abandonar el caso, le rogué que continuara, que no se trataba de una psicosis, que iba a salir. Finalmente aceptó continuar atendiéndola.

Bárbara relató que unos días antes de ese episodio, en una fiesta familiar escuchó a unas señoras comentando acerca de ella como enferma. Y agregó, “Siempre voy a ser la enferma” “Y si la gente ve eso, debo ser eso”.

En ese momento intentó desaparecer, trató de esconderse. “Yo me propuse cambiar, pero vuelvo a lo mismo. Trato de creer que no soy enferma ni loca.” Un salirse de la escena ante la angustia desbordante fue lo que llevó al pasaje al acto.

Se sentía estancada y encerrada, desde hacía bastante tiempo. “Quiero empezar a salir pero me da miedo, ir a todos lados sin pensar que me están mirando. Me parece que es un cambio que hay que hacer de un día para otro; decir ¡Basta!”.

Luego de esto, una segunda internación también por ingerir pastillas, esta vez en la UTI. El médico clínico dijo que hasta ahí llegó, no intenté convencerlo de nada, y le expresé que yo también dejaba. Entré a terapia y le dije a Bárbara “Por disposición del sanatorio, de aquí tendrías que salir con un psiquiatra. Hasta aquí llegué yo”.

Me miró fijamente y me dijo:

- Pero yo no estoy loca
- Sí, lo sé, pero vas a tener que demostrarlo

La saludé y me fui. No la ví más ni supe de ella hasta cinco años después.

Pensé que esta última maniobra, la más significativa, a la manera de corte final, puso en ella la responsabilidad de su acto, de su goce y las consecuencias, al dejar de sostenerla, y lanzándola a hacerse cargo de su propio deseo. Fue una apuesta analítica para producir algún efecto por el vacío generado por esta intervención, que posibilitó que continuara trabajando el “a” como causa de deseo, impulsándola a generar un modo singular de sostenerse más allá del Otro.

La clínica muchas veces nos pone en lugares incómodos, inciertos. Pero si el deseo del analista está presente, algo puede operar. Incluso en el silencio, incluso cuando creemos haber fracasado, algo puede advenir.

“El pasado me condena”

Rosana Maldonado

Psicóloga. Psicoanalista, Máster en Psicoanálisis y Práctica Clínica de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano en Brasil. Miembro del Foro del Campo Lacaniano de Río de Janeiro. Profesora y supervisora del programa de posgrado en Psicología de la Universidad Santa Úrsula.

El caso involucra a un joven adulto quejándose de que sólo toma decisiones financieras que lo llevan a deudas impagables. Este caso clínico ilustra el desencadenamiento de la neurosis de este sujeto, a partir de una experiencia traumática vivida en la infancia.

Refleja a un neurótico obsesivo que presenta goce en su estructura funcional con gran parte de los síntomas en la esfera psíquica, una verdadera patología intelectual, tal como la describe Freud.

Fred, de 27 años, llega a las sesiones angustiado porque no puede trabajar y ganar dinero, hasta el punto de contraer deudas perjudiciales. Él relata que compró un auto para hacer entregas del producto que vende, pero no fue una buena compra. Pagó un precio bajo por este auto, pero solo le trajo pérdidas teniendo que pagar el doble para arreglar todos los problemas que tenía el auto.

Fred cuenta su historia desde pequeño, dice que siempre tuvo problemas, pero de otro tipo. Comienza a relatar episodios de consumo de drogas como marihuana y cocaína en su adolescencia, y líos que tuvo con malos “amigos” en la calle. Fue detenido en albergues por ser menor de edad. Lo que cuenta parece ir en contra de sus orígenes, en contra de los estándares de su familia de clase media alta. Hay muchos detalles en la historia, pero aquí nos centramos en la experiencia traumática infantil, que se revela a lo largo de las sesiones, y las consecuencias de ésta.

Le pido a Fred que me diga si tiene alguna idea de por qué tuvo tantos problemas durante su adolescencia. Él revela que terminó volviéndose algo disfuncional, como resultado de la separación de sus padres cuando era un niño y que su madre era una persona algo voluble y depresiva. Me cuenta detalles de su primera infancia, y luego menciona un episodio que dice que fue bastante traumático, pero que había intentado trabajar a lo largo de su vida, que era solo un niño y no tenía culpa de nada.

Cuenta que cuando tenía 8 años estaba en una finca que era propiedad de la familia con su hermano de 6 años, que ese era un lugar que lo hacía muy feliz, donde salían a jugar todos los días. Se sintió

como un mentor para su hermano menor y le enseñó cosas. Cuenta que un día, como de costumbre, despertó a su hermano muy temprano en la mañana y lo llevó a pasear y a explorar los campos alrededor de la enorme granja. Ese día sucede algo terrible. Él y su hermano están en un lugar determinado y su hermano es atacado por un animal. Su hermano muere a causa del ataque mientras Fred intentó desesperadamente pedir ayuda. Dice que en ese momento se sintió extremadamente culpable por haber dejado a su hermano morir solo, por no haberlo podido salvar. Dice que lo superó yendo a terapia durante años y años, y que en la terapia llegó a la conclusión de que no era culpable, porque le seguían diciendo: “eres solo un niño, no tienes ninguna responsabilidad”. Concluyó que no fue negligente, porque los responsables de los jóvenes deberían serlos adultos y los padres. Esto fue trabajado extensamente en terapia con el objetivo de eliminar el sentimiento de culpa que lo abrumaba.

Lo que queremos destacar aquí es lo que le sucedió a este joven después de que racionalizó que no tenía la culpa y los efectos de reprimir el trauma. Fred de alguna manera había olvidado la importancia de este evento en su vida.

Lo que se olvida se vive y se actúa, nos revela Freud. El paciente no recuerda nada de lo que ha olvidado y reprimido, sino que lo expresa mediante sus actos. Lo reproduce no como un recuerdo, sino como una acción; lo repite, sin saber que lo está repitiendo (Recordar, Repetir y Elaborar, 1914). Al final, Fred, sin darse cuenta de lo que se está haciendo a sí mismo, se castiga con su cruel Superyó.

En una incesante satisfacción gozosa. Fred pasó toda su adolescencia siendo arrestado y castigado repetidamente en un intento de pagar el precio de la culpa de haber dejado morir a su hermano. Como nos muestra Freud en el texto *Yo y el Ello*, 1923, en el sujeto neurótico triunfa el sadismo del superyó combinado con el masoquismo.

Desde los 17 años ya no estaba preso, sabía que el proceso y el castigo eran más complejos porque ya era casi mayor de edad, su padrastro era abogado y le había informado de ello. Después de los 18 años, desplaza su síntoma de deuda al Otro, a pagar realmente con dinero... contrae deudas impagables. Desde entonces, ha sido un fracaso, sin darse cuenta de que su fracaso es consecuencia de sus propias acciones contra sí mismo.

En el análisis se da cuenta de ello y queda horrorizado por lo que ha hecho con su vida hasta ahora. Al igual que Edipo, tiene todas las pruebas de ello, pero no puede verlas. En la tragedia de Edipo tenemos el coro señalando incesantemente la verdad del sujeto y sus acciones en el inconsciente. Con Fred, las terapias eran menos un coro y más alienantes al excusarlo.

A esto se suma su deseo infantil de aniquilar a su hermano menor, cuando su madre queda embarazada y poco después su padre se separa. La idea fue reprimida en ese momento, la idea él diría que su madre sería solo suya... la culpa de este deseo incestuoso aumenta desde el momento en que este hermano se vuelve querido para él, su gran compañero de aventuras y culmina con la muerte de su hermano (el deseo que había existido fue reprimido y solo apareció la “doble” culpa)

Entonces, cuando su hermano muere, la culpa es abrumadora, pero sólo tiene que convencerse de que no tiene la culpa porque es un niño pequeño según todos los que lo rodean... Esto es lo que se excluye de la cadena de significado, pero alrededor de lo cual gira la cadena. Él analizando da vueltas y vueltas intentando articular lo que parece estar en cuestión, pero es el analista quien señala el camino. El psicoanálisis da voz, palabras, discurso al sujeto que lucha contra sus acciones dañinas, tendientes a lo peor... dándole así posibilidades de elaborar su responsabilidad por sus elecciones, y le da la posibilidad de ser agente de lo que hará con lo que ocurrió en su vida y su destino... ¡el psicoanálisis pasa por una cuestión ética y no moral!

“¿Cómo leer la letra? Sobre la letra que hace la diferencia”

Viviana Venosa

Graduada en Psicología por la Universidad de São Paulo. Máster en Psicología por la misma institución, con la disertación: «El acto de cortarse: una investigación psicoanalítica», sobre autolesiones sin intención suicida. Es miembro del Foro del Campo Lacaniano de São Paulo y actualmente forma parte del Colegiado de Delegados (2025-26). También trabaja en consultorio privado. Y trabajó durante ocho años en un servicio público de Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Dándose a leer, como la posición analizante a través de sus dichos. Hace que el analista responda, con su presencia de voz, a las versiones del analizante, abriéndose al desacuerdo *del desfrute la lectura*¹⁷ de la pérdida de sentido. Si el cuerpo se organiza, el sexo de la no relación sexual da relevancia y *designa* al vacío de la pérdida, sabiendo hacer caer-allí-una-letra-que-cambia. Un “toma y daca” de su modo de goce, de lo que se ha dado por pérdida.

«*Dar a letra*» es una expresión idiomática en nuestro idioma brasileño que significa algo así como «enseñar el camino». En medio del camino suele haber más de una piedra. ¿Cuál sería el camino de la letra (*chemin de l'être*)? Un camino liso, no és. Para quien no lo sepa, «camino liso» es el nombre de un antiguo folleto de alfabetización en Brasil. Pero la letra no é fáciles de leer. Como dice la letra de la canción brasileña del grupo Secos e Molhados: «Simple e suave coisa, suave coisa nenhuma»

Ahora bien, si el deseo es la falta, en el campo del Otro, con la que me hice interpretar, ¿quién me dio l'être? Y la carta que la letra escribe a (su) destino, ¿se lee?

"Pero, ¿cómo debe tomarse aquí esta letra? Sencillamente, literalmente. Llamamos carta a este soporte material que el discurso concreto toma prestado del lenguaje." ¹⁸ . La letra como soporte material del significante da sentido a través de la cadena significante. Así, a través del lenguaje, la letra da la letra del lugar del sujeto en la fala.

¹⁷ NT: Aquí, la autora ha utilizado un neologismo portugués que combina desfrute con lectura: *deleite + leitura = deleitura*.

¹⁸ Lacan, J. A Instância da Letra ou a Razão desde Freud, in: Escritos, RJ: Zahar, p. 498.

Cito a Lacan en el Seminario 19: "En este caso, el verbo no es difícil de encontrar: basta con cambiar la letra con la que empieza la palabra peor [*pire*], lo que significa decir [*dire*]. Sin embargo, en lógica, el verbo es precisamente el único término para el que no se puede hacer un lugar vacío. De hecho, cuando intentas hacer una función a partir de una proposición, es el verbo el que crea la función, y es a partir de lo que lo rodea que puedes hacer un argumento. Entonces, al vaciar este verbo, lo convierto en un argumento, es decir, en una sustancia. No es un dicho, sino un argumento"¹⁹.

Adverbio - verbo: *pire* - *dire*; LA LETRA CAMBIA. La letra cambia: el verbo se elide, no completamente, por lo que puede leerse como la letra p del adverbio *pire* (peor) dando medio salto mortal, dando la vuelta al pie de la letra en el verbo *dire* (decir). Un adverbio es una palabra que indica una circunstancia (estado de ánimo, lugar, tiempo). Puede modificar a un verbo. Las palabras adverbiales, con el prefijo *ad*, que significa «junto con», van unidas al decir del verbo, *ça ne va pas sans dire*, es decir, los adverbios no van sin *Un-decir*.

El malabarismo lacaniano funciona con el matema de la letra, lógicamente, y le hará decir casi un año más tarde que «(...) en el discurso analítico sólo se trata de esto, de lo que se lee, de lo que se lee más allá de lo que usted ha incitado al sujeto a decir.»²⁰ Y más adelante, en la misma lección, menciona el discurso filosófico, advirtiendo de los riesgos de caer en una ontología. Es entonces cuando Lacan nos recuerda el uso del verbo copulativo: el verbo *ser*. Es interesante pensar cómo este verbo -*ser*- insiste en producir una cópula. Aquí, creo que es precisamente porque no logra la cópula: «esto es lo que es», que el verbo *ser* -por lógica- conlleva el dicho de la no relación sexual. Pero, a través del discurso del *M'être*, esto podría pasar desapercibido, si no fuera por la letra. Y Lacan se pregunta: «¿Cómo volver si no es a partir de un discurso especial?»²¹. La cita:

Toda dimensión del ser es producida por algo que está en la línea, en la corriente del discurso del amo, de aquel que, al pronunciar el significante, espera de él lo que es uno

¹⁹ Lacan, J. (19) Seminário Livro 19 – “... ou pior”, in: RJ, Zahar, p.12

²⁰ Lacan, J. (19) Seminário Livro 20 – Mais Ainda, in: RJ, Letra Freudiana, p. 91

²¹ Lacan, J. (19) Seminário Livro 20 – Mais Ainda, in: RJ, Letra Freudiana, p. 98

de sus efectos del bucle, (...) lo que está hecho de esto, que el significante manda, el significante es, al principio, y por su dimensión, imperativo.

(...) Y es en esto en lo que es importante darse cuenta de qué está hecho el discurso analítico, y no ignorar lo que sin duda sólo tiene ahí un espacio limitado, es decir, que se habla de lo que el verbo 'coger' enuncia perfectamente, se habla de 'coger' -el verbo en inglés *to fuck*- y ahí se dice que esto no va bien.

Ahora, si existe una dimensión del imperativo en el significante, podríamos resumirla como: «Has hablado, has cogido: *il n'y a pas de rapport sexuel*»? Teniendo en cuenta la insistencia en el hecho de que no hay metalenguaje para el campo psicoanalítico, el significante amo dicta el ser de manera imperativa: ¡es! ¿Es esto lo que Lacan indicaba cuando mencionaba que el significante es la causa del goce, introduciendo la dimensión de la sustancia gozante en la causalidad, en un nuevo giro en relación al objeto a como causa del deseo? En el mismo seminario 20, Lacan menciona la experiencia psicoanalítica: "¿No es ahí donde se supone que está la experiencia psicoanalítica? - la sustancia del cuerpo, a condición de que sólo se defina como aquello de lo que se goza",²²

Así que propongo aquí, a modo de conclusión, algo así como: el verbo «ser» es sólo una letra cuando se escribe como «l'être» en francés. La audacia aquí reside en la idea de que, como función gramatical, el verbo sólo *d'enuncia* la no relación. Y que, en el decir de los analizantes, podemos leer tal vez el decir de su hacer. Si, como verbo ser, no se hace nada, sólo se es. ¿Qué puede leerse como «hacer» articulado con el verbo «saber», como lugar de verdad en el discurso psicoanalítico?

Por lo tanto, sin renunciar al significante, la letra puede pensarse como verbo, permitiendo una escritura lógica que circunscribe la práctica psicoanalítica como propuesta de tratamiento sui generis, en la singularidad de cada caso, pero también la praxis de la teoría como discurso que lleva su marca de diferencia.

²² Lacan, J. (19) Seminário Livro 20 – Mais Ainda, in: RJ, Letra Freudiana, p. 79.

“ El caso, un problema de ...dos”

Julia Minaudo

Licenciada en Psicología. Docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA): cátedras de Psicopatología II y Clínica, Psicoterapias – Clínica de Adultos I. Investigadora UBACyT (Universidad de Buenos Aires, Ciencia y Técnica). Miembro de FACL – Polo Buenos Aires y de la Escuela de la IF-EPFCL. Ha sido enseñante en diversos Colegios Clínicos. Integra equipos interdisciplinarios en hospitales. Supervisora de residentes. Experiencia en Psicología de internación psiquiátrica y coordinación de grupos terapéuticos. Ha presentado numerosas conferencias y exposiciones teórico-clínicas. Ha publicado artículos en libros, revistas, y en congresos nacionales e internacionales y jornadas de investigación. Coautora del libro *Alzar la voz. Incidencias clínicas del incesto* (2020).

El caso no se reduce a un suceso, ni pretendemos que nos de cómo saldo un estado cerrado y definido de un problema subjetivo.

El psicoanálisis propone desde sus inicios al caso como apertura con varios niveles:

- A la verdad del inconsciente
- A construir coordenadas clínicas que dan andamiajes y timón para otros casos.
- A vaciar de sentidos gastados que nos propone la sociedad de turno.
- Que un caso y otros que resuenan en sus repeticiones, aunque singulares, son el punto de partida como lugar donde se resguarda, justamente, la ética que afirma fuerte que ninguna teorización por sí sola nos autoriza a cerrar un caso.

Los analistas vivimos soportando pertinentemente una práctica dialéctica entre lo singular y lo particular siempre viva, novedosa y móvil.

Un problema de... dos

Una paciente tomada en su totalidad por una inhibición sexual con su pareja actual, como había sucedido también con otras. La inhibición se circunscribía en torno al momento de ser tocada en las partes genitales. No era rechazo, sino se presentaba algo imposible de insinuar, menos aún de pedir a su pareja de años de relación. Al desplegar las coyunturas de este punto, dice “siempre fue así, no me animo a pedir ni hablar en ese momento. Fingí tanto tiempo que la paso bien que ahora no le puedo pedir eso, porque se daría cuenta”. De esta manera justificaba un círculo cerrado sin salida que implicaba normalizar y acomodarse a ser una eterna simuladora. Esta era su defensa.

“¿Tendré un problema orgánico o físico?” Me preguntaba. Ante esta demanda, la maniobra fue abrirlo como una inconsistencia donde su cuerpo no estaba cancelado sino que respondía a coyunturas singulares. Su organismo podía llegar al orgasmo exclusivamente con la masturbación y a solas. Le era imposible de lograr aquel estado con su pareja. Aquí aparecía el detenimiento de las asociaciones y ella proponía una demanda directa al analista preguntando una y otra vez por cómo solucionarlo.

La incomodidad se presenta en el análisis en este caso por la repetición de lo que no cesa, lo que no se inscribe. No había perspectiva de un trabajo analítico por largos años. Los intentos de intervenciones y preguntas que apuntaban a lancen la regla fundamental eran una constante. Ello despertaba en el analista el sentimiento de perder herramientas, la sensación de impotencia.

Sí se pudo recortar a partir de unos sueños la mirada paterna que siempre aparecía como “penetrante” y con una carga clara de acusación moral, que le generaba una culpa por sus prácticas masturbadoras infantiles y juveniles. Sentimiento completamente en contra de sus creencias y militancia política ya que, en otro plano, ella luchaba por la libertad de las mujeres.

Sin solucionar lo que llama su problema sexual, se separa de su pareja en la cual gobernaba una relación avara en todos los aspectos de la vida, de la demostración de amor, de la relación con el dinero y la impotencia de generar proyectos. Al tiempo conoce a un hombre decidido, que la elige sin vueltas. Ella no sin la angustia que se bordea en vivir el vértigo de una vínculo que funciona. Queda embarazada rápidamente. Demasiado rápido como para aceptar sin que entre el conflicto su lucha política feminista, por un lado, y por otro, sus ganas constatables de continuar con el embarazo. Su temor protagonista era qué iban a decir sus compañeras de militancia, porque no podía expresar con contundencia su alegría, reculaba. El desafío por momentos más cruciales de un análisis es cuando lo real muestra anticipadamente lo por lo que se optaría sin las ataduras neuróticas. Su novio le dio la libertad de elegir asegurándole que él si estaba decidido y quería tenerlo. Ella decide continuar con el embarazo y avanza.

Hoy es una madre muy amorosa. Como sabemos en muchas ocasiones ser madre o padre abre un portal a la propia infancia sobre todo a cómo fuimos cuidados y criados.

Es en este tiempo que en ella se despierta un temor nuevo con la forma de idea obsesiva;

su hija puede ser vulnerable a que le hagan cualquier cosa: “no sabe, es inocente pequeña e inconsciente”. Un día escucha a su padre, ahora abuelo jugando con su hija en el primer piso de su casa. Lo escucha cantar “un dedito, dos deditos, tres deditos”. Un poco angustiada, siente la necesidad de ir a ver qué pasa.

La regla fundamental al fin empieza a rodar y se despliegan asociaciones en forma de recuerdos:

- 1) Relata un encuentro informal de muy corta duración con un hombre que le dice en la intimidad con intenciones seductoras: te meto un dedo, dos dedos..... ella se va del lugar sin darle explicaciones espantada muy angustiada sin entender porque el significante “dedos” la desarma.
- 2) Ante el señalamiento del analista con el significante “de-dos, que no es de a uno” . por fin un recuerdo infantil que desestimado y sospechosamente despojado de afecto intenta pasar desapercibido y camuflado en la forma de una mera anécdota graciosa, es pescado por el analista forzando al analizante hacia las puertas de la Otra escena. Como al pasar, relata una constipación infantil preocupante que llega al punto de llevarla al médico para solucionarlo; no puede recordar si el médico la revisa. Al parecer le da una técnica de presión entre los orificios ...no tiene claro que pasó en ese consultorio. Supone que su mamá intenta primero sin éxito y después, sí recuerda que es su papá quien hace la presión con los dedos, lo que le generó la posibilidad de evacuar el intestino. Recuerda el festejo familiar.

“Recurar”, dice de su posición subjetiva, da nombre a su inhibición: “postergué cosas propias; siempre pienso algo y no lo hago, reculo... hay algo en mi cuerpo que no se termina de acomodar”.

Fue necesario un trabajo preliminar de varios años de escucha, no sin pasar el analista por el sentimiento de haber agotado las armas para intervenir hacia la apertura del trabajo analítico/clínico.

Uno ejercita la paciencia de la araña teje y espera expectante, abstinentemente pero activo, a veces por mucho tiempo, diría. ¿Por qué soportamos hasta ese punto y más? Tener la posibilidad de desdoblarse y sostenerse gracias a la fuerza que nos otorga la sensata política freudiana, allí creo que es la clave de nuestra inspiración. El porqué sólo puede decirlo cada uno, en su propio caso singular... Pero el cómo lo sabemos: en la persistencia del analista quien se ofrece a recibir a quien consulta para transformarlo en analizante.

Aquí hay satisfacción para el analista también, con la apertura del espacio hacia poder captar las expresiones efectivas del síntoma, las que nombran al sujeto en lo más singular, irreproducible en otro particular.

Allí cada uno de nosotros que no deja de ser un sujeto deseante al clinicar con la experiencia encuentra satisfacción en su labor, al fin! La finalidad de análisis se pone en juego. En un tiempo otro construimos clínica ... tiempo dos y no sin tres. La terceridad de la transferencia en la experiencia, la terceridad de compartir aquí con otros (ustedes) aunque sea unos pequeños esbozos de nuestros analizantes a los que le dedicamos buena parte de nuestra vida. Acaso no es fundamental encontrarnos para sentir aunque sea la ilusión de que hablamos el mismo idioma camuflado en distintas lenguas?

“El pasador ¿un analista?”

María Soledad Carro

AP Miembro de la Escuela de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. Miembro fundadora del ex Foro Patagónico, actual Polo Patagonia. Miembro del Foro Argentino EPFCL ALS. Enseñante del Colegio Clínico de la Patagonia.

Cometí el error de escribir primero el resumen, porque los tiempos apremiaban, antes que el texto completo para este Simposio. Entonces, si lo que trae dificultades suele ser el recorte, ahora la dificultad reside en desarrollar esa idea, “ser el clínico” de mi propio texto.

Remitiéndome a la experiencia como pasadora, insiste la pregunta de si el pasador es un analista. Decía que hizo falta tiempo para diferenciar estas funciones en el dispositivo del pase. Lo difícil de establecer esa diferencia es que suelen estar anudadas, moebianamente. ¿Por qué?

El pasador es un analizante, alguien que ya ha recorrido los vericuetos de su fantasma en análisis y que tal vez ha tenido la fortuna de encontrar allí el corte que desata su encadenamiento al síntoma, por ende, la demanda que sostiene el Sujeto supuesto al saber comienza a debilitarse. A partir de ahí surge otra demanda: ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo abandonar ese lugar?

Podemos pensar que Lacan se hizo esta pregunta, y para responder, propuso un juego: el dispositivo del pase. Como todo juego requiere que sus participantes lo tomen con la seriedad y responsabilidad que requiere para sostenerlo, cada uno en su función.

En mi pueblo había un chiste en el que alguien mandaba a otro a comprar “agujeros para un colador”. Un absurdo, que a mi me sirve para ubicar la función del pasador.

El pasador es el pase, eso es lo que se espera desde La Escuela. ¿Cómo se escucha un agujero y cómo se pasa? Quizá lo que pasa al pasador son los bordes de ese agujero. Si el pasador ha atravesado ese agujero o si se encuentra en ese atravesamiento, tal vez eso no lo sorprenda en el decir del pasante, pero deberá inventar un modo para hacerlo pasar, una ficción que lo incluya, prestando fidelidad y su voz a lo escuchado.

No es el dispositivo analítico, pero tiene sus semejanzas. El pasador no es un analista, no interpreta, pues ese trabajo ya está hecho. Pero hay una invitación a jugar ese lugar, estar a la altura conlleva una escucha desprejuiciada, atenta, y si es posible que no busque nada allí, sino que encuentre.

El pasador vuelve a su lugar analizante, otra vez atrapado en su división, atento ahora a responder a una demanda. En este sentido, se pone en acto cierta suposición de saber al cartel que escucha, misma suposición de saber que en tanto convoca, obtura. Según mi experiencia, el pasador para

no convertirse en un colador, además de transmitir lo que escuchó, de lo cual ya es parte, no debe renunciar a dar su opinión, su elaboración, y el cartel escuchar eso como parte del caso que se escucha. Si quienes conforman el cartel tienen presente esa disponibilidad, sin prejuicios, el pasador tiene más posibilidades de autorizarse en su decir. Es un juego en equipo, no lo olvidemos. Cuando hice esta experiencia, decía que el encuentro con el cartel había tenido para mí un efecto de supervisión. Además del relato del caso, lo que ya permite cierta distancia de lo escuchado, uno de los integrantes de ese cartel dice: “qué interesante ese punto porque hay algo de un cambio de posición”. Esa intervención me dejó pensando hasta que, ya en otro momento, me permitió armar la lógica del caso. Y advertir, además, que lo que obturaba ese trabajo era el mismo punto que impedía terminar de armar mi propio caso.

Si podemos pensar que el supervisor es el clínico, como se dijo en una de las noches preparatorias al Simposio, y el pasador un analizante, tal vez aparezca antes o después, el Un decir del acto que engendra al analista.

Para la Escuela será la posibilidad de una nueva nominación de un Analista de Escuela. Para quienes llevaron adelante ese trabajo, innumerables efectos que cada uno pondrá a trabajar a partir de ahí.

MESA 5 - PRESENTACIÓN DE CASOS B

Maria Helena Martinho (EPFCL- FCL Rio)

Un caso clínico: transferencia, fantasía y acto.

Liora Stavchansky (Foro México)

La calle: entre el juego y lo real de la violencia

Rossane Melo (EPFCL - FCL Río)

Los “diagnosticismos” y sus efectos en la clínica con niños.

Walter García (FA-BA)

La interpretación como caja de resonancia

“Un caso clínico: transferencia, fantasía y acto”

Maria Helena Martinho

Psicoanalista; Doctora y Máster en Psicoanálisis por el Programa de Posgrado en Psicoanálisis del Instituto de Psicología de la UERJ; Miembro de Escuela (ME) de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano; Miembro de la EPFCL-Brasil, Foro Río de Janeiro; Profesora y supervisora clínica del Curso de Especialización en Psicología Clínica de la PUC-RJ; correo electrónico: mhmartinho@yahoo.com.br

Un caso clínico pone de relieve la articulación entre transferencia, fantasía y acto para ilustrar la transferencia como acto y como espacio donde tienen lugar diferentes órdenes de actos: el analizando realiza un *acting out*; el analista realiza un acto analítico.

El acto analítico revela la forma particular de goce de esta mujer, que paga un alto precio por la seguridad que obtiene en la fantasía; está atrapada en una posición fija, respondiendo de manera estereotipada al Otro. La fantasía es la pantalla que oculta algo de lo real, pero el acto analítico indica lo real que insiste, la repetición traumática.

El *acting out* es un despliegue de la fantasía: por un lado, se muestra algo porque no se puede decir; por otro, lo que se muestra se dirige al Otro de la transferencia. El amor transferencial hace posible la maniobra, constituyendo una estrategia que diferencia este análisis de las otras ocho terapias anteriores.

En la primera entrevista, Márcia habla de su desconfianza y abandono. En la segunda entrevista, anuncia que abandona su noveno intento de tratamiento. Cinco meses más tarde, vuelve a verme, pero dice que esta vez es una petición para su hijo de cinco años.

Márcia acude a algunas entrevistas para hablar de su hijo, pero habla de “abortos”, “abandonos” y “rechazos”. Su hijo dirige una pregunta a la analista y entra en análisis. Decido mantener a la madre en las entrevistas, después de todo, la primera vez acudió a mí como su analista y luego renunció al tratamiento porque necesitaba pagar menos. Sin embargo, podía pagar mi precio por su hijo. ¿Qué significaba esto en su historia de “abortos”, “abandonos”, “mentiras” y “menos valor”?

En un momento de angustia, Márcia revela: “Fui adoptada, no querían que naciera. Soy un aborto de la naturaleza”. Esta mujer paga un alto precio por la seguridad que obtiene en la fantasía: el precio de estar atrapada en una posición fija: “un aborto de la naturaleza”. Márcia supone que el analista conoce a los niños abandonados; lleva a su hijo rechazado para que sea tratado por el analista. En las sesiones de su hijo, siempre llega tarde a recogerlo. Un día dejó al niño esperándola fuera. Me dice enfadada: “No me gustó, sentí que ponían a mi hijo en la puerta como un cubo de

basura, esperando a que pasara el basurero”. Márcia empieza a cuestionar mi trabajo con su hijo. Le digo que es decisión de la familia dejar al niño en tratamiento. En un movimiento de intensa cólera ante mis palabras, Márcia actúa, abandona la logopedia del niño, amenaza con abandonar también su análisis y lamenta que su “implicación” no sea correspondida por el analista. Propongo una sesión extra, ella se presenta y cuestiona el motivo de la sesión. Indignada, dice que éste no es su análisis, porque si lo fuera, no vendría sólo una vez a la semana. Le propongo aumentar el número de sesiones. Acepta, pero se da cuenta de que tendrá que trabajar para mantener ese deseo.

Después, se pudo comprobar que colocar a su hijo fuera de la habitación tuvo el efecto de un acto analítico, ya que le hizo ver su propia cuestión de actuar siempre su fantasía: “un niño está abandonado”. El analista realiza un “acto analítico que promueve el escándalo, porque revela el fracaso del sujeto que se supone que sabe... El acto viene en el lugar de un decir por el cual cambia al sujeto” (Lacan, 1967-1968, conferencia del 22/11/1967). El acto analítico ratifica la exclusión de este sujeto, señalando que Márcia, la abandonada, también abandona. La fantasía es una pantalla que oculta algo de lo real y el acto analítico indica lo real que insiste, que vuelve siempre al mismo lugar, indica la repetición traumática.

Vemos un pedido de análisis en dos etapas: en la primera, Márcia viene y no apoya el pedido en su nombre; en la segunda, oculta su pedido en un pedido de análisis para su hijo.

Hay tres puntos de inflexión que marcan su entrada en análisis: en el primero, se presenta pegada al significante maestro “aborto de la naturaliza”, significante de transferencia dirigido al analista que se supone sabe de niños abandonados; en el segundo, el *acting out* dirigido al analista actualiza la fantasía “un niño es abandonado”; en el tercero, ante la propuesta de una sesión extra, surge la pregunta de “Che Vuoi?”: “¿Por qué me dijiste que viniera hoy?”, pregunta que la lleva por el camino de su propio deseo.

En *El Seminario, libro 10: la angustia* (1962-1963), Lacan dice que el *acting out* es un “despliegue de la fantasía” (p. 138). Este despliegue tiene dos dimensiones, una relativa al objeto *a*, y otra relativa al Otro: por un lado, está lo que debe mostrarse porque no puede decirse, esta dimensión es la relativa al objeto *a*; por otro lado, debe haber un Otro a quien mostrar la fantasía, esta dimensión es la que articula el *acting out* con la transferencia.

Lacan señala que el *acting out* funciona de la misma manera que la fantasía: “a la vez como evitación de la angustia” (p. 130) y como práctica de goce. Puede aparecer como una respuesta a la resistencia del analista, como puede verse, según Lacan, en el caso Dora de Freud y en el caso

del hombre de los sesos frescos de Ernest Kris; también puede aparecer como una práctica de goce, una puesta en escena fantasmática. Sin embargo, el *acting out* siempre apunta a una subjetividad fijada en la fantasía, un sujeto que se repite en esta forma estática de presentación.

En el caso clínico presentado, “el acting out es el comienzo de la transferencia. Es la transferencia salvaje. No es necesario el análisis para que haya transferencia. Pero la transferencia sin análisis es acting out” (p. 140). Lacan se pregunta: “¿cómo domar la transferencia salvaje? ¿Cómo meter al elefante salvaje en el prado? ¿Cómo poner el caballo en la rueda para hacerlo girar en el tiovivo? ¿Cómo lidiar con el acting out?” (p.140).

En la singularidad de este caso clínico, se observa que el acto analítico tuvo un efecto interpretativo, vino en el lugar de un decir a través del cual cambió el sujeto, hizo emerger la angustia, el agujero, el deseo, el amor transferencial posibilitó la maniobra, constituyendo una estrategia que diferenció este análisis de las otras ocho terapias anteriores.

Referencias

- Freud, Sigmund. (1919). “Pegan a un niño. Contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales”. In: *Obras completas*. Buenos Aires: Amorrortu, 2006. v. 17.
- LACAN, Jacques. (1958). A direção do tratamento e os princípios de seu poder. In: *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
- LACAN, Jacques. (1960). A subversão do sujeito e a dialética do desejo no inconsciente freudiano. In: *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
- LACAN, Jacques. (1960-1961). *O Seminário, livro 8: a transferência*. Rio de Janeiro: Jorge. Zahar Editor, 1992.
- LACAN, Jacques. (1962-1963). *O Seminário, livro 10: a angústia*. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2005.
- LACAN, Jacques. (1967-1968). *O Seminário, livro 15: o ato psicanalítico*. Inédito.
- LACAN, Jacques. (1969). “O ato psicanalítico: Resumo do Seminário de 1967-1968”, In: *Outros escritos*. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003.
- LACAN, Jacques. (1969-1970). *O Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1992.

“La calle: entre el juego y lo real de la violencia”

Liora Stavchansky

Psicoanalista mexicana. Su interés se centra en la transmisión del psicoanálisis y, particularmente, en el estudio de las infancias, las adolescencias, el cuerpo, la segregación y el silencio entre muchos otros. Es miembro fundador del Foro del Campo Lacaniano de México (FCLM). Miembro de Escuela de la Internacional de los Foros. Miembro del Foro Argentino de Buenos Aires (Polo Sur). Docente de la Universidad Iberoamericana de México desde 1995. Diversas publicaciones en revistas internacionales y libros. Últimos libros publicados: *Infans*. Paradiso Editores. México 2025.

La violencia que asola México ha dejado de ser una excepción para convertirse en parte del tejido cotidiano, infiltrándose incluso en las infancias y sus juegos. La invasión del narcotráfico y de grupos criminales en la vida cotidiana, ha generado dinámicas comunitarias donde lo brutal, lo impulsivo y lo crudo se normalizan. Esta violencia, lejos de quedar circunscrita a los territorios donde se ejerce, se inscribe en los cuerpos, y modifica las formas de subjetivación desde la infancia. En ciertos entornos, niñxs que crecen bajo esta atmósfera, imitan y reproducen escenas de secuestros, extorsiones o ejecuciones como si fueran parte de un guión compartido. Lo hacen en el juego, en los recreos, en sus vínculos: imponen cuotas escolares, cobran por el uso de los baños, o amenazan como gesto lúdico. Estas escenas, aunque puedan parecer parodias, configuran un tipo de normalidad *necropolítica* que borra las fronteras entre juego y violencia, entre representación y realidad.

Desde el psicoanálisis, esta situación nos interpela de forma urgente. La clínica con niñxs se convierte en un lugar donde lo social irrumpe con fuerza, exigiendo al analista sostener no solo el decir del sujeto, sino también el eco de un país herido. La violencia deja de ser un significante lejano para convertirse en materia de transferencia, en textura del síntoma, en materialidad del juego. Se abren así dos caminos opuestos: por un lado, el juego mimético, donde el niñx reproduce lo vivido o lo escuchado, repitiendo sin apertura, sin distancia, sin simbolización. Una especie de parálisis lúdica que remite al horror y a la imposibilidad de subjetivar la experiencia. Por otro, el juego como profanación, como transformación poética de lo real; como un espacio donde se escenifica la ausencia, donde se ensaya la pérdida, donde la muerte se vuelve presencia metafórica, soportable, habitable.

Estas coordenadas pueden leerse en hechos como los documentados por el periodista Raymundo Riva Palacio, quien recogía el testimonio de un psicoanalista tras una jornada marcada por balaceras: niños narraban cómo desde su salón veían pasar camionetas con cadáveres. ¿Qué imagen se instala en un infante cuando la muerte irrumpe con tal brutalidad? ¿Qué lenguaje puede traducir el dolor cuando no hay contención ni explicación posible? En este terreno, el juego se bifurca: puede convertirse en vehículo para la repetición alienante o en acto creativo capaz de sustraer al niño de esa lógica impuesta por el Otro criminal.

El caso clínico de Lola, de ocho años, lo ilustra con crudeza. Derivada por su escuela tras el fallecimiento de su hermana en un “accidente” escolar, Lola llega al consultorio atravesada por el silencio. Su hermana había sido “obligada a jugar”, a saltar un domo desde el tercer piso. Murió al instante. En sus primeras sesiones, Lola no habla de Emilia, pero juega con explosiones, muertes, y destrucciones. Su frase “juguemos a que Emilia no está” se repite con un ritmo casi musical. En este gesto se cifra una posible vía de elaboración: no se trata de olvidar, sino de recordar de otro modo; no de reprimir, sino de recrear; no de evitar, sino de escenificar. El juego se vuelve aquí una praxis simbólica que permite nombrar lo innombrable.

En México, la muerte ha sido históricamente domesticada, transformada en ritual, dulcificada en calaveras de azúcar, celebrada en altares. Pero en su forma actual, la muerte violenta no tiene lugar en el lenguaje ritual: se vuelve espectáculo, mercancía, saldo noticioso. El capitalismo convierte la violencia en bien de consumo, en narrativa, en ficción de Netflix. Jugar a la muerte se convierte entonces en una manera de habitar lo real sin mediación, lo que hace que el juego pierda su carácter simbólico. Ya no es juego: es reproducción. Ya no hay divergencia, ni metáfora. Solo literalidad.

El juego, en su forma más pura, es improductivo, inútil, desacralizador. Como dice Horkheimer, bajo el dominio de la racionalidad instrumental, el juego no tiene cabida porque no genera plusvalía. Sin embargo, su potencia política está precisamente ahí: es una práctica que resiste la lógica de la utilidad, del rendimiento, de la productividad. El juego subvierte, miniaturiza, parodia. En ese sentido, es anticapitalista. No responde al imperativo de la eficacia; se burla de él. No hay niño que juegue para obtener algo. Se juega por jugar, por el placer de repetir, de transformar, de inventar.

Giorgio Agamben señala que el niño, al profanar lo sagrado, hace del objeto algo común. Ese gesto es político y ético: permite imaginar otras formas de uso, otras formas de estar en el mundo. El

juego convierte lo prohibido en disponible, lo solemne en risible. Lacan diría que ahí se produce un redoble: un eco del mundo, pero con variación. Freud lo planteaba en términos de elaboración psíquica: jugar no es evitar el displacer, sino metabolizarlo, darle forma. El Fort-da de su nieto revela la dimensión trágica y creativa del juego: se pone en escena la ausencia, se tolera, se tramita.

Así, el niño no juega solo a matar o destruir. Juega a recrear el mundo que se le ha roto. Puede convertir una caja en un cohete, un lápiz en una espada, una muñeca en un hijo. Lo sagrado se vuelve profano al entrar en el circuito del ludus. Y esa es la verdadera resistencia. Porque ahí donde todo se vuelve mercancía, el niño profana y reinventa. Si la violencia se capitaliza, el juego la desacraliza.

Jugar a cobrar piso, a secuestrar, a matar, no es juego: es su reverso. Es su caricatura. Es el síntoma de una cultura donde la muerte ha dejado de doler. En esas representaciones no hay invención, no hay alteridad. Solo repetición. Por eso urge devolver al niño al terreno de lo profano, a ese “país de los juguetes” que Agamben describe como tiempo sin cronología, como espacio sin utilidad. Jugar es una forma de salvar el mundo. De volverlo habitable. De narrar lo insoportable sin ceder ante él.

Lola, en su juego silencioso, repite la caída, escenifica la explosión, aniquila simbólicamente a sus padres. No lo hace por crueldad, sino por supervivencia. El juego es el único espacio donde Emilia aún está, donde la muerte no se impone como destino, sino como pregunta. El juego le permite decir, sin palabras: “ella ya no está, pero yo todavía puedo estar”. Esa es la potencia ética del juego.

Jugar no es imitar. Es inventar. No es obedecer. Es desobedecer. Y en un país donde la infancia se ha vuelto rehén del miedo, el juego puede ser la única forma de libertad que aún no ha sido colonizada. En este sentido, más que nunca, el juego es político.

“Los diagnosticismos y sus efectos en la clínica con niños”

Rosana Melo

Analista Miembro de la Escuela (AME), miembro fundador del Foro del Campo Lacaniano de Río de Janeiro. Profesor y vicecoordinador del curso de Psicología en la UFRRJ. Profesor del Posgrado en Psicología en la UFRRJ. Miembro de la Red Nacional de Investigación en Salud Mental de Niños y Adolescentes.

El “siglo del niño”, tal como lo anunció la escritora y poetisa Ellen Key en 1900, traía la promesa de que el siglo XX seguiría los pasos del niño, hijo del narcisismo de los padres, como indicó Freud en 1914. Sin embargo, algunas metamorfosis en los lazos sociales y en el campo del goce (Lacan, 1969-70) comenzaron a presentar al niño como un objeto de consumo en la vitrina de los mercados, con consecuencias que no pueden ser ignoradas, ya que el niño “se encuentra directamente afectado por el estado actual de los lazos sociales o de los desenlaces” (Soler, 2014, p. 43). El niño emerge así como pieza clave de un proyecto civilizatorio y pasa cada vez más a ocupar la posición de objeto de goce, de tutela e intervención. El infans entra en la ciudad de los discursos eurocéntricos como objeto a ser hablado, moralizado, educado, instruido, institucionalizado, cultivado para convertirse en adulto.

La alianza entre el discurso científico y el discurso capitalista conduce a la universalización y homogeneización de los sujetos. Pero esta universalización tiene un precio: se trata de una subversión sin precedentes (Lacan, 1967). El discurso de la ciencia, al forcluir al sujeto, mantiene en la ignorancia al cuerpo, un cuerpo que llegaremos a tener el derecho de desmembrarlo para el intercambio. Queda el cuerpo, objeto de escrutinio y control.

Es en este contexto que Lacan destaca, con el término “niño generalizado”, la consecuencia de todo esto. Asistimos a la emergencia de nuevas formas de gestión del goce, mediadas por el mercado y sus ofertas de objetos de consumo. En este escenario, solo hay lugar para el “para todos”. ¿Qué hacer entonces con aquellos que aparecen en la ciudad de los discursos con sus diferencias, diferencias irreductibles, que escapan a las ataduras del mercado? La gestión de esos cuerpos y esos goces se convierte también en una gestión espacial. La tesis de Lacan señala la segregación como consecuencia de la universalización (Soler, 1998) y, al retomar a Michel Foucault en su crítica al campo médico-psiquiátrico, Lacan concluye que la psiquiatría, aliada al

discurso de la ciencia, nos llevará al campo de concentración generalizado, es decir: separar, aislar, concentrar para dominar desde un proyecto de uniformización.

Sobrevive entre nosotros la lógica del aislamiento, que Lacan (1967) atribuye al nacimiento del campo de la psiquiatría. Michel Foucault (1973-1974) consideró que este poder psiquiátrico se concretó, sobre todo, a partir de la infancia. Proponemos, por lo tanto, abordar la expansión de los diagnósticos y la medicalización de niños en Brasil como efecto de la universalización de los modos de goce, y cómo el niño generalizado favoreció que la infancia se convirtiera en un campo en disputa.

La patologización de los ineducables y la segregación de los cuerpos infantiles marcan la historia de la infancia en el mundo eurocéntrico. A lo largo del siglo XX, fuimos testigos del nacimiento de otras formas de gobernar la infancia, en las que la vigilancia punitiva asume otras formas, mientras que la patologización y la medicalización se convierten en un fenómeno global. La preocupación por el desarrollo de una nomenclatura uniforme está presente desde la primera página del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, publicado en 1952. Esta nomenclatura uniforme favorece la epidemia de diagnósticos (Whitaker, 2017), realizados de manera cada vez más ligera, sin tener en cuenta el tiempo para comprender (Oury, 2009), generando impactos en la clínica y en la cultura.

La manipulación del lenguaje —en los estratagemas lingüísticos incorporados en las diversas ediciones del manual— y las nuevas formas de (neuro)biologización de la vida, con énfasis en la cerebralización de los afectos y el sufrimiento psíquico, han sido asociadas a las marcas de la radicalización totalitaria del siglo XX. Para Sauret, Askofare y Macary-Garipuy (2016), la concepción de un sujeto biológicamente compatible es lo que subyace a la ideología nazi y al materialismo científico, en su versión estalinista. Cabe a aquellos que sostienen tales determinantes biológicos explicar cómo su “biologismo” puede diferenciarse de los terribles biologismos que mancharon la historia del siglo XX.

Los diagnósticos pueden ser modelados por fuerzas sociales y políticas, tal como ocurrió en el régimen diagnóstico del Tercer Reich que sirvió para la selección de las “vidas indignas de ser vividas”, bajo el pretexto de un proyecto científicista y sus esfuerzos para crear una comunidad

nacional homogénea. A pesar de las críticas dirigidas a la medicina —representada por la Psiquiatría— por su asociación con instituciones normativas y de control social del Estado, de las denuncias sobre los mecanismos de control e interés financiero subyacentes a la industria de los diagnósticos, y a pesar del reconocimiento de que, en el siglo XX, el mal se utilizó de las técnicas científicas (de los crematorios más eficientes a las bombas atómicas, pasando por la racionalización estatal), seguimos siendo testigos del surgimiento de nuevas formas de gobernar la infancia. La vigilancia asume otras formas con el diagnosticismo, siempre respaldada por discursos que evocan ideales humanitarios y de prevención. Dominio, concentración, exterminio, anestesia, fijación.

Hoy, adolescentes y niños llegan a los consultorios, a las escuelas, a los ambulatorios y enuncian: “soy TDAH”, “soy TEA”, “soy bipolar” —reclamando beneficios sociales asociados a estas identidades. Asistimos, así, a los efectos de la masificación y la mortificación de los sujetos, ahora portadores de una identidad cristalizada y validada por el Otro. El avance de un discurso que domina desde la pasión por la ignorancia y que vocifera por la eliminación de la diferencia instituye una hostilidad dirigida al infantil, alternando entre el rechazo y la indiferencia.

Es con el psicoanálisis que podemos interrogar el estatuto de ficción y de fijación de estas identidades, desnaturalizar tales identificaciones e interpretar la fantasía de infancia que orienta las acciones dirigidas a los cuerpos infantiles —en el asfalto, en las calles, en las comunidades, en las escuelas, en las instituciones.

Referencias

Arendt, H. (2012). *Origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo*. São Paulo: Companhia das Letras. (Obra original publicada em 1949)

Bercherie, P. (1980). *Os fundamentos da clínica: história e estrutura do saber psiquiátrico*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Broderick, A. A. (2022). *The autism industrial complex: how branding, marketing, and capital investment turned autism into big business*. Maine: Myers Education Press.

Fernandes, A.D.S.A.; Couto, M.C.V.; Andrada, B.C. & Delgado, P.G.G. (2024). *A “indústria” do autismo no contexto brasileiro atual: contribuição ao debate*. Material Técnico.

Foucault, M. (2006). *O poder psiquiátrico*. São Paulo: Martins Fontes.

Foucault, M. (2010). *História da loucura na idade clássica*. São Paulo: Perspectiva. (Obra original publicada em 1972)

Freud, S. (2006). Introducción del narcisismo. In S. Freud. *Obras completas de Sigmund Freud* (Vol. 14). Buenos Aires: Amorrortu. (Obra original publicada em 1914)

Freud, S. (2006). Psicologia de las masas y análisis del yo. . In S. Freud. *Obras completas de Sigmund Freud* (Vol. 18). Buenos Aires: Amorrortu. (Obra original publicada em 1921)

Lacan, J. (2003). Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. In J. Lacan, *Outros escritos* (pp. 249–264). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Lacan, J. (1990). *O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise* (4ª ed.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. (Obra original publicada em 1964)

Lacan, J. (1992). *O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise* . Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. (Obra original publicada em 1969–1970)

Lacan, J. (2012). *O seminário, livro 19: ...ou pior* . Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. (Obra original publicada em 1971–1972)

Lacan, J. (2003). Alocução sobre as psicoses da criança. In J. Lacan, *Outros escritos* (pp. 359–368). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. (Obra original publicada em 1967)

Lacan, J. (1967). **Breve discurso a los psiquiatras**(inédito). https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/biblio/pdf_Psico/discurso_psiquiatras.pdf

Ortega, F., & Vidal, F. (2007). Mapeamento do sujeito cerebral na cultura contemporânea. *Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde*, 1(2), 257–261.

Oury, J. (2009). O coletivo. São Paulo: Aderaldo & Rothschild

Sauret, M.-J., Askofare, S., & Macary-Garipuy, P. (2016). Controvérsias atuais no tratamento do autismo na França: o que está em jogo para a psicanálise. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, 16(spe), 1098–1118. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812016000400003

Sheffer, E. (2019). *Crianças de Asperger: as origens do autismo na Viena nazista*. Rio de Janeiro: Record.

Soler, C. (2014). *Lo que queda de la infancia*. Asociación Foro del Campo Lacaniano de Medellín.

Soler, Colette. (2018). Les ségrégations. Séminaire Champ Lacanien à Paris, *Mensuel* 128, Paris.

Zorzaneli, R., Bezerra, J. R.B., & Costa, J. F. (Orgs.). (2015). *A criação de diagnósticos na psiquiatria contemporânea*. Rio de Janeiro: Garamond.

Whitaker, R. (2017). *Anatomia de uma epidemia: pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o aumento assombroso da doença mental*. Rio de Janeiro: Fiocruz.

“La transferencia como cámara de resonancia”

Walter García

Licenciado y Profesor de psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Psicoanalista. Terapeuta No Verbal (Fundación Benenzon). Miembro del Foro Argentino del Campo Lacaniano (polo Buenos Aires) y de la IF-EFPCL. Psicólogo en la Escuela Especial María Montessori. Docente de educación superior en Discapacidad neuromotora y visual. Supervisor de diferentes instituciones educativas y de salud.

Partiendo de la afirmación de Colette Soler, que en la clínica con el autismo infantil, el analista viene a ubicarse en el lugar del "Otro Primordial Real", me propongo indagar cuál es el estatuto del lazo transferencial en el trabajo con estos niños/as.

Las encrucijadas transferenciales que presenta el autismo en la infancia, vuelven a colocar el foco de los interrogantes en los fundamentos de nuestra praxis ii puesto que, la transferencia, en tanto nombra esa dimensión del lazo que nos permite formar parte de la economía libidinal de nuestros analizantes -motor y obstáculo de un análisis- es la vía regia para leer y maniobrar sobre los nudos ciegosiii en donde se ancla el padecimiento subjetivo. Ahora bien, cuáles son los desafíos que enfrentamos con estas posiciones donde la “perturbación del instrumento-libido”iv desdibuja la frontera entre el sujeto y el Otro.

El autismo infantil testimonia sobre una problemática que atañe a los modos en que el ser hablante ha sido afectado por la lengua materna; y nos interpela respecto a ese punto de la existencia donde se inscribe el intervalo, como efecto del tránsito entre ser hablado y hablar. Estos niños, responden al trauma de la lengua de un modo peculiar: Sostienen al Otro a distancia, anulando los signos de su presencia debido a que son vivenciados en lo real como una irrupción atronadora. Este rechazo radical del Otro, da cuenta del modo en que el viviente puede quedar prendado del significante en su cara real. Es decir, cuando el estatuto de la traza de goce, producto de la contingencia de los primeros cuidados entre el cuerpo de la madre y el del niño sigue vivo; y al no haber sido alcanzado por la operatoria de lectura que produciría su borratura, interfiere en la constitución del significante en su matiz simbólica y en la re-creación del objeto. Entonces ¿De qué maneras puede llevarse a cabo esa “rectificación del Otro” para inter-venir allí?

Si consideramos que en sus invenciones -las maneras en las que se relacionan con los objetos del mundo, su cuerpo y los otros; el uso que hacen de su con-textovii inmediato; así como también del campo de sonoridades que los rodean- habita ese saber supuesto a un sujeto por venir; y que además, existe allí un incansable intento por construir un borde respecto a aquello que se les vuelve intolerable; hallaremos las pistas que nos abrirán las puertas del lazo. En este sentido, la transferencia parte del analista y se soporta en "Le supposé-savoir-lire- autrement" (supuesto-saber-leer-de-Otro-modo) viii, esa traza, ahí donde se fundamenta el Otro como cuerpo de escritura, antes del advenimiento del sujeto dividido.ix

El trabajo con estos niños me enseñó que existe un campo sonoro-musical que puede ofrecernos vastos recursos a la hora de modular nuestra presencia, permitiéndonos incidir en la economía libidinal. Esto me llevó a pensar en la transferencia como una Cámara de Resonancia. Concepto proveniente del campo de la música que alude a la cavidad donde se transmiten y son intensificadas las vibraciones del sonido, haciendo que el instrumento ejecutor se vuelva más ligero y a su vez conserve su sonido original. Y me recordó la clase del 11/06/1974x donde Lacan define a la transferencia como una "puesta en co-vibración semiótica". Frase enigmática que busca menos una pretendida frecuencia de vibración con el autista (lo que anularía la disparidad subjetiva) que la instauración de un lugar de escucha donde la presencia del analista, en primera instancia, logre con-fundirse con la escena, dando paso a esas formas en las que la lengua ha percutido el cuerpo, -esos S1 encarnados en la indecisión "entre el fonema, la palabra, la frase y el pensamiento todo"xi-, para lograr así el consentimiento que le permitirá luego operar con un recurso que haga de la discontinuidad parte del juego.xii

R es un niño de dos años y medio, con diagnóstico de "autismo en la infancia". No habla, no mira, no controla esfínteres, ni se dirige al otro. Su nombre, un tanto peculiar, decanta algunos ecos de la historia familiar. R lleva el nombre de su abuelo materno, pero con la sutil diferencia, su última letra no es la "e" sino la "o", porque a su madre le "sonaba mejor". Este salto entre letras, abrirá esa posible hiancia por donde el Otro comenzará a nacer para R.

R dedicaba sus sesiones a armar filas de animales de una forma solitaria y minuciosa. Comencé a alcanzarle los animales diciendo: "ahí va el caballo" (relincho); "ahí va el perro" (ladrido). En una ocasión, al terminar esa fila convertida en un arco que nos separaba claramente, nos paramos al

unísono y me dispuse a saltar de su lado. R aplaudió, se rió y me regaló una primera mirada cómplice. A partir de allí su construcción siempre iniciará con la misma tríada de animales a la cabeza de la fila. Y además, solicitará imperativamente al analista que nombre correctamente cada animal en orden, señalándolos y pronunciando un insistente “ah”. Sin equivocidad posible, el analista se apoya en la modulación de los tonos y las cadencias, y en distintos ritmos, para introducir una primera diferencia tolerable, luego una pausa y una apuesta: “elefan...” y R pronuncia “e”. Esto se traslada a todos los animales. Al llegar al último, cuya letra final es la “o”, su expresión toma una coloratura singular acompañada de la agitación de sus miembros. Así se inaugura todo un paño de juegos sonoro-musicales que aún nos acompaña: en la articulación de fonemas y de imágenes o al culminar cada sesión, tirando los animales en un tacho. Hoy R no sólo controla esfínteres y sostiene la jornada escolar con AT, sino que va por el mundo pronunciándose: “papá” “mamá” “jugo” “gua-te” “Vamo-a-casa”.

La transferencia pensada como cámara de resonancia, nos permite amplificar la prehistoria del sujeto -esa herencia sonora hecha de las trazas impresas por la sonata materna. Ahora bien, en el autismo infantil, ¿Será que nos abre un patio de juegos para re-percutir sobre ese eco del decir en el cuerpo (pulsión) dando lugar a nuevos S1 con lo que un sujeto pueda empezar a contarse?

Referencias

- Cerruti, N. (2014) Cuidado con la música. La filosofía de Nietzsche como música. El psicoanálisis en su musicalidad. Buenos Aires. Letra Viva.
- De Gainza, P.; Lares, M. (2011) Conversaciones con Jorge Fukelman. Psicoanálisis: juego e infancia. Buenos Aires, Lumen.
- García, W. "El cuerpo, una relación al mundo." En Hacerse-se un cuerpo en el autismo y la psicosis infantil. Buenos Aires. Editorial Letra Viva. 2017
- García, W. Jugar con lalalangué, un paso de sonido (pas de son). Revista Nadie Duerma. Año 2020. <https://www.nadieduerma.com.ar/edicion-12/jugar-con-lalalangué-un-paso-de-sonido-pas-de-son-168.html>
- Iuale, María Lujan (2014). “Mártires de lalengua”, en Nadie Duerma #3. Revista de Psicoanálisis del Foro Analítico del Río de la Plata.
- Iuale, L. (2016) Detrás del espejo. Perturbaciones y usos del cuerpo en el autismo. Buenos Aires. Editorial Letra Viva.
- Lacan, J. (2007) El seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. (1964). Buenos Aires. Paidós
- Lacan, J. (2009) El Seminario de Jacques Lacan, libro 20: Aún. (1972-1973). Buenos Aires. Paidós.
- Lacan, J. Seminario Nro 21 Los nombres del padre (les non dupes errent). (1973-1974). Versión Crítica Ricardo Rodríguez Ponte.

-Lacan, J. El seminario de Jacques Lacan, Libro 23: El sinthome. (1975-1976). Buenos Aires. Paidós. 2015

-Lacan, J. Seminario Nro 25 El momento de concluir. (1977-1978). Versión Crítica Ricardo Rodríguez Ponte.

-Lacan, J. Conferencia en Ginebra sobre el síntoma (1975) En Intervenciones y textos 2. Buenos Aires. Editorial Manantial. 2007

-San Miguel, T. "La sugestión en el análisis." En La situación actual de la transferencia. Buenos Aires. Editorial Letra Viva. 2019

-Soler, C. El inconsciente a cielo abierto de las psicosis. Buenos Aires. JVE Ediciones. 2004

-Soler, C. Estudios sobre las psicosis. Buenos Aires. Editorial Manantial. 2007

Notas

i ii Los cuatro [conceptos...pp.130](#))

v Principalmente la voz y la mirada.

vi Soler, C. (2007) Estudios sobre las psicosis.

vii El guión de la palabra "con-texto" alude a que allí se juega también la dimensión textual de la historia del sujeto.

viii Lacan juega con su lalengua para ubicar la necesidad de un modo Otro de lectura para aquellas trazas de goce que se han impreso en el cuerpo, y que podríamos decir que el autismo pone de relieve en sus manifestaciones. (Lacan, J. Seminario 25 "El momento de concluir". Sesión de 10 de enero de 1978. Inédito)

Soler, C. El inconsciente a cielo abierto de las psicosis. pp. 79

"La transferencia está determinada por la función de una praxis" (Lacan, J. El Seminario 11 Los cuatro conceptos.

El término nudo ciego se refiere a un tipo de nudo que es especialmente complicado de deshacer. A menudo, se forma de manera que no se puede ver claramente cómo se entrelazan las cuerdas o hilos, lo que dificulta su desenredo. Es un concepto que puede aplicarse tanto en contextos literales, como en la atadura de cuerdas, o también en situaciones metafóricas donde se presentan problemas difíciles de resolver.

Soler, C. El inconsciente a cielo abierto de las psicosis. p.78

ix San Miguel, T. "La sugestión en el análisis." En La situación actual de la transferencia. pp.37

xii Según Lacan, El recurso con el que cuenta el analista es "en lalengua, lo que la quiebra (brisée)" Lacan, J. (2009) El Seminario 20: Aun. Paidós, Bs.As. pp.57-58

MESA 6 - SUPERVISIÓN Y CONTROL

Leonardo Leibson (FA-BA)

Los dos cuerpos del analista

Luis Prieto (FA-BUE)

El caso, la causa y el acto en la clínica analítica

A. Noguera y A. Bruschi (FA-BA)

Efectos en la práctica del espacio de supervisión

Katarina Vidal Aragão (EPFCL- FCL Aracaju)

La formación del analista y las consecuencias en la transmisión

Juan Manuel Moraña (FA-BA)

El pase, el control y la transmisión de casos clínicos: un trípode para interrogar los problemas cruciales del psicoanálisis.

“Los dos cuerpos del analista”

Leonardo Leibson

Psicoanalista, médico especialista en psiquiatría, doctor en psicología. Foro Argentino del Campo Lacaniano, Polo Buenos Aires. AME de la EPFCL. Docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires.

“El analista es un instrumento, hay que metérselo en la cabeza”

C. Soler (2000, 185)

1. Al menos 2

Lacan afirma que “es indispensable que el analista sea al menos dos. El analista para tener efectos y el analista que, a esos efectos, los teoriza”²³. ¿Qué localización para esos “dos”?

A nivel espacial, ¿uno y otro serían “dos caras de una moneda”? De ser así, habría que traspasar un borde para dar cuenta del pasaje entre uno y otro. Pero esta “dupla” podría ser una banda de Moebius, donde el borde, único, es un doble bucle que implica torsión, pero no discontinuidad. ¿Sería eso la estructura del deseo del analista?

A nivel temporal, ¿habría una relación de antecendencia y consecuencia? ¿Uno explica al otro o es su conclusión? ¿O hay una lógica de anticipación y retroacción, donde el segundo prepara el acto que el primero sostiene y del cual el segundo hará inscripción?

Finalmente, ¿ese “al menos dos” podría implicar una terceridad, un *no-todo* uno ni otro? La hiancia entre el analista y el clínico como punto de apoyo para que el analista pueda dar a leer su implicación en ese análisis. Ese entre uno y otro ¿es requisito para la transmisión del psicoanálisis?

2. ¿Quiénes son “*al menos* dos”?

El analista que soporta el acto requiere del que a esos efectos los teoriza. Este “teorizante” puede ser equiparado a la figura tradicional del “clínico”. Aquel que, ante un público, enseña desde una experiencia. Amalgama hechos y rasgos comunes, define cuadros, extrae consecuencias, formula abordajes. Desde su punto de vista al pie de la cama del enfermo relanza su mirada hacia el público. Eso genera enseñanza, nutrida por la admiración y la obediencia (los “popes”).

²³ Lacan, J., *El Seminario, Libro 22, R S I*, inédito, sesión del 10/12/74

El analista, en cambio, se ubica al costado y no observa, escucha. *Una escucha que lee, pero que no piensa*. Así lo define Lacan: “(...) el psicoanalista en el psicoanálisis no es sujeto, y (...) situando su acto con la topología del objeto a, se deduce que opera por no pensar.”²⁴

“Al menos dos”, pero si sólo contamos hasta dos, lo imaginario plantea un “o...o...”.

Contar hasta tres permite ubicar no sólo la diferencia entre estos dos lugares sino lo que los enlaza.

El analista no está como sujeto, pero nada le impide estar como cuerpo. Porque “está hecho de objeto a”, de eso que caído del cuerpo -o encerrado allí- deviene causa de transferencia, *agalma* prometido al desecho.

El clínico no parece necesario que tenga cuerpo. Puede ejercer esa función desde un texto o un parlante. O ser un dispositivo de IA.

Sin embargo, el acto que ese analista soporta no llegaría lejos si no pudiera ser leído, historizado, subjetivado. Dice C. Soler: “el acto analítico no se historiza a sí mismo. Permite al sujeto historizarse, pero no se historiza a sí mismo”²⁵. Lacan insiste que “el acto es la lectura del acto”.

No podría entonces el analista soportar el acto sin estar soportado por la lectura del clínico. Y algo que enlace.

3. Sincronías

¿Entonces cuál es “primero”? Más que primero o segundo, hay una lógica de anticipación y retroacción. El analista se apoya en lo que el clínico señala para arrojarse a la apuesta del acto, que sólo será tal si la lectura del clínico lo sanciona.

O, de otro modo: es “el clínico” quien puede registrar lo que en la posición del analista hace obstáculo. Es el clínico, que piensa pero no causa, el que ubica en lo que resiste un punto potencial de iluminación. El que puede leer las trampas.

Así, “el analista es al menos dos”: el que se deja tomar en el juego y aquel que puede leer cuál es el juego.

²⁴ Lacan 1969, 50.

²⁵ Soler 2000, 196.

En un momento de detención de un análisis, algo señala la traba que transferencialmente muestra el punto donde el analista se hará soporte del acto.

Si no hay despertar del enredo transferencial amoroso, no hay vacío que lance el acto. Y “no hay analista sino en acto”²⁶.

4. ¿Más de dos?

Si el acto analítico es “el pase del psicoanalizante al psicoanalista”²⁷ ¿el clínico supone un retorno a la posición analizante que, como dice C. Soler, “es más soportable”²⁸?

El clínico, el que piensa y construye una teoría acerca de su padecer, es el analizante²⁹. Pero ignora que ese padecer dice de la rajadura que lo funda y sostiene. El que sí sabe algo de eso (aunque se trata de *un saber que no piensa*) es el analista que se realiza en acto para destituirse sincrónicamente.

Por eso el analista tiene “horror al acto” (Lacan). Porque pone en juego el saber acerca de la hiancia sexual que funda al sujeto en un parpadeo de abismo.

Así también, cuando alguien “presenta” un “caso” ¿en qué se autoriza para extraer de ahí preguntas o conclusiones? Esto plantea interrogantes no sólo éticos sino especialmente lógicos³⁰.

¿Dónde se habla? Seguramente en el lugar del clínico. Pero, y acá lo interesante, no sin que algo del analista participe de esa “exposición”. Aun cuando el que sostuvo el acto esté ya perdido.

¿En nombre de quién expone el clínico? ¿Habla como un tercero que ya se ha ido?

Entre esos “al menos dos” hay algo tercero que soporta la distancia estructural necesaria entre ambos.

El cuerpo del analista deja caer un añico que causa. El clínico parece no tener cuerpo. Pero los enunciados del clínico podrían ser actos ... fallidos. Hay enunciación, marcas de una división

²⁶ Soler 2000, 186.

²⁷ Lacan 1969

²⁸ Soler 2000, 197.

²⁹ Cf. el texto de F. Schejtman.

³⁰ Cf. Le Gaufey 2020.

subjetiva. Resonancias, polifonía, lecturas. Lo que permite que los enunciados no se cierren sobre sí mismos. Eso supone un cuerpo. Sutil, pero cuerpo al fin.

El detalle es que esas marcas de enunciación sólo existirán si hay una escucha lectora en acto. O sea, un analista en funciones.

Hay corporeidad tercera que se interpone anudando a los dos. Una corporeidad tercera que es un “entre” vacío, pero no insustancial, que les da a esos dos la posibilidad de armar un “agujero verdadero”³¹. Umbral para el advenimiento de lo real que el acto engendra.

Referencias

- Lacan, J. (1969) “El acto psicoanalítico”, en *Reseñas de enseñanza*. Cap. V, Buenos Aires, Manantial, 1984.
- Lacan, J. (1974-75) *El Seminario, Libro 22, R S I*, inédito, sesión del 10/12/74.
- Lacan, J. (1975-76), *El Seminario, Libro 23, El Sinthome*, Buenos Aires, Paidós, 2006
- Soler, C. (2000), *La política del acto*, Buenos Aires, Escabel, 2024. Caps. VIII y IX.
- Le Gaufey, G. (2020), *El caso en psicoanálisis: ensayo de epistemología clínica*. Córdoba, Ediciones Literales, 2021
- Schejtman, F., “¿Dónde encontrar al clínico?”. En *Analítica del Litoral*, n° 9, EOL, sección Santa Fe.

³¹ Lacan 1975-76

“El caso, la causa y el acto en la clínica analítica”

Luis Prieto

Psicoanalista. Miembro de Foro y Escuela FACL - Polo Buenos Aires. Lic. en Psicología (UBA). Docente en Clínica de Adultos I (Cát. Muraro) y Usos del Síntoma (Cát. Mazzuca). Enseñante en el Colegio Clínico del Río de la Plata.

Alicia tiene 29 años. Es directora de publicidad. Empezó el tratamiento porque se sentía ansiosa y no podía concentrarse. Consulta por videollamada dado que se encuentra en otro país. Ya tuvo dos tratamientos. El último con un colega analista que me la deriva porque ya no tenía disponibilidad horaria. La frecuencia en algunos momentos se mantiene en una vez por semana pero con períodos de mucho ausentismo. Está harta del trabajo en dirección. Su especialidad son las publicidades de autos. Si bien estudió fotografía su talento con la cámara de video la llevó a estar trabajando en algo que, en principio no disfruta pero, le permite sostenerse económicamente. Le interesa el guión y la dirección de proyectos artísticos pero nunca se siente a la altura.

El trabajo de todo el primer año y medio de tratamiento se centra en la historia de su familia. Una infancia en una zona muy pobre de Argentina y el progreso con algunos empujones de suerte, aunque según ella "todo siguió siendo precario". Una buena parte de su discurso está destinado a distintas relaciones con personas de su mismo género dado que tempranamente se cansó de los "tipos". Sin embargo, con las chicas tampoco logra hacer pie. En general, se torna desanimada y deserotizada. Mientras que sus partenaires terminan totalmente enamoradas y por ende despechadas.

La figura de la madre aparece en esa dimensión del empuje a la feminización: "en la adolescencia me llevaba a comprarme vestiditos y yo prefería pantalones desgastados y hacerme piercings". Su madre estaba muy mal, había tenido un intento de suicidio después de que su padre la abandonara por otra muchísimo más joven. Según Alicia su madre había sido cornuda toda su vida pero muy negadora.

Hace unos meses consiguió un lugar para montar su estudio. El espacio es tan grande que empieza a soñar con una serie de proyectos artísticos vinculados: clases de fotografía, ciclo de cine de autor y experimental, música electrónica. Al poco tiempo deja su trabajo en la agencia de publicidad y destina todos sus ahorros a poner en marcha el anhelado centro cultural. Empieza a funcionar pero el gasto es mayor que el ingreso. Lo primero que genera ganancias son las fiestas electrónicas donde ella suele consumir alcohol, marihuana y algo de éxtasis.

La noche del día de la madre, me disponía a cenar con mi familia y recibo un mensaje: “Luis, tuve un intento de suicidio, cuando puedas hablemos”. La urgencia me invadió y a los pocos minutos estábamos conversando. En una fiesta, hacía apenas unas horas, se había inyectado una solución ferrosa que se utiliza en ciertos aparatos que estaban en su estudio. Respondí con el manual de procedimientos del buen clínico: ponerme en contacto con su familia aquí, con sus amigos allá, dirigirla a una guardia médica. Todo a la distancia y con esas horas de diferencia que me hicieron interrumpir no sólo la cena familiar sino varias horas de descanso.

El intento fue de lo más alocado: lo único que logró fue una hinchazón del brazo bastante impresionante, inmovilidad de la articulación y una intervención de urgencia que afectó aún más su economía. Pasado el episodio, la vergüenza y el aislamiento social por no poder explicar a sus conocidos el estado de ese brazo totalmente vendado.

Ella relacionaba lo sucedido con el aumento de tensión por las deudas, el consumo de alguna sustancia esa noche, la ruptura reciente con una chica (que tampoco le importaba demasiado) y la visita de su madre a quien prefería no tener que alojar.

Todo parecía devolvernos a ese vínculo de exigencia. Hasta que le pregunté cuáles habían sido los pensamientos que tuvo durante ese momento en que se inyectó y cayó desmayada: “Seguro Raúl va a reclamarme por esta fiesta”. Raúl es quien le alquila el lugar donde funciona el centro cultural de un modo particular pues no es el dueño sino quien lo regentea como parte de la propiedad de un sindicato. Me dice que todo lo que ha invertido está en riesgo porque no hay un contrato y que unos días antes Raúl le había pedido más dinero. Intervengo señalando que parecía “bastante precario”. Es allí donde me confiesa que hasta entonces no había registrado el parecido entre Raúl y su padre, que además lleva el mismo nombre. Su padre no sólo había abandonado a su madre sino que les dejó una deuda que tardaron varios años en saldar.

Alicia sigue actualmente con el centro cultural pero se asoció con otros amigos que se ocupan del trato con Raúl. Siguen apareciendo momentos de tensión persecutoria en esa relación, amenazas de cierre del centro y pedidos de más dinero que ponen en jaque su estabilidad psíquica. Sin embargo, ha comenzado a historizar la “precariedad” y a encontrar las coordenadas de la “clandestinidad” en la que se maneja como parte de una repetición: “Me promete algo que luego no cumple... aunque creo que es lo mismo que hago yo con los demás”.

Esta breve viñeta clínica presenta las coordenadas de un intento de suicidio pero además la reflexión que me permito en este Simposio sobre la diferencia entre la clínica y ética del análisis

respecto de otras prácticas. La intersección entre la clínica y la posición del analista conlleva otro campo que no es el psicológico sino el del goce. Éste funciona como interpelación a la posición del analista. Tal dimensión fue introducida tempranamente por Freud respecto de la Cosa/causa. En su trabajo sobre la *Psicopatología de la vida cotidiana* (Freud, 1901) la sobredeterminación de los términos es arrastrada por la referencia a las “cosas últimas” (p.10). El olvido de *Signorelli* activa un mecanismo de la defensa en la clave de un particular vel alienante: *muerte o sexualidad*. Un paciente “había puesto fin a su vida a causa de una incurable perturbación sexual” (*idem*). El intento de olvido resulta en un más allá de la voluntad y muestra el lugar inequívoco del *juicio íntimo* con que Freud paga al transmitirnos esa enseñanza. El acto y la causa quedan ligados en una posición ética inédita: “algo no se logró del todo ni fracasó por completo” (Freud, 1901, p. 12).

La expresión “clínica analítica”, al igual que rectificación subjetiva, la elección forzada o la vacilación calculada, contiene una tensión que hace al nudo mismo de la dialéctica presente en un caso y la operatoria que podríamos llamar propiamente psicoanalítica, su acto. Esto se debe ni más ni menos que al estatuto ético mismo de los fundamentos de nuestra praxis, que se distinguen a nivel de la *cosa* freudiana.

Mientras que el caso implica el sostén conceptual y la puntuación lógica, el acto se ubica en un borde particular que introduce la dimensión paradójica de nuestra praxis. Resalto el término borde, ya que Lacan llama la atención sobre su lazo estrecho con aquella noción limítrofe: la pulsión. Un concepto es limítrofe y fundamental al mismo tiempo, en la medida en que hay en él una decisión, una elección.

Si la pulsión se entrama *íntimamente* al deseo del analista es porque en su estatuto encontramos la dimensión causal. Por esta razón, elevamos la casuística freudiana a paradigma. Lacan nos enseña a leer en ella los obstáculos de los cuáles Freud extrae consecuencias fundamentales para una praxis con coordenadas discursivas inéditas y una noción de acto precisa. Una clínica que merezca el calificativo de analítica se constituye de esos detalles insignificantes que nos toman por sorpresa y para los cuales no hay manual de procedimientos, ni protocolos. La incalculable nos despierta cuando la escucha puede adormecerse. La urgencia subjetiva no es lo que urge en un análisis, tampoco aquí hay relación causal.

Referencias

Freud, S. (1901) *Psicopatología de la vida cotidiana*. Amorrortu Editores.

- Lacan, J. (1959-1960): El Seminario, Libro 7: La Ética del Psicoanálisis, Ed Paidós, Buenos Aires, 2007.
- Lacan, J. (1969) “El acto psicoanalítico”, en Otros Escritos, Buenos Aires, Ed. Paidós 2012.
- Lacan, J. (1964): “Del Trieb de Freud y del deseo del psicoanalista”, en Escritos 2, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2005.
- Lombardi, G. (2015): “La libertad en psicoanálisis”, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2015.

“Efectos en la práctica del espacio de supervisión”

Adriana Bruschi , Alejandra Noguera

Este texto es el resultado de un espacio de supervisión en un marco de escuela, conformado por dos analistas y una terceridad.

El trabajo clínico se ha sostenido de la dinámica y el aprendizaje.

Alejandra Noguera:

Quisiera destacar la diferencia que ambas percibimos en el marco de este espacio versus otros que tuvimos antes, supervisar con alguien de otra escuela, o con alguien que no está en línea con los finales de análisis o sin un marco de escuela, simplemente con un profesor con el que se tuvo transferencia. El psicoanálisis puede marchar solo... pero ¿A dónde? La orientación de la cura no es algo menor o prescindible, pero habiendo transitado por esos otros espacios he podido experimentar la diferencia. Y aquí me quiero detener.

M. consulta por su reciente separación. Ha tenido dos relaciones de pareja y de cada una, un hijo. Él relata que en el momento en que se estaba muriendo su padre, ella, que quería tener un hijo, se quedó embarazada. Él se sintió engañado. Sus padres se separaron cuando él tenía un año y medio. Lo angustia algo de la repetición que él advierte.

Llevo el caso a supervisar, en el armado recorto un recuerdo: “Mi padre me contó que no quería tener un hijo y que me quiso abortar, pero mi madre no quiso”. M. presentaba una permanente apatía, desgano, se hallaba según sus palabras desvitalizado. “Me agarra la soledad y no la puedo resistir”. Trabajando el caso se señala, una deflación del deseo, erotización con la muerte, como su partenaire, goce mortífero de quedarse como el “abortado”.

Segunda supervisión

Retomando el trabajo, marco algunas precisiones con respecto a la posición subjetiva de M. en relación al Otro. Quien, de acuerdo a sus dichos, manifiesta estar a merced de aquello que supone como demanda del Otro. M. se interroga, ¿Por qué lo quiere su actual mujer?, dice: –“no soy interesante” Se puede inferir su posición fantasmática como el “no querible”, “no elegido”.

A partir del intercambio en el trabajo de supervisión, surge que hasta aquí, M. logró un lazo transferencial y una permanencia en el dispositivo. No obstante de ahora en más la orientación debería ser sacarlo del discurso lógico del yo, o sea de lo mental hacia una versión más pulsional, más inconsciente. Se observa que su relación a la pulsión es el gran ausente, (cuerpo) existe el riesgo de consistir las identificaciones paternas, la trampa del obsesivo. ¿Cómo maniobrar para salir del sentido? Yendo al detalle con la letra, la equivocidad del significante, por la vía del sin sentido, cortar, jugar con las asociaciones, analizar.

Adriana Bruschi:

A partir de la convocatoria y de los temas sugeridos, me interesa trabajar el tema de la supervisión o control (ambos nombres fallidos) a la luz de dos conceptos: REPETICIÓN Y CORTE.

Sabemos que la transmisión de un “caso” implica un trabajo, no es una repetición literal, aunque conlleve algo de la repetición de los dichos del analizante, pero quien escucha, corta, recorta.

Una primera transmisión es la del analizante al analista, hay ahí un corte y luego llevar eso a otro espacio nuevamente otro corte.

¿Qué se repite? ¿Qué se corta? Corte como selección del material, repetición de la palabra escuchada. ¿Cómo se conjugan, articulan?

Repetición y recorte.

B consulta por sus desventuras amorosas. Es una mujer con un exitoso desempeño laboral, no obstante, su padecer se centra en las relaciones con los hombres.

Entre los episodios de su vida: cuenta que ha realizado un trabajo en el exterior en un lugar muy extremo (work and travel) y ha estudiado además de inglés otro idioma que también llama la atención por ser muy inusual.

Llevo este caso al espacio de supervisión, debido a que hasta ese momento me encontraba desorientada.

Trabajando el material, surge el significante “extranjero” que, si bien no estaba explícito, se podía extraer (mecanismo de condensación). B tenía una gran atracción por aquello que se le presentaba

como extranjero. Retornando al trabajo con B, introduce este significante, que ella toma y sustituye por otro significante, pero ya propio “extraño”. Este es un significante que significa a su padre. El caso se abre, de esa desorientación inicial surge un hacia dónde. B asocia sus padecer con los hombres, sus elegidos son extraños.

Segunda supervisión

Vuelvo a llevar el caso al espacio, habiendo transcurrido algunas sesiones más. B. historifica sus distintas relaciones de pareja. Se detiene en una escena con uno de sus partenaires en la cual cuando estaban compartiendo una comida, él le dice que lleva un arma. B. se sorprende y retoma el significante “EXTRAÑO” dice: “ no sabía nada de él” luego exclama “Tampoco sé nada de vos” El significante EXTRAÑO se enlaza a la transferencia en acto.

A partir de este trabajo, de elaboración se repite y recorta una secuencia, que presenta una lógica propia.

B. comenzó una relación de pareja, con alguien que no se le presenta como un extraño. No obstante, se infiere que la dificultad está en lo familiar. La orientación es a partir de la pregunta ¿Cómo se hace familia-familiar?

CONCLUSIONES:

Retomando el punto de partida, es notorio en las dos viñetas los efectos que se produjeron a partir de la supervisión.

La transmisión y elaboración, no solo en construir el caso, sino también de este trabajo de escritura vuelve a poner en acto eso que es el psicoanálisis.

En cada HIANCIA se lanza algo, soportando que no hay garantías, un saber que se produce “entre”.

Un analista que se habilita a partir de UN NO SABER, estructural, se permite abrir sus casos al trabajo entre-otros (lazo a la escuela).

“Estilo y transmisión en la formación del analista”

Katarina Vidal Aragão

Psicoanalista, miembro del IF/EpfcI - Brasil - Foro Aracaju. Coordinadora de la red de investigación Psicoanálisis e Infancia en el Foro Aracaju. Perita externa del Tribunal de Justicia.

La propuesta de este trabajo viene del argumento del Simposio , " cómo volver hoy, casi medio siglo después, al último Lacan, el de la sección Clínica y del Seminario disolución intentando restituir el decir de Freud en el psicoanálisis, en la praxis de la teoría, en la clínica, en la enseñanza?" La transmisión del psicoanálisis está ligada a lo que el analista puede comunicar de los análisis que conduce, por lo tanto no se hace transmisión del psicoanálisis sin la clínica. Pero es la formación del psicoanalista la que condiciona "que el sujeto se halle capaz de sostener una demanda de análisis que otro le hace y de conducir este análisis hasta un término reconocido como tal" (Silvestre, 1981). Reconocer la formación del analista, o más bien su estilo, y su escuela dice de un compromiso para llevar a cabo la transmisión a través de su trabajo en la clínica. En la formación del analista lacaniano "el analista sólo se autoriza por sí mismo", lo que lo confronta, permanentemente, con la responsabilidad del acto, el cual posiciona al analista como autor o co-autor de algo nuevo.

La formación del analista y las consecuencias en la transmisión, en cuanto a eso cuál es la función del estilo? Curiosamente, el estilo forma parte de lo que en el discurso no es lenguaje, ni tampoco lalengua, aunque se utilice de las dos. Por lo tanto, el estilo tiene una función en la transmisión — "Lacan la subrayó en su enseñanza. En un discurso, el estilo es un factor independiente que se sitúa del lado de la manera: manera de decir, manera de hacer, y también en la conducta, pues el estilo no es sólo el estilo de la escritura que hace al escritor, hay el estilo propio al acto de enunciación, propio a toda conducta". (Soller, 2011)

La posición del analista en la curación supone abandonarse al inconsciente en la escucha, sin fijar la atención en nada en especial, sino en todo por igual. Llegar a este lugar de analista depende del modo singular, implicando ciertos efectos de lalengua con la cual él abordó su des-ser. En esto se sitúa lo que lo inspira en su acto por venir, tal es su dependencia de la práctica de la letra.

Teniendo en cuenta la política del psicoanálisis, aquella que es sustentada por el deseo del psicoanalista, que permite al sujeto lidiar con la imposibilidad-estructural-del saber traer algunos apuntes de un caso clínico:

Consigo Alan traído por la madre, debido al intercambio de fonemas, no habla "correctamente". Presenta comportamiento agresivo e infantil, dificultad de relacionamiento y de lidiar con Normas. "Él no tiene problema de cognición, pero pierde punto en la prueba, cuando escribe mal". Todo tiene que ver con la ausencia del Padre. "- No tiene límites"!

La madre relata que lo trae ajeno a la voluntad del Padre. Cuando me pregunto por qué, me doy cuenta de que el padre no participa en la vida del niño. Ella hace referencia a un hombre que simplemente la dejó embarazada y lo acusó de ser el padre de su hijo. Le pregunto si puedo llamar a "papá" para una entrevista, pero ella dudaba de que viniera. Alan, atento a todo, no para, y cuando escucha la palabra padre se pone aún más agitado, "poniendo el consultorio al revés". Hace diez años la madre de Alan convive maritalmente con André, y él hace cuestión de ocupar función paterna, pero la madre no deja, pues Alan tiene un "padre".

El padre (biológico) acepta venir, pero ella cree que él sólo lo hace por reconocer que mi nombre está ligado a "algunos trabajos con la justicia". Alan llama a su padre a jugar y no es atendido. El padre justifica sus ausencias y acusa a la madre de alienación (concepto inventado que no nos sirve). Cuando al ser padre, él paga las cuentas e incluso los pagos de las sesiones lo hace siempre con retraso. (Es un padre atrasado)

Partiendo del supuesto de que el síntoma del niño revela lo que hay de no-dicho, de encubierto o de sintomático en la estructura familiar, tenemos que estar atentos al habla de los padres. El análisis con niños implica verificación de momentos de constitución subjetiva y tratamiento del goce en el sentido de interrogar el deseo en su realización como sujeto. El análisis es del sujeto, aun cuando sus significantes históricos son traídos por otro. Estar atento a lo que hace la singularidad del niño, a las historias contadas por otro, no es más que el reflejo de lo que le fue ofrecido en término de saber, del goce como encuentro traumático con el otro y del objeto a lo que fue en el deseo del otro?

Volviendo a la narrativa en torno al niño-objeto, me remito a un Alan que, al inicio de las entrevistas, no cabía en mi consultorio, por ser un niño grande que cuando llega llora, grita, se tira

al suelo y al jugar y perder, tira todo por la sala, diciendo: "– Yo siempre pierdo... no puedo soportar perder más."Y suele elegir el mismo juego. "damas"; Conecta Cuatro (mamá, papá, él, buenodrasto). La madre revela que tuvo un padre ausente y no deseaba esta realidad para su hijo. Señalo que tiene a André, su compañero que desea estar en este lugar y que se ve reforzado por la solicitud de Alan. Revela también que siente dificultades de conversar con su hijo, no habló de las dificultades en el embarazo, del abandono, de haberse relacionado con un hombre casado con tres hijos, y que Alan es el cuarto de este padre. Juan es operador del derecho y siempre se utiliza de las leyes para aterrorizar a la madre, en cuanto al pago de la pensión. Me pregunto ¿por qué nunca buscó el derecho de su hijo? André pide una sesión para saber qué puede hacer para ayudar a Alan. Dice que Alan está mejor y cuando papá llama, dice que no quiere contestar. Porque Juan llama, como máximo, cuatro veces al año. No aguanta más tener que ver al niño sufriendo, la madre buscando un padre que no existe y no dejándolo hacer función paterna, y me pregunta qué debe hacer. Le pregunto qué piensa él ante esta situación, a lo que él me responde sólo si yo Peleo y yo le respondo que un padre puede pelear por el hijo.

Al comenzar a escuchar su historia, Alan comienza a calmarse y ahora cuando pierde dice: - lo que importa es jugar, no es tía?

En el caso en pantalla, la madre de Alan, finalmente entró en la justicia para denunciar la negligencia del padre de Alan, en cuanto al pago de las cuentas y ya no solicita informes a la escuela para justificar el intercambio de sonidos. Alan puede perder a su padre construido por su madre y ha constituido una relación de confianza y afecto con André, su padrastro al que llama padre.

El análisis de niños se constituye como efecto de un estilo que no puede ser imitado, pero que es fruto del propio análisis del analista con toda la singularidad que marca su relación con el psicoanálisis.

“El pase, el control y la transmisión de la práctica clínica: un trípode para interrogar los problemas cruciales del psicoanálisis”

Juan Manuel Moraña

Psicoanalista. Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de Escuela y del Foro Argentino del Campo Lacaniano, Polo Buenos Aires. Enseñante del Colegio Clínico del Foro Argentino del Campo Lacaniano, Polo Buenos Aires Investigador UBACyT y becario doctoral de la Universidad de Buenos Aires

Docente en la Cátedra I, “Clínica Psicológica y Psicoterapias: Clínica de Adultos”, a cargo de la Prof. Tit. Dra. Vanina Muraro de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Docente en la Cátedra, “Usos del Síntoma”, a cargo del Prof. Tit. Dr. Marcelo Mazzuca de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.

Algunas reflexiones acerca del pase, el control y la transmisión de la práctica clínica en tanto trípode para interrogación de los problemas cruciales del psicoanálisis.

El procedimiento del pase

Transmitir y aprehender los efectos del acto analítico, específicamente aquellos que hacen a la aptitud para sostener el deseo del analista, reviste una dificultad que mantuvo a Lacan ocupado en su formalización. De allí la afirmación que sostiene que “los analistas son los sabios de un saber acerca del cual no pueden conversar”, el procedimiento del pase responde a esta dificultad. La “sombra espesa” a la que Lacan hace referencia tiene su fundamento en la aporía propia del acto: no hay sujeto que pueda testimoniar, “dar cuenta” sobre el momento del pase porque el sujeto no es causa del acto, sino su producto, transformándolo. Cómo testimoniar sobre lo real es imposible, al pasante sólo le queda arriesgarse a testimoniar de la mejor manera sobre la verdad mentirosa poniendo a prueba la *hystorización* del propio análisis. Es así como el pase se erige como órgano de garantía que tiene por objetivo la verificación del real en juego en la formación del analista en el punto justo donde lo que busca ser aprehendido pone en jaque a la transmisión del saber. El procedimiento del pase no tendría sentido sino por restituir una garantía en la formación del analista que por estructura se encuentra más allá de la reflexividad. Si existe es para demostrar este *impasse*, echar luz sobre el momento electivo del pasaje en que adviene el deseo del analista.

La nominación de AE implica el compromiso con la transmisión de un saber elaborable que retorne a la Escuela, que promueva la interrogación sobre los problemas cruciales del psicoanálisis.

El control

El control anuda los primeros dos pilares que Freud postula para la formación del analista: el análisis personal y el estudio de la teoría. Al abandonar la soledad del acto, el analista se aventura a la intimidad del encuentro con otro donde pondrá a prueba, por primera vez, su aptitud para sostener las condiciones del acto (su autorización como tal) leyendo retroactivamente sus consecuencias en la dirección de las curas que sostiene.

Para Lacan el control se impone al analista en formación como una exigencia ética: “Algo está en juego aquí de una responsabilidad que la realidad impone al sujeto, cuando es practicante, de asumir el riesgo.” No se trata de poner a prueba su conocimiento, sino, el saber que ha podido extraer de su propio análisis, con el que opera, soportando el acto analítico.

Sin dudas el control es necesario para el joven analista ya que es el espacio donde se inaugurará la dimensión del clínico que lo habita, el espacio donde formalizará la experiencia y obtendrá un saber hacer acerca de la función que decidió sostener.

¿Acaso los analistas “con experiencia” continúan con esta exigencia que Lacan delega a los practicantes? ¿Es posible ser supervisor del propio acto analítico? ¿Si el acto está en la lectura del acto, quién es el que lee? ¿pueden superponerse los lugares de supervisante-analizante y de supervisor-lector de los efectos del acto analítico?

La transmisión de la práctica clínica.

En la Proposición del 9 de octubre del 67, Lacan hace dos afirmaciones que inicialmente me resultaron paradójicas: por un lado, que “El analista no se autoriza sino por sí mismo” y, por otro, que esto no excluye que la Escuela garantice que un analista depende de su formación ofreciendo una garantía a aquellos que la quieran. “Ella puede y, en consecuencia, debe hacerlo” sostiene Lacan.

Tiempo después pude leer algunos detalles que había soslayado: en 1977, en la “Apertura de la sección clínica”, Lacan sostiene que la clínica psicoanalítica consiste en interrogar al psicoanálisis, todo lo que Freud, como el mismo Lacan, han dicho, y a los analistas, urgiéndolos a que den sus razones. Para señalar esto último Lacan utiliza el verbo “*presser*” que significa “presionar”, “apretar”, es decir, no se trata de un consejo al estilo freudiano sino de una exigencia que se le impone al analista. Es por esa misma exigencia que sostuvo, pocos años antes en el Seminario 22, que “es *indispensable* que el analista sea al menos dos”, el que sostiene el acto analítico y el que teoriza sus efectos, es decir, el que formaliza su práctica dando sus razones acerca de los efectos

que ha causado el acto que sostuvo. Parece ser entonces una responsabilidad de la cual el analista no debería quedar dispensado.

Este hallazgo echó luz acerca del agregado que hace Lacan en el Seminario 21 a propósito de la autorización del analista al sostener que “al autorizarse sólo por sí mismo el analista no puede con ello sino autorizarse también por otros”. Entiendo ahora que esta autorización, en soledad efectuada a partir de la transformación del propio análisis, no puede no ser puesta a prueba, es decir, ofrecerse a la autenticación en la Escuela. Si el acto está en la lectura del acto, el modo en que un analista puede dar pruebas de serlo y autenticado por la Escuela (es decir, AME) es ofreciendo pruebas de los efectos, de las consecuencias que tiene en sus analizantes el acto que sostuvo.

Los analistas que ofrecen su práctica clínica a la Escuela asumen el riesgo, no solo de poner a prueba sus aptitudes para soportar el acto analítico, sino, sobre todo, asumen el compromiso de una transmisión en acto de los efectos del deseo del analista. “El analista debe llevar esa marca, a sus congéneres les toca saber hallarla”, dice Lacan en la Nota Italiana.

Al “hacer Escuela” crean un espacio propicio donde poder articular un decir que tenga consecuencias comprometido con el porvenir del psicoanálisis, es decir, teorizar tanto acerca de sus problemas como de su vigencia y eficacia. La Escuela es un espacio donde poner en acto que “la ética del psicoanálisis es la praxis de su teoría”, con otros.

MESA 7 - EL PASE

Luciana Guarreschi (EPFCL -FCL São Paulo)

Índices de pase clínico

Matías Buttini (FA- BA)

El analista y el clínico designados en un pasador.

Pedro Moacyr C. Brandão Junior (EPFCL- Sao Região Serrana)

Notas sobre lo intransmisible y la reinención del psicoanálisis. Qué de los pasadores

Dyhalma Ávila (Foro Puerto Rico).

¿“Sin tomar en cuenta procedencias ni calificaciones”?

La enrevesada pregunta por la designación del pasador

Andrea Fernandes (EPFCL- FCL Salvador)

Psicoanálisis y pase: ¿qué hay de nuevo?

Fernando Martínez (FA-Patagonia)

El momento de designación

“Índices de pase clínico”

Luciana Guarreschi

AME de la IF-EPFCL. Maestría en Psicología Clínica en la Universidad de Sao Paulo. Trabaja en Sao Paulo.

Acabó, está acabado, casi acabando, debe estar casi acabando.

Los granos se acumulan, uno a uno, y un día, de repente,

ahí está un montón, un amontonamiento, el montón imposible.³²

Este texto proviene de un cartel constituido por los cinco recién nombrados AMEs de la Zona Brasil. Lejos de hacer un índice remisivo de lo que sería necesario para designar a un pasador, nos lanzamos a mapear factores de referencia, otro significado de la palabra índice, que sirve para analizar una condición, en este caso, de aquel que esta pasador, aunque aún no designado. De ahí el nombre: índices **del pase clínico, condición primera del analizante pasador.**

Mi pregunta en el cartel es: **¿cuáles serían las buenas preguntas que nos permitirían cartografiar el momento de la designación del pasador?** Claro que la respuesta a cada una de ellas será caso por caso y está a cargo del analista. No es que la percepción del pase clínico estuviera ausente de nuestras escuchas y de nuestra propia experiencia, pero la responsabilidad de la designación plantea otros cuestionamientos. Nuestra escuela tiene 25 años de discusiones sobre la función de pasador, pero cuando llega su turno, hay que rehacer el camino, construyendo un saber propio sobre esto.

Conocemos las indicaciones de Lacan sobre la función del pasador. Y es innegable que su obra busca, en momentos y formas distintas, mapear las transmutaciones artificiales³³ que ocurren a lo largo de un análisis dirigido a su fin, a saber, producir un analista. El pasador está ahí, en ese

³² Beckett, Samuel. Fin de partida, São Paulo: Cosac Naify, 2002, p. 38.

³³ La transmutación artificial es un proceso químico en el que núcleos atómicos de un elemento son modificados para convertirse en núcleos de un elemento diferente, a través de un proceso artificial, que implica bombardeo con partículas subatómicas. A diferencia de la transmutación natural, que ocurre espontáneamente debido a la inestabilidad nuclear, **la transmutación artificial requiere una intervención activa.**

paso esencial para que haya psicoanálisis en el mundo, instante de pasaje a analista, al menos quiere creer el AME responsable por su designación.

Creencia sí, pero no sin algunas balizas que el analizante debe aportar para que la apuesta en la designación provenga de un cálculo mínimo. El analista busca algún indicativo – evidencia, presagio, prueba, muestra, destello, impresión, sombra – por el cual el analizante deja entrever su condición de pasante, en términos clínicos, y posible pasador en el dispositivo del pase.

Voy a ahorrarles las citas de Lacan y seguir con Beckett, en *Fin de partida*. Ustedes conocen la obra: Hamm y Clov están atrapados en un refugio, intercambian diálogos impenetrables sobre la condición humana en la que se encuentran, la no relación que establecieron durante años y la soledad extrema del fin próximo. Hamm es un artista fracasado, ciego y paralítico. Clov es su sirviente y tiene una afección que no lo deja sentar. Mutilados espían lo que quedó del mundo.

En cierto momento Hamm dice: *¿estás oyendo? ¿estás oyendo? Ladrillos huecos. ¡Todo esto es hueco! ¡Basta! ¡De vuelta!*³⁴. Es de él que tomo la primera pregunta cartográfica: **¿puede este analizante habitar el silencio a pesar de la angustia ruidosa de su desmoronamiento fantasmático, donde lo hueco del mundo le asombra y lo hace vacilar continuamente a la espera de un regreso que no existe?** Si es así, ¿cómo? Una vez sorteado, ¿podría saber tan solo, como siempre ha estado, en la tarea que le espera?

Hamm pregunta angustiado: *¿Pero qué está sucediendo, qué está sucediendo?* Clov solo puede decir: *algo sigue su curso*³⁵. El analista, en este momento, habla poco, pues está en riesgo, ya que la falla del sujeto supuesto saber es patente y, sin embargo, él *sigue sosteniendo el lugar del semblante de objeto a, causa real*³⁶. Hamm, impaciente, patalea. Lo que me ayuda en otra pregunta: aunque “pasando mal”, **¿el posible pasador sigue su curso por las migajas que sobraron de su verdad mentirosa?** Sabemos que, en este momento, algunos se van, sin que el analista pueda hacer nada más que lamentar.

Momento en que sueños reducidos de imágenes, rápidos, certeros y marcadamente grafemáticos proliferan. Sí, estos mismos sueños pueden estar presentes a lo largo de todo un

³⁴ Beckett, Samuel. *Fin de partida*, São Paulo: Cosac Naify, 2002, p. 72.

³⁵ Idem, p. 55.

³⁶ Sandra Berta, Designar para una función – f(x): pasador. Trabajo presentado en el Espacio Escuela “¿Qué se espera de la función AME?”. por ocasión del Encuentro Nacional de 2024.

análisis, pero en el pase clínico, no se prestan más a elucubraciones, no **quieren** decir más nada, **solo dicen**. Y angustian. Pregunta cartográfica: ¿**Qué consecuencia saca el analizante de lo que dice de sus sueños?** ¿Corta el texto irrespetuosamente, toma lo incierto por lo cierto, extiende el espacio fuera de las leyes que proscriben la contradicción³⁷ o busca más una significación? Hamm bien que intenta: *¿No estamos comenzando a... a... significar algo?* Clov no deja: *¿significar? ¡Nosotros, significar! ¡Ah! ¡eso es bueno!*³⁸.

El fin se aproxima, pero ambos no saben cuándo será, el impasse de la no relación está evidenciado, Clov *no puede sentarse* y Hamm, *es verdad, no puede mantenerse en pie*³⁹. Los “no hay” abundan por la posición del analista: *No existe más naturaleza. No hay más marea. No hay más mantas. No hay más ataúdes. No hay más calmantes*⁴⁰. Hamm insiste: *¡pero la cajita estaba llena! Sí, pero ahora está vacía*, responde Clov. ¿Cuál es la cartografía del tiempo de la vacilación, no en su duración, sino en su velocidad? ¿**Cuánto tolera nuestro posible pasador la velocidad de su vacilación entre la inconsistencia y la incompletud?** Pues es cierto que ya no vacila entre completo e incompleto, consistente e inconsistente, eso la neurosis lo hace desde siempre.

Hamm dice: *no puedo dejarte*. Clov, sirviente analista, responde: *Lo sé y ni siquiera puedes seguirme*⁴¹. Suspendidos, siguen hasta el final de la partida.

³⁷ Barthes, R. El rumor de la lengua. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, p. 41.

³⁸ Beckett, Samuel. Fin de partida, São Paulo: Cosac Naify, 2002, p. 81.

³⁹ Beckett, Samuel. Fin de partida, São Paulo: Cosac Naify, 2002, p. 50.

⁴⁰ Idem, pp. 119-139.

⁴¹ Idem, p. 99.

“El analista y el clínico designados en un pasador”

Matias Buttini

Matías Buttini trabaja como psicoanalista, es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Foro Argentino del Campo Lacaniano (FACL) – Polo Buenos Aires, y Analista Miembro de la Internacional de los Foros – Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano (A.M.E. de la IF-EPFCL). Fue docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires, donde coordinó el Área de Hospitales y Prácticas Institucionales de la cátedra de Clínica de Adultos, en la que actualmente enseña. También es docente en el Colegio Clínico del Río de la Plata y en el Clinical College of Colorado (EE.UU.). Además, coordina el área de Psicología y Hostales de Salud Mental en la Institución Psicoterapéutica Témpora. Ha publicado artículos y libros sobre psicoanálisis, literatura y cine, así como las obras Nadie soporta una vida encantadora (Lettra viva, 2012), Deporte maligno (Ñamandú, 2019) y Cauces del goce (Escabel, 2022) en coautoría con F. Martínez y A. Rostagnotto.

Eso sólo conforma a todo el mundo por no tener ninguna consecuencia fastidiosa, ya que
está hecho para eso, para el provenir psicoanalítico mismo, es decir, para todos aquellos
que están en el mismo barco

J. Lacan. “...o peor”

Homero decía que las sirenas llenaban el alma de Ulises con un *deseo de escuchar* en estado puro. Apolonio dice, con más radicalidad todavía, que las Sirenas llenan el alma
más arcaica de Butes con un *deseo de aproximarse* en estado puro

P. Quignard. “Butes”

Al analista, designado por sus colegas y su escuela, AME, le toca a su vez, designar pasadores entre sus analizantes ¿Cómo hace eso? Según el *Reglamento Interno* lo hace “en el momento que le parece oportuno”. Designación y oportunidad, ambos términos están implicados, se anudan en ese acto de designación donde el analista, pasa al clínico. El pase del analista al clínico no es todo el tiempo, es por cortes. Cuando controla un caso, cuando lo escribe, cuando teoriza esos efectos, cuando sopesa el acto, fuera de él pero usando “esa salida como entrada” (Lacan: EFP, 1967).

Cuando designa un pasador, también lo hace desde ese pase del analista al clínico y retorno. Lacan inventa el verbo *clínicar* para denominar el acto de acostar a quien tiene la esperanza de obtener algún beneficio de su decir. Cuando luego de varias vueltas, el analista-AME cree captar

el momento oportuno, hace clínica de esos efectos del decir del analizante y podría designar ese momento. ¿Qué beneficios podría obtener el analizante designado pasador? No lo sabemos de antemano, apuesta sesgada, sin duda y se corre un riesgo por ello, que coincide con la lógica del Inconsciente: se lo lee una vez efectuado.

Sin caer en las fórmulas conocidas, ¿qué es designar? Según el diccionario es el acto de “nombrar, señalar, destinar a cierto fin... marcar. Poner un “signo”, marca y huella de una posibilidad, de una elección, de un deseo, primero del AME, luego a ser corroborada o rechazada por el pasador. El deseo del analista, no podría no dejar su huella de transmisión. Transmisión del Inconsciente. En ese acto, se designa al-menos-dos: un clínico que designa un pasador de entre sus analizantes y ese pasador que deberá, a su vez aceptar o rechazar la propuesta.

La condición previa será la designación del AME por sus colegas en la escuela, pero es sólo condición en potencia... No será AME hasta que designe un pasador, única función original que Lacan ha dada en su *Proposición*.

Recibe un llamado de un desconocido, me cuenta un analizante, que le dice que ha sido nombrado como pasador de *su* pase. “Debe haber un error”, dice. Bien podría ser un error, es una posibilidad, *wait and see*. Y sin embargo, ese analizante tomará a cargo el “error” y aceptará. Nunca tan certero el Inconsciente que al fracasar.

En *Sobre la experiencia del pase* (1973) Lacan propone que un pasador sea designado por su analista, “independientemente de su consentimiento”. Lo importante, dice, es que el que lo oye no se muestre altanero”. Estas precisiones de Lacan dan lugar a su expectativa: “evitar el retorno a las viejas usanzas”. Agregaré que la transmisión no sea dirigida “a un viejo de la vieja guardia”. El pase busca una experiencia, siempre joven, que debe poder “*apartar de su piel, la funesta vejéz*”, para decirlo con Apolonio (p.205).

El pase al clínico permite un *refresh*⁴² de su escucha y detectar signos de que el analizante, se ha posicionado de otro modo frente al Inconsciente a su deseo por el psicoanálisis.

Ahora bien, ¿por qué hay necesidad de AME? Se lo asocia a no sé que tipo de consagración, de trayectoria, de mueble viejo. Punto problemático si seguimos a la letra la propuesta de Lacan y

⁴² Evocamos acá a la palabra usada en inglés usada por algunas señoras mayores para hablar con *snobismo* de una cirugía del rostro para quitarse las arrugas, reflejo inocente del paso del tiempo.

su insistencia en renovar la experiencia con su Pase. El AME deberá hacer un poco más como Butes y no rehuir tanto el salto, cuando se trata de su acto. Retomaré este ejemplo luego de un rodeo necesario.

En los inicios de nuestra Escuela, M. Bousseyroux (*Wunsch n° 4*) detalla las repercusiones que sucedieron a la *Proposición* de Lacan y que lo condujeron a modificar su primera versión en algunos puntos sensibles. Uno de ellos, fue el AME como la figura encargada de la designación de pasadores. Aquel que, curiosamente, encarnará lo nuevo que con el objetivo de “quebrar la rutina”, ir contra el envejecimiento de la Escuela. Esto generó reacciones lo que evidencia que se tocó un punto delicado de poder y puso al pase en el lugar de síntoma institucional. Con la caída de la figura del Otro didacta, encargado, unidireccionalmente de la transmisión del psicoanálisis, cae un imperio. Lacan introduce la figura del AME, como el encargado de designar a un nuevo, “apto y sensible” (los términos son de Freud y de Lacan) pasador del Inconsciente. Este movimiento produce al menos tres olas fuertes al interior de la política de la Escuela:

- Caída del Otro didacta y permeabilidad a nuevos caminos...
- Retorno de lo reprimido/atesorado en ese Otro del saber pretendidamente asegurado por la trayectoria y consagración: varias renunciaciones de colegas
- Deber de correr algún riesgo propio de producir un saber nuevo, en contraposición a la vieja y conocida “feliz incertidumbre”⁴³

La Escuela de Lacan no deberá permitir que los didactas de ayer, de hoy y de siempre, se instalen cómodamente. Sin embargo, el dispositivo no puede continuar sin quien designe a esos pasadores, ahora deducidos de los análisis. El AME es aquel al que la Escuela le supondrá saber detectar el momento del pase entre sus analizantes. Agrega M. Bousseyroux que se trata de “apostar a la capacidad de discernir si ese analizante está preparado para implicarse en la experiencia de la Escuela y aportar su contribución...”. El AME queda designado detrás de cada analizante al que designa como pasador.

Acá hay otro curioso desdoblamiento, que recae sobre el pasador: hacer pasar el testimonio de la verdad del pasante a juzgar en el cartel y también en cuanto a *su* contribución epistémica en la transmisión. Ambas expectativas de una Escuela ubicables en el Pase, recaen sobre la

⁴³ Expresión de Lacan en el seminario 3, *Las psicosis*, para referirse al neurótico que no sabe y no quiere saber.

designación del AME, que tiene a su cargo teorizar toda una serie de elementos derivados de los efectos de su accionar clínico. Como toda teorización, deberá ser corroborada o caer. La causa y el efecto están más separados aquí, por ello es más que deseable que la función de AME sea proclive a la división.

Al igual que Butes el AME debe arrojarse sin más al mar cada vez que propone a alguien. ¡Siendo designado por su propia designación! Su propio mensaje podría explotarle en las manos. ¿Quién es Butes? Un “intruso”, uno de esos personajes marginales de los que Pascal Quignard se sirve para presentar un problema. Es integrante del barco que pasa por la mítica isla donde las Sirenas elevan su canto mortífero a los marineros para engañarlos y devorarlos. Personaje antagónico de Ulises, quien recordemos, pide ser atado al mástil para escuchar “sin riesgo” de saltar, y de Orfeo quien tapa el canto de las sirenas tocando su lira. Butes se deja ir y salta. Es un *disidente* y por ello alguna “consecuencia fastidiosa deberá poder asumir. El intruso, salta, disiente al mismo tiempo que se afirma en su acto, pues quiere aproximarse a ese engañoso canto y ese canto de-signa su salto como oportunidad.

El pasador es un intruso designado de la extensión de la Escuela, sin dejar de la lado la intensidad por la que aún transita. El pasador, literalmente *transeúnte* ¿no invoca el salto propio de toda exogamia? El pase es una expansión de la Escuela como Causa y una *aproximación* a la contraexperiencia institucional vital. Su puesta en funcionamiento implica desanudar⁴⁴ y desbordar los márgenes del continente navío psicoanalítico.-

Referencias

- Apolonio de Rodas. (1987). *El viaje de los Argonautas* (C. García Gual, Trans.). 1ª reimpresión Libro de Bolsillo, Alianza Editorial, Madrid, 1992. (Obra original publicada ca. 3.º siglo a. C.)
- Bousseyroux, M. (2006). “*Posición de Lacan respecto a la designación y funciones del pasador*”. Dos contribuciones en la tarde sobre el pasador, de l'EPFCL-Francia, 1º de abril 2006. En *Wunsch* nº 4.
- Lacan, J. (1967) “*Proposición del 9 de octubre de 1967*”. Primera versión. En Ornica?, Petrel.

⁴⁴ Es Quignard quien señala que la primer aparición en el mundo griego del término *análisis*, desatar, se corresponde con esa escena en el verso 200 del Canto XII de la *Odisea* de Homero. Lacan evoca la misma escena en su apertura del seminario “...o peor”, reflatando la idea de un psicoanalista como Ulises que, atado al mástil/falo, escucha sí, pero todo al revés. Sirenas de la Escuela y el Pase, en lugar de quedarnos atados al mástil del navío sólo escuchando -su goce de escuchar, *j'oui* - un canto sobre el que no se puede actuar sino maniatado. Ese goce, atado al mástil fálico, deja al psicoanalista como Ulises: atado al sentido común, al “significado principal, global”.

- Lacan, J. (1967) Discurso a la E.F.P." 6 de diciembre de 1967. En Directorio IF-EPFCL.
- Lacan, J. (1971-72) *"El Seminario, libro 19: ...o peor"*. Ed. Paidós, Bs. As., 2012.
- Lacan, J., (1973) *"Sobre la experiencia del pase"*. En Ornica?, Petrel.
- Lacan, J. (1977). Apertura de la sección clínica. En Ornica? Nº 3. Petrel, Barcelona, 1981.
- Quignard, P. (2011) *"Butes"*. Ed. Sexto piso, Madrid, 2012.

“Notas sobre la invención y lo intransmisible”

Pedro Moacyr Brandão

Miembro de la Escuela EPFCL-Brasil y miembro del Foro del Campo Lacaniano Região Serrana/RJ, actualmente integra la Comisión Epistémica Local de Recepción y Garantía de la EPFCL-Brasil (CLEAG-2025-2026). Autor de los libros «Paradojas del dolor: del dolor de existir a los dolores del cuerpo» y «Abusos de la sexualidad».

Mi argumento es el efecto sobre *sólo después* de mi experiencia como pasador, pero también en el presente trabajo en un cartel intercontinental. Propongo abordar la cuestión de la transmisión, señalando lo que implica como intransmisible del psicoanálisis, por lo tanto, el vislumbre de que se trata de una invención. Para ello, parto de la Proposición de Lacan, que sitúa al pasador como testigo: él es, todavía, el pase, “es decir, en quien el *de-ser* está presente en ese momento en que su psicoanalista conserva la esencia de lo que le es transmitido como duelo” (Lacan, 1967, p. 260). Si el ser viene a dar consistencia al Otro del lenguaje, lo simbólico lo hace pare(S)er, parece darle un apoyo para ser.

Pero un análisis se mueve en dirección a lo real, apostando a que el ser hablante, en el límite, se encuentra cara a cara con su soledad. En Mais, Ainda, Lacan (1972/73) nos recuerda que “quien habla sólo tiene que ver con la soledad” (p.163), en la medida en que la soledad deja una huella de ruptura del ser, revelando el fracaso del supuesto saber. Así, el psicoanálisis tiene los efectos de un saber hacer con lo real que sostiene el “todo-solo” inherente al hablaser, una clínica del acto en el campo del goce. El saber que produce un análisis es una invención, (es)fecto un producto de la propia trayectoria del análisis. “El psicoanalizante hace al psicoanalista” y “el psicoanalista se hace del objeto a” (Lacan, 1969, p. 375), se hace del saber que es un desecho, resto de la operación en la que el analista se encuentra con el *de-ser*, no sin pasar por el horror, y la tristeza, y un duelo diferente al de la caída de los vínculos con los objetos.

En el torbellino de los confines de su análisis, el pasador es elegido y acepta escuchar algo sobre el camino que llevó a alguien a autorizarse como analista. Al cartel de pase, tiene como función dar testimonio de una verdad como causa y transmitir un fragmento de saber (Bousseyroux, Wunsch 4). El pasador se enfrenta a un encuentro con lo imposible, con lo real que lo coloca ante los límites del saber, pues no hay reglas ni indicaciones de cómo serán los encuentros con el pasante, y qué, y cómo, aportará al cartel lo escuchado. Lo cual remite al pasador a las coordenadas que debe extraer de su propia experiencia de análisis.

Del lado del analista, el pasador es el pase en el que “se conserva la esencia de lo que le es transmitido como duelo”. “Duelo para el analizante, *de-ser* para el analista», dice Colette Soler (Wunsch 12). Por otro lado, está el analizante. En el pase, el tiempo y el espacio están en juego. Para el pasador, es hora de continuar en la intención, aún más, hacia la soledad que conlleva la experiencia. Es un trípode –pasante-pasador-cartel del pase, como se plantea en la Nota Italiana, pero no sin la Escuela para trabajar en garantizar un espacio para la transmisión del saber de lo real, de la causa, singular.

En la Nota italiana, Lacan nos recuerda que el saber no es todo elaborado y, por lo tanto, queda por ser inventado. De este modo, transmisión e invención se unen. Más adelante añade una curiosa afirmación: “el psicoanálisis es intransmisible” (Lacan, 1978), lo que obliga al psicoanalista a reinventar el psicoanálisis. Así pues, la transmisión parece posible si se considera lo imposible, lo intransmisible. La invención entonces, es un efecto, un acto de construcción, como el aparato llamado Pase, una invención lacaniana “donde el acto podría ser aprehendido en el momento en que se produce” (Lacan, 1967). El funcionamiento de una Escuela considera la verdad del saber erróneo y lo intransmisible en juego en la experiencia analítica. El pasador, “debutante en la posición del analista” (Lacan, 1975), por estar en un momento específico de su “*caminhadura*”⁴⁵, solo, escucha. Con su ser en juego, frente a la reinención de un psicoanálisis al que asiste, cuenta al cartel la cuenta de la operación lógica de la experiencia analítica que escuchó.

Pasar por el dispositivo de pase no está exento de consecuencias, para mí inicialmente fue la instalación de un tiempo de angustia, sin otra opción que hacer un esfuerzo extra. Como analizante, un esfuerzo por jugar con las palabras, por re-coger y re-tomar una vez más fragmentos de análisis, restos, saber perforado de un solo de escuela (un-solo “d'escola”- de escuela). En un momento dado tuve un sueño: estaba en un avión (sin alas), con colegas de la escuela, en un vuelo un tanto extraño entramos en una cordillera cuyo piso era de ladrillos perforados, momento en el que el techo cedió. Del lado del analista, concesión del su lugar, y la apuesta a la Escuela como

⁴⁵Neologismo creado por el cantante y compositor brasileño Gilberto Gil, en la canción que llamó “Drão”. El término hace referencia a la dureza de la vida, pero también puede considerarse una metáfora del esfuerzo por mantener relaciones amorosas ante el descubrimiento de que las relaciones sexuales no existen. Así, el sonido de la palabra se desdobra en “caminha” (cama pequeña, y dura). La palabra dura puede referirse al verbo durar, en relación a la duración de algo, o a la dureza misma, que alude a problemas, dificultades. Aquí el uso del neologismo en relación con el momento del pasador se correlaciona con lo que Lacan trabaja como de-ser.

espacio que valora “que cada analista reinvente el modo en que el psicoanálisis puede perdurar” (Lacan, 1978).

Referencias

- Lacan, J. Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela. En. Otros escritos. Londres: Oxford University Press. 2003.
- Lacan, J. (1967). Discurso en la Escuela Freudiana de París. En. Otros escritos. Londres: Oxford University Press. 2003.
- Lacan, J. (1969). El acto psicoanalítico: resumen del seminario 1967-1968. En. Otros escritos. Londres: Oxford University Press. 2003.
- Lacan, J. (1972-1973) El Seminario, Libro 20, Más, todavía. Nueva York: Oxford University Press, 1985.
- Lacan, J. (1973). Nota italiana. En. Otros escritos. Londres: Oxford University Press. 2003.
- Lacan, J. (1975). Conferencia en Ginebra sobre el síntoma. In Lacan, J. Intervenciones y Textos 2. Buenos Aires: Manantial (1991).
- Lacan, J. (1978). Clausura del 9º Congreso de la Escuela Freudiana de París, un hecho sin precedentes.
- Bousseyroux, Michel. (2006). Posición de Lacan respecto a la designación y funciones del pasador, Wunsch 4.
- Soler, Colette Soler (2012). El pasador, Wunsch 12.

“¿Sin tomar en cuenta procedencias ni calificaciones? La enrevesada pregunta por la designación del pasador”

Dyhalma N. Ávila-López

Psicóloga clínica y psicoanalista con práctica privada en San Juan. Es miembro del Foro Psicoanalítico de Puerto Rico, del que ha sido Delegada en dos ocasiones y de cuyo Colegio Clínico es enseñante. Miembro de la Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano desde 2008 y Analista Miembro de la Escuela (AME) desde 2020. Ha sido miembro del Colegio de Representantes de la Internacional de los Foros (CRIF) por la Zona América Latina Norte, miembro de la Comisión Local Epistémica y de Acogida (CLEA) de la Zona, y es la actual Representante de la Zona al Colegio Internacional de la Garantía (CIG)

Con esta breve exposición, intentaré darle una nueva vuelta a la pregunta en torno a la que ha girado mi principal inquietud desde que recibí el título de A.M.E.: la responsabilidad que implica la designación de pasadores. En general, dicha inquietud concierne, como es de esperar, a la responsabilidad relativa al funcionamiento del dispositivo del pase. Pero a ésta se le añade, al menos en mi caso, el asunto de la responsabilidad con respecto al pasador, específicamente, cuando el analizante en cuestión no tiene un vínculo directo con nuestra comunidad de los Foros, y mucho menos con nuestra Escuela.

Retomo la pregunta cerca de donde la dejé el año pasado, cuando la abordé durante un Espacio Escuela de la Zona ALN sobre la función del A.M.E. en tanto “garantía de la Escuela”. Desde entonces, diversas experiencias –por ejemplo, el trabajo en un cartel del CAO y debates sostenidos al interior del actual CIG– me han permitido constatar que se trata de un asunto tan insistente como enrevesado.

Mi inquietud responde a una situación muy concreta. Luego de cinco años como A.M.E., finalmente cuento con analizantes que entiendo podrían estar en ese punto de su análisis en que se les pudiera designar como pasadores. Sin embargo, aunque participan de algunas actividades de nuestro Foro y del Colegio Clínico, ninguno pertenece a la IF. Por consiguiente, aún no están familiarizados con los temas de Escuela y, mucho menos, con los pormenores del dispositivo del pase y la función del pasador; o sea, aquello en lo que se estarían involucrando y asumiendo.

El único colega A.M.E. de quien recuerdo una declaración contundente, que apunta a ese caso particular, es Luis Izcovich. En un seminario de nuestro Colegio Clínico, hace algunos meses, éste planteaba que –si bien no puede haber “doxa” de lo que se considera un “pasador modelo”,

siendo preciso tolerar la disparidad de criterios al designarlos— el que, por estar en el umbral de advenir al *deseo del analista*, un pasador logre reconocer en el pasante la marca de ese deseo, requiere una transferencia con la Escuela. No parece haber muchos que compartan esta posición.

En los intercambios con otros A.M.E. acerca de ese punto, siempre se comenta de inicio, naturalmente, el hecho de que ser miembro de un Foro no es un requisito para la designación como pasador. Se destaca además que, del mismo modo en que pertenecer a la IF —sobra decir—no garantiza que un pasador lleve a cabo satisfactoriamente la transmisión del testimonio que escuchó de un pasante, su no pertenencia no tendría por qué ser un impedimento para lograrlo. También se suele hacer alusión a pasadores no afiliados a la IF, cuya transmisión ha resultado en la nominación de algún A.E. Aunque todo esto me queda muy claro, por así decirlo, "en teoría", lo cierto es que, "en la práctica", se me continúa planteando como un interrogante.

La Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela establece que, a la Escuela, “sólo se es admitido en la base, en el marco de un proyecto de trabajo y sin tomar en cuenta procedencias ni calificaciones”.⁴⁶ Se me ocurrió que, aludiendo a las palabras de Lacan, podría formular el interrogante que me interpela así: la designación de pasadores ¿es algo que, en términos de la relación de éstos con el psicoanálisis, se haría también “sin tomar en cuenta procedencias ni calificaciones”?

Formularlo de esta forma me permitió vislumbrar una vertiente adicional para pensar la pregunta que me concierne; y fue, precisamente, el hecho de que dicha pregunta “me concierne” en una doble acepción, lo que pude comenzar a atisbar. Entiéndase: cuánto de lo propio podría estar implicado de manera encubierta; cómo esa cuestión de las procedencias y las calificaciones, que, en apariencia, se refiere exclusivamente al analizante con posibilidad de resultar designado, le puede “rebotar” al analista que asuma la responsabilidad de designarlo.

Este nuevo giro resonó con la propuesta realizada hace poco por un compañero de cartel: que, tal como es preciso “autorizarse a sí mismo” a partir del surgimiento del *deseo del analista*, habría también que autorizarse como designador de pasadores, a partir de lo que podría llamarse “deseo del A.M.E.” Esa afirmación resonó, a su vez, con lo que recordé de mi primera exposición como A.M.E. Tras aludir, aunque de modo más general, justamente al tema de la responsabilidad

⁴⁶ *Otros escritos*, p. 262.

que vengo destacando, advertía allí que, aún a varios años de sentirme autorizada como analista, me encontraba muy lejos de pensarme “a la altura” del título recibido.

En retrospectiva, siguiendo la premisa del colega, podría decir que, para aquel entonces, había transcurrido el tiempo suficiente para la autorización como analista, pero, evidentemente, no como A.M.E. –un título cuya iniciativa, cabe recordar, le corresponde a la Escuela. Asimismo, podría decir que, al presente, habiendo pasado unos años desde el no considerarme “a la altura”, ese ya no es –tanto– el caso con respecto a la responsabilidad que supone la función epistémica.

En cuanto a la responsabilidad relativa a la función de designar pasadores, sin embargo, entiendo que haría falta todavía un tiempo adicional: el de trabajar un poco más con la pregunta por las “procedencias y calificaciones” con relación a la Escuela y sus dispositivos; pregunta que, al parecer, no solo remitía a aquellas del posible pasador. Ese tiempo requerirá, en consecuencia, abordar la pregunta desde otra posición, que también tome en cuenta, y ponga en perspectiva, los fantasmas que tal vez siguen operando, acerca de las propias “calificaciones” para designar.

Al menos de momento, para esta A.M.E., ese parece ser un paso previo a la autorización como “designadora” –vocablo que, curiosamente, la Real Academia Española no ha autorizado, dato que abona a la idea de que no hay otra vía que “autorizarse por sí mismo”. Ese paso previo, el de continuar trabajando con la pregunta desde una posición diferente, requerirá, sobre todo, poder asumir “en la práctica” algo que es mucho más fácil de admitir “en teoría”: que la “garantía de la Escuela”, que supone el título de A.M.E., nunca podrá implicar una garantía en términos del fruto que rendirán las funciones; ni las del pasador, ni las del designador. Y no podría implicarla, por más que se trate de ejercer las funciones con el mayor grado de responsabilidad, y se intente “estar a la altura”. Pues quizá la altura a la que realmente habría que estar –se me ocurre ahora–no tendría tanto que ver con el fruto a recoger sino con el acto de atreverse a sembrar.

“Psicoanálisis y el pase: ¿qué hay de nuevo?”

Andrea Fernandes

Psicoanalista, AME de la EPFCL, miembro del Foro de Salvador de la EPFCL-Brasil, Doctor en Psicopatología Fundamental y Psicoanálisis (París 8), Prof. Profesor Jubilado del Instituto de Psicología de la UFBA/Brasil. Participó del CIG (2019-2020) . .

Mi participación en el CIG, 2019-2020) y en el CRIF 2021-2022 incentivó la construcción de este texto. El trabajo en estas dos instancias de la Escuela me reveló que el dispositivo del pase contempla la afirmación de Lacan de que “el analista es al menos dos: el que provoca el trabajo analizante y el que teoriza sus efectos”⁴⁷. Me propongo entonces examinar en qué medida el pase sería propicio para “que cada analista reinvente el modo en que el psicoanálisis puede perdurar”⁴⁸ problematizando cuestiones cruciales del psicoanálisis desde la perspectiva clínica y lo que emerge desde la perspectiva clínica en el pase.

La Escuela, a través del pase, pretende garantizar “que un analista dependa de su formación continua”⁴⁹. Hay un vector desde los foros a la Escuela. Si los Foros ofrecen formación continua, es la Escuela la encargada de garantizarla. Respecto a la cuestión de la garantía, el trabajo en las diferentes funciones de la Escuela exige que el analista se convierta en “responsable de la marcha de la Escuela”, convirtiéndose en “psicoanalista de su propia experiencia”⁵⁰.

En el dispositivo de pases interviene la comunidad de la Escuela, desde los participantes, miembros del foro y miembros de la Escuela, así como los AMEs y AEs, en las diferentes funciones del dispositivo: secretaría de pases, pasante, pasador y cartel de pases. En la experiencia del pase, cada analista, en su formación permanente, es llevado a problematizar el acto que está “al alcance de cada ingreso al psicoanálisis”⁵¹ a partir de lo que cada uno “logró llevarse del hecho

⁴⁷ Lacan, J. *O Seminário – livro 22: RSI* (1974-1975), lição de 10 de dezembro de 1974, inédito.

⁴⁸ Lacan, J. “La transmission” (1978) – *9º Congrès d’École Freudienne de Paris*, 9 de juillet 1978. Paris: Lettres de l’École, 1979, n° 25, vol. II, pp 219-220. Acesso pelo site: <http://aejcpp.free.fr/lacan/1978-07-09.htm> (Tradução da autora), p. 2.

⁴⁹ Lacan, J. “Proposição de 9 de outubro de 1967” in: *Outros Escritos*. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 248.

⁵⁰ *Id. Ibidem*.

⁵¹ Lacan, J. “O ato psicanalítico – Resumo do Seminário de 1967-1968 n: *Outros Escritos*. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 371

de haber sido psicoanalista durante un tiempo”⁵², de conducir análisis y/o de estar en análisis. Existe entonces una conjunción entre el clínico y el analista que se expresa bien en la frase de Lacan: “El analista se hace a partir del objeto *a*. Se hace, es decir: se hace producir; del objeto *a*: con el objeto *a*”⁵³.

En muchas jornadas de la Escuela, en nuestros Encuentros Internacionales y Nacionales, los implicados en el pase suelen revisitar los ecos de esta experiencia el dispositivo. Hemos denominado estos espacios como Jornadas de la Escuela, pero incluso fuera de este espacio, en las presentaciones y escritos, los analistas elaboran lo que hacen cuando operan como analistas y, al mismo tiempo, validan su pasaje “a su praxis de la teoría”⁵⁴.

Este tema fomentó el debate en la Escuela sobre la función no vitalicia del AME. En la discusión, uno de los propósitos sería incentivar a los AME a profundizar en lo que hacen como clínicos y lo que teorizan a partir de ahí y, así, podrían colaborar con el progreso del psicoanálisis en la comunidad de la Escuela. Esto sería una forma de dejar claro que “el analista se autoriza a sí mismo”⁵⁵ y necesita validar esta autorización ante sus pares.

En cuanto al Analista de la Escuela (AE), ¿qué pueden esperar el dispositivo de pase y la comunidad de la Escuela?

Lacan esperaba que con el pase, la Escuela, pudiera disipar la espesa sombra que cubre el cruce “en la que el psicoanalizante se convierte en psicoanalista”⁵⁶. Del Analista de la Escuela, Lacan esperaba que en esta función, ahora ejercida en tres años, el AE podría elaborar, en particular, la dimensión del síntoma como incurable. El énfasis se debe a que es la base de lo que hace el analista al realizar los análisis: a través del acto, a través de la interpretación, a través del deseo del analista.

La sombra espesa se articula con el par ordenado S_1S_2 de la lengua como significante que marca el cuerpo del ser hablante, todavía *infans*. El sinsentido del síntoma parte de este punto de real y es siempre singular y promueve la libre asociación, las elucubraciones en el análisis. El

⁵²

⁵³ Lacan, J. “O ato psicanalítico – resumo do Seminário de 1967-1968” in: *Op. cit.*, p. 375.

⁵⁴ Fingermann, D. *A (de)formação do psicanalista*. São Paulo: Escuta, 2016, p. 75.

⁵⁵ Lacan, J. “Nota italiana” in: *Outros Escritos*. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 311.

⁵⁶ Lacan, J. “Proposição de 9 de outubro de 1967” in: *Op. Cit.*, p. 258.

analista acepta el supuesto de saber que el síntoma, como manifestación del inconsciente, crea un enigma y, actuando como un objeto *a*, “no se subjetiva ni se comprende”⁵⁷, sino que responde con la función del objeto causa del deseo.

“El objeto *a* es un efecto del discurso analítico”⁵⁸. Y, “no habría discurso analítico ni revelación de la función del objeto *a*, si el analista no fuera el efecto... el síntoma...que implica la transformación de la relación del saber, como determinante de la posición del sujeto, con el fondo enigmático del goce”⁵⁹. Hay un saber del lalengua propio del goce del ser vivo que es intransmisible. Por los malentendidos del lalengua, en un análisis, el hablante puede tocar el límite de la suposición de sentido y lo real como imposible, de donde resuena el Hay Uno sin Otro. Esto promueve resonancias em non ia rapport sexuales. El acto psicoanalítico es suposto em el passagem de psicoanalizante a psicoanalista.

El pase da la recibe a quienes creen que han dado este paso. El cartel de pases, con base en el reporte de los pasadores, puede decidir designar al passante como AE. Esta designación, por parte del cartel de pase, así como la función del AE, es de suma importancia porque ofrece a la Escuela y a el AE la oportunidad de velar por que esto no caiga en el olvido, ya que aquí está en juego el tratamiento de lo real en juego en la formación del analista. Esa es, para mí, la apuesta de lo que hay de nuevo en el pase.

⁵⁷ Fingermann, D. “A política do sintoma na direção da cura” in: *Stylus*, nº 22. Rio de Janeiro: EPFCL-Brasil, maio 2011, p. 93.

⁵⁸ Lacan, J. *O Seminário – livro 16: De um Outro ao outro* (1968-1969). Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 45.

⁵⁹ *Idem. Ibidem.*

“El momento de la designación de un pasador”

Fernando Martínez

Lic. en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Psicoanalista. AME de la EPFCL. Miembro fundador del Foro Patagónico. Miembro del Foro Argentino del Campo Lacaniano - Polo Patagonia. Coordinador actual del Colegio Clínico de la Patagonia. Enseñante en el Colegio Clínico de la Patagonia y en diversos espacios de las Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano. Coautor del libro "Cauces del goce" publicado por Escabel Ediciones.

¿Pruebas de serlo?

En la Proposición del 9 de octubre de 1967, Lacan señala que el título de AME se constituye por el *simple hecho de que la Escuela lo reconoce como psicoanalista que ha dado pruebas de serlo*⁶⁰. Debo confesar que siempre me resultó enigmática esta frase: ¿cuáles son esas pruebas que bastan para otorgar ese título?

Es una pregunta que nos hemos hecho junto a los colegas que integramos la CAI, comisión ad hoc del CIG encargada de recibir las propuestas de candidatos a AME. Nuestro trabajo consistió en revisar la participación en la Escuela, la actividad en su zona, el compromiso con el sostenimiento institucional, los aportes epistémicos, etc., todo debidamente justificado por quienes los postulan.

Sin embargo, hay una función específica del AME que articula la política de transmisión de la Escuela con su práctica clínica: la designación de pasadores. ¿Cómo se acredita esa capacidad para situar el momento de pase en un analizante? La respuesta sigue siendo enigmática y, en general, se resuelve con la confianza depositada en el candidato. Sólo dejo planteada la cuestión, porque no creo que sea una pregunta que se agote ni que pueda responderse de manera unívoca. Me aventuro a señalar algunas cuestiones que podrían acercar alguna respuesta de manera tangencial.

La responsabilidad que le cabe al AME en la apuesta que realiza con la designación del pasador lo excede, en tanto que se *somete, él mismo, de manera indirecta al control de su acto...por otros, por el colectivo de la Escuela*.⁶¹ Se trata de una apuesta sin garantías, que reabre el interrogante

⁶⁰ Lacan, J. Proposición del 9 de octubre de 1967. Pag. 262- Otros Escritos. Paidós Buenos Aires. 2012

⁶¹ Rithée Cevasco. Dos contribuciones en la tarde sobre el pasador, de l'EPFCL-Francia, 1ero de abril 2006. En Wunsch N° 4. Publicación on line de la EPFCL

sobre su propia clínica en un momento que no elige él, sino que se impone por la temporalidad del Sujeto Supuesto Saber. Sólo a posteriori podrá saberse si ese acto fue tal.

Es, entonces, una apuesta riesgosa, no sólo para el AME que designa —basándose en las coordenadas clínicas del caso—, sino también para el pasador que asumirá o no esa función y además para el pasante en el pedido de pase a la Escuela. Una apuesta *múltiple* alrededor de lo **tíquico** que se pone en juego, apertura a una experiencia de transmisión que excede cualquier buena o mala intención. De ahí que el dispositivo del pase sea especialmente sensible a la intencionalidad, y pueda verse afectado por manipulaciones sostenidas en el sentido que pueda generar cualquiera de sus actores, incluidos los carteles del pase.

El pasador es el pase

«Por ello, mi proposición se interesa en el pase cuando el acto podría ser captado en el tiempo mismo en que se produce», dice Lacan en su Proposición, suponiendo que los AME pueden discernir ese instante. El momento de la designación, entonces, se vuelve una bisagra en el dispositivo analítico, en tanto articula y pone a prueba, en el seno de la Escuela, el acto analítico mismo. Acto que compromete al futuro pasador —por estar aún atravesado por ese momento—, y también al analista, que somete su función a la prueba de la designación, anudando intensión y extensión; pasando de la intimidad del análisis a la extimidad de la Escuela. Así aporta la pieza clave del dispositivo del pase: el pasador, que —según Lacan— **es** el pase, por hallarse él mismo en ese momento.

Desde mi experiencia, este momento clínico convoca al analista a designar porque el pasador se halla en pleno despliegue del des-anudamiento de su experiencia analítica. Ese trayecto no se sitúa fuera del tiempo, sino en un intervalo preciso donde ya se ha entrevisto la díada fundamental que articula la falta-de-ser —la castración— con el objeto del fantasma. Pero donde, sin embargo, la operación de reducción transferencial aún no se ha consumado.⁶²

Es un tiempo de vacilación y pasaje, donde el **deser** del analista comienza a vislumbrarse, anunciando el duelo inevitable por ese Otro que deja de consistir. No es casual que Lacan haya

⁶² Cevasco, Rithée. Ibidem.

calificado los afectos de este momento como teñidos por un sesgo maníaco-depresivo: una oscilación subjetiva entre el empuje hacia una salida y la angustia ante la pérdida.

Este intervalo se ubica entre el *impasse* que la transferencia instituye —ese callejón sin salida donde la verdad deja de sostenerse como causa— y la posibilidad, aún incierta, de un pase. Un momento liminar para el analizante, entonces, de caída de la verdad mentirosa, donde se juegan el deseo, el saber y el acto.

Una apuesta que, desde el interior del dispositivo analítico, contribuye a ese invento de Lacan que es el dispositivo del pase, para experimentar que la verdad está irremediablemente ficcionada y que el saber sólo puede *pasar en acto*. Al modo de una tragicomedia de enredos, esta apuesta relanza a la comunidad de la Escuela a la gran búsqueda: **¿y dónde está el analista?!**⁶³

⁶³ En referencia al film del absurdo: *Airplane!* De 1980, dirigida por Jim Abrahams, David y Jerry Zucker, con el protagonista de Leslie Nielsen. En [Francia](#) se tituló *Y a-t-il un pilote dans l'avion?* (¿Hay algún piloto en el avión?), en [Hispanoamérica](#): *Y, ¿dónde está el piloto?*, y en [portugués](#) (para su estreno en [Brasil](#)) se tituló *Apertem os cintos, o piloto sumiu* (Abróchense los cinturones, el piloto se ha ido)

